

2026

COMGES

Ministerio de Salud



ORIENTACIONES TÉCNICAS COMPROMISOS DE GESTIÓN

Subsecretaría de Redes Asistenciales
Departamento de Control de Gestión

Versión 1.1 junio 2026

Ministerio de Salud



Indicadores Compromisos de Gestión 2026

Versión 1.1 junio 2026

Índice

1. Contexto de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)	3
2. Principales Características de las RISS:.....	3
3. Dominios y Atributos esenciales de las RISS	4
4. Propuesta Metodológica para evaluar los COMGES 2026.....	7
I. Introducción.....	7
II. Estructura de los Compromisos de Gestión 2026	8
III. Compromisos de Gestión para el año 2026	9
IV. Ponderación de los Compromisos de Gestión y sus indicadores.....	10
V. Metodología de evaluación.....	11
VI. Tablas de sensibilidad y asignación de puntajes	13
VII. Sobre los indicadores de evaluación	14
5. Marco conceptual e indicadores que componen cada COMGES	19
Compromiso de Gestión N°1: Eficiencia en la gestión de procesos asistenciales, calidad y seguridad del paciente.	19
Compromiso de Gestión N°2: Estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento en la Red Asistencial.....	31
Compromiso de Gestión N°3: Gestión de los tiempos de espera.	38
Compromiso de Gestión N°4: Gestión de Riesgos, Recursos Humanos y financieros.	59
Compromiso de Gestión N°5: Prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer.	70
Compromiso de Gestión N°6: Sistemas de información y Salud Digital.	83
6. Indicadores de Monitoreo Obligatorio.....	94
7. Nivel de aplicación	141

1. Contexto de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)

Las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) corresponden a una estrategia organizacional orientada a garantizar una atención de salud accesible, continua, integral, coordinada y centrada en las personas, familias y comunidades. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2025)¹ las define como una red de organizaciones que presta o coordina la prestación de servicios de salud equitativos e integrales para una población definida, asumiendo responsabilidad por los resultados sanitarios, la experiencia de las personas usuarias y el uso eficiente de los recursos disponibles.

Este modelo surge como respuesta a los desafíos asociados a la fragmentación de los sistemas de salud, caracterizados por dificultades en la coordinación entre niveles asistenciales, discontinuidad de los cuidados, inequidades en el acceso y variabilidad en la calidad de las prestaciones. En este contexto, las RISS promueven una organización basada en las necesidades de salud de la población, fortaleciendo la capacidad resolutoria del primer nivel de atención y articulando de manera efectiva los distintos dispositivos de la red asistencial.

La actualización del Marco conceptual de las RISS impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2025) releva la importancia de avanzar hacia sistemas sanitarios que integren la gestión clínica, la gestión poblacional y la gestión territorial, fortaleciendo la continuidad de los cuidados a lo largo del curso de vida. Este enfoque reconoce que los resultados sanitarios dependen no sólo de la producción de prestaciones, sino también de la capacidad de la red para coordinar intervenciones oportunas, responder a las necesidades diferenciadas de las personas y reducir brechas de acceso e inequidades en salud.

En Chile, el Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales impulsa la consolidación progresiva de este modelo a través de diversos instrumentos de gestión, entre ellos los Compromisos de Gestión (COMGES), los cuales constituyen una herramienta estratégica para orientar, monitorear y evaluar el desempeño de los Servicios de Salud. Desde esta perspectiva, los COMGES contribuyen al fortalecimiento de las Redes Asistenciales mediante el seguimiento de objetivos prioritarios asociados a la calidad, oportunidad, eficiencia, integración de servicios y resultados sanitarios.

2. Principales Características de las RISS:

Las Redes Integradas de Servicios de Salud se caracterizan por organizar la provisión de servicios en torno a las necesidades de las personas y comunidades, promoviendo la coordinación efectiva entre los distintos niveles asistenciales y garantizando la continuidad del cuidado a lo largo del ciclo vital.

Entre sus principales características destacan:

- Atención centrada en las personas, familias y comunidades, considerando sus necesidades, preferencias, contexto sociocultural y condiciones territoriales.

¹ Organización Panamericana de la Salud. (2025). Redes integradas de servicios de salud: Actualización del marco conceptual y operacional para la Región de las Américas. OPS. <https://doi.org/10.37774/9789275330500>

- Gestión poblacional y territorial, orientada a identificar riesgos, necesidades sanitarias y brechas de acceso de grupos específicos de población, permitiendo planificar intervenciones oportunas y pertinentes.
- Continuidad de la atención y del cuidado, mediante mecanismos de coordinación clínica y administrativa que faciliten el tránsito de las personas entre los distintos dispositivos de la red.
- Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud como eje articulador del sistema y puerta preferente de acceso a los servicios sanitarios.
- Acceso equitativo y oportuno a prestaciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
- Gestión integrada de recursos, procesos e información, favoreciendo una utilización eficiente y sostenible de las capacidades instaladas de la red.
- Participación social efectiva, incorporando la experiencia, expectativas y necesidades de las personas usuarias y comunidades en los procesos de planificación, implementación y evaluación.
- Interoperabilidad y transformación digital, mediante sistemas de información que faciliten la integración clínica, el intercambio seguro de datos y la toma de decisiones basada en evidencia.
- Orientación a resultados sanitarios, experiencia usuaria y generación de valor en salud, promoviendo mejoras sostenidas en la calidad y efectividad de las intervenciones.

3. Dominios y Atributos esenciales de las RISS

Las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) se sustentan en un conjunto de dominios y atributos que orientan la organización, gestión y evaluación de las Redes Asistenciales. Estos dominios representan las capacidades estructurales y funcionales necesarias para avanzar hacia sistemas de salud más integrados, equitativos, resilientes y centrados en las personas, permitiendo responder de manera efectiva a las necesidades de salud de la población y a los desafíos sanitarios actuales.

La consolidación de las Redes Asistenciales requiere el desarrollo articulado de estos dominios, promoviendo la coordinación entre establecimientos y niveles de atención, la continuidad de los cuidados, la participación social y la generación de resultados sanitarios con enfoque territorial.

3.1. Organización de la atención y cuidado con enfoque territorial

Este dominio comprende los atributos relacionados con la organización de los servicios de salud en función de las necesidades de la población, la continuidad de la atención y la articulación de los distintos dispositivos que conforman la red.

Atributos

- Población y territorio definidos, con conocimiento actualizado de las necesidades, riesgos y prioridades sanitarias de las personas, familias y comunidades.
- Cuidado y organización de los servicios basada en las personas, la familia y la comunidad y sus necesidades de salud a través de curso de vida, considerando los enfoques de derechos, género, interculturalidad y determinantes sociales de la salud.
- Red de servicios integrada y coordinada que garantice acceso oportuno a acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
- Oferta de servicios con calidad y capacidad resolutoria con servicios orientados en el nivel más apropiado de complejidad, favoreciendo la resolutoria territorial y comunitaria. Gestión de la atención basada en riesgos, necesidades y resultados sanitarios.

3.2. Gestión Integrada de recursos, transformación digital y procesos estratégicos

Este dominio reúne los atributos vinculados con la capacidad de gestión de las Redes Asistenciales, el uso eficiente de los recursos disponibles, la transformación digital y el fortalecimiento de los procesos estratégicos para la toma de decisiones.

Atributos

- Infraestructura y equipamiento adecuados a las necesidades de salud. Planificación estratégica basada en evidencia, necesidades poblacionales y prioridades sanitarias. Gestión integrada de recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y logísticos.
- Gestión de recursos humanos para la salud. Gestión del desempeño orientada a resultados, calidad asistencial, eficiencia y mejora continua. Desarrollo de capacidades analíticas para el monitoreo, evaluación y gestión basada en evidencia. Gestión del conocimiento, innovación y aprendizaje organizacional como elementos de fortalecimiento institucional.
- Gestión de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Disponibilidad y uso oportuno de información para la gestión sanitaria y la toma de decisiones.
- Gestión de servicios de apoyo administrativo y logístico. Protección de datos personales, ciberseguridad y resguardo de la información sanitaria.
- Transformación digital del sector de la salud. Sistemas de información interoperables que faciliten la integración clínica y administrativa de la red. Transformación digital orientada a fortalecer el acceso, la oportunidad, la continuidad del cuidado y la experiencia usuaria.

3.3. Gobernanza, participación social y acción intersectorial

Este dominio considera los mecanismos de conducción estratégica, liderazgo, coordinación institucional y participación de los distintos actores involucrados en la gestión y desarrollo de las Redes Asistenciales.

Atributos

- **Gobernanza RISS.** Liderazgo y gobernanza orientados al logro de objetivos sanitarios comunes y compartidos en toda la red. Rendición de cuentas y transparencia en la gestión sanitaria.
- **Gestión territorial de las RISS.** Coordinación efectiva entre los distintos niveles de atención, establecimientos y actores del sistema de salud. Vinculación permanente con las comunidades y organizaciones sociales de los territorios.
- **Participación social efectiva.** Participación social incidente en los procesos de planificación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y servicios de salud.
- **Gestión basada en resultados.** Desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones y sectores relacionados con los determinantes sociales de la salud.
- Monitoreo y sistemas de información para la salud
- **Gestión de cambio.** Acción intersectorial para abordar de manera integral las necesidades y problemáticas que afectan la salud y el bienestar de la población. Promoción de la corresponsabilidad entre instituciones, comunidades y personas en el cuidado de la salud.

3.4. Financiamiento suficiente y sostenible

Este dominio agrupa los atributos relacionados con la disponibilidad, asignación y utilización de los recursos financieros necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo e integrado de las Redes Asistenciales

Atributos

- Suficiencia e integración del financiamiento, para responder a las necesidades sanitarias de la población y asegurar la continuidad de las prestaciones. Mecanismos de financiamiento que favorezcan la integración de servicios y la coordinación de la atención.
- Asignación de recursos y sistema de pago, basada en criterios de equidad, necesidades de salud y características territoriales. Uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos. Incentivos alineados con la calidad de la atención, la continuidad del cuidado, la integración asistencial y los resultados sanitarios.
- Inversión para el desarrollo de las RISS. Sostenibilidad financiera de las Redes Asistenciales en el mediano y largo plazo.
- Evaluación permanente del desempeño financiero y del valor generado para las personas, comunidades y el sistema de salud.

Los dominios y atributos descritos constituyen el marco conceptual que orienta la formulación, implementación y evaluación de los Compromisos de Gestión (COMGES 2026), permitiendo fortalecer progresivamente la integración de las Redes Asistenciales, mejorar la experiencia de las personas usuarias y contribuir al logro de mejores resultados sanitarios para la población.

4. Propuesta Metodológica para evaluar los COMGES 2026

Compromisos de Gestión año 2026

Los Compromisos de Gestión (COMGES) definidos para el año 2026, abordan ámbitos o líneas prioritarias para el fortalecimiento de las Redes Asistenciales en camino a la propuesta de las RISS 2025. Cada compromiso se articula en torno a un dominio, conformado por distintas áreas temáticas alineadas con sus principales características y atributos propuestos por las RISS, y que, en virtud de ello, tiene como objetivo medir el grado de avance e integración de cada uno, los cuales son evaluados a través de indicadores específicos. Estos indicadores permiten objetivar y estandarizar el cumplimiento de los objetivos definidos para cada indicador, en coherencia con las prioridades en salud y los atributos dispuestos para ello.

Bajo el compromiso de fortalecer la cohesión de los dominios y atributos en los Servicios de Salud y sus Redes Asistenciales, la articulación para la gestión y la instalación de procesos estratégicos, se han incorporado en algunos indicadores con requisitos específicos, en complemento a la evaluación de cada uno de los procesos asociados a los COMGES. Estos requisitos pueden consistir en informes centrados en grupos poblacionales específicos, el cumplimiento de actividades dentro de un plan, el monitoreo de indicadores complementarios u otros mecanismos de seguimiento, fortaleciendo así el proceso de evaluación y análisis estratégico de los compromisos.

I. Introducción

Los COMGES para el año 2026 representan una herramienta estratégica para la Subsecretaría de Redes Asistenciales, proceso además clave para sostener las RISS y orientar, monitorear y evaluar a través de ellos, el desempeño de los Servicios de Salud del país, en función de prioridades sanitarias nacionales. Estos compromisos se estructuran en torno a seis líneas estratégicas, cada una de las cuales aborda áreas claves para el fortalecimiento de las Redes Asistenciales, con un enfoque basado en la calidad, eficiencia, oportunidad y equidad, centrado en las personas.

Cada COMGES incorpora un conjunto de indicadores específicos, cuya función es medir el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos para tales efectos. Estos indicadores poseen una ponderación relativa al compromiso, lo que facilita estimar su contribución dentro de la evaluación global del COMGES. En algunos indicadores, se consideran requisitos asociados, los que complementan y enriquecen la evaluación, otorgando un enfoque más integral.

Este enfoque permite que cada Servicio de Salud oriente sus esfuerzos hacia la mejora continua, de manera equitativa y focalizada en resultados sanitarios concretos. La implementación de los COMGES 2026 constituye un avance significativo en la consolidación de RISS, más resolutivas, robustas, humanas y centradas en las personas.

Los COMGES deberán evolucionar progresivamente desde indicadores centrados en procesos y producción hacia indicadores de resultados sanitarios, experiencia usuaria, continuidad del cuidado y reducción de inequidades.

II. Estructura de los Compromisos de Gestión 2026

La estructura de los Compromisos de Gestión (COMGES) para el año 2026 responde a una metodología que permite alinear los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud con el desempeño de los Servicios de Salud y la consolidación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). Cada compromiso se compone de elementos que orientan, operacionalizan y estandarizan la medición de resultados, garantizando consistencia técnica y comparabilidad a nivel nacional.

A continuación, se detallan los componentes que conforman la estructura evaluativa de los COMGES:

1. Nombre del Compromiso de Gestión:

Corresponde a la denominación del compromiso, que agrupa las líneas estratégicas priorizadas para los Servicios de Salud a nivel nacional. Su finalidad es orientar la gestión hacia la mejora continua de la calidad, oportunidad y eficiencia en la atención de salud.

2. Objetivo estratégico del Compromiso de Gestión:

Define el propósito sanitario que se busca alcanzar mediante la implementación del compromiso, contribuyendo a mejorar el estado de salud de la población a través de intervenciones focalizadas, la eficiente gestión de los procesos y evidencia objetivable.

3. Componentes de evaluación del Compromiso de Gestión:

Cada Compromiso de Gestión se estructura a partir de indicadores y, en algunos casos, requisitos complementarios, los cuales permiten añadir una forma objetiva de evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. De acuerdo con lo señalado, es necesario precisar lo siguiente:

- I. **Indicador:** Es una medida cuantificable, observable y medible que permite describir o evaluar un proceso o fenómeno social, sanitario o institucional. Para los efectos del COMGES, funcionan como herramientas de medición que permiten evaluar el desempeño del Servicio de Salud en relación con el objetivo del compromiso. Pueden ser de resultado o de proceso, y están asociados a una fórmula, una fuente y una meta específica, la cual puede definirse en función de la mejora respecto a la línea base del año anterior o mediante una meta nacional de acuerdo con un estándar.
- II. **Requisito:** es toda información, condición técnica, metodología específica o evidencia complementaria que debe cumplirse para que un indicador sea correctamente interpretado y útil para la toma de decisiones. Su propósito es robustecer el proceso evaluativo y asegurar la calidad del dato.

El no cumplimiento implica una penalización equivalente a -1 punto respecto del puntaje obtenido en el indicador principal, manteniendo igualmente la evaluación cuantitativa del indicador.

Figura 1: Diagrama de la estructura COMGES 2026



Además de los indicadores y requisitos que integran los componentes de evaluación de los COMGES, antes mencionados, se establecerán de forma transversal indicadores para monitoreo, de reporte obligatorio; esto quiere decir que, se deben reportar en la fecha acordada y ante incumplimientos en el envío de información se inhabilitará al Servicio de Salud para ser evaluado en su desempeño institucional del COMGES.

En resumen: la evaluación consta del COMGES (evaluación) más indicadores de monitoreo (reporte).

III. Compromisos de Gestión para el año 2026

Los Compromisos de Gestión (COMGES) definidos para el año 2026 consolidan un marco estratégico orientado a fortalecer el desempeño de los Servicios de Salud y avanzar en la consolidación de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) resolutivas, oportunas, eficientes y centradas en las personas. Cada compromiso aborda dimensiones clave del quehacer sanitario, articulando indicadores y requisitos que permiten evaluar de forma estandarizada el progreso institucional en áreas prioritarias para la autoridad sanitaria.

Los seis compromisos establecidos para el periodo se describen a continuación:

- COMGES 1: Eficiencia en la gestión de procesos asistenciales, calidad y seguridad del paciente.
- COMGES 2: Estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento.
- COMGES 3: Gestión de los tiempos de espera.
- COMGES 4: Gestión de Riesgos, Recursos Humanos y financieros.
- COMGES 5: Prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer
- COMGES 6: Sistemas de información y Salud Digital.

IV. Ponderación de los Compromisos de Gestión y sus indicadores

En virtud de transparentar la distribución de la ponderación de los indicadores por cada uno de los Compromisos de Gestión definidos para el año 2026, así como también evidenciar su ponderación relativa dentro de la evaluación global, se presenta a continuación, una tabla con el nombre del COMGES junto con la cantidad de indicadores que conforman cada compromiso y su peso específico para cada uno. La ponderación de cada COMGES es el reflejo del peso de cada indicador determinado por el total, respecto del instrumento. Finalmente, se indica la ponderación de cada indicador dentro de su compromiso, calculada dividiendo la ponderación total del compromiso entre la cantidad de indicadores que compone el COMGES, para así determinar su valor específico.

Tabla N°1: Ponderación de compromisos e indicadores COMGES 2026.

COMGES	Número indicadores	Ponderación del Compromiso	Ponderación del indicador al compromiso
1. Eficiencia en la gestión de procesos asistenciales, calidad y seguridad del paciente.	4	18%	4,50%
2. Estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento en la Red Asistencial.	2	9%	4,50%
3. Gestión de los tiempos de espera.	7	30%	4,29%
4. Gestión de Riesgos, Recursos Humanos y financieros.	3	13%	4,33%
5. Prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer	4	17%	4,25%
6. Sistemas de información y Salud Digital.	3	13%	4,33%

V. Metodología de evaluación

La evaluación de los COMGES para el año 2026 se fundamenta en un modelo que considera el cumplimiento de metas vinculadas a 23 indicadores principales y, en algunos casos, también el cumplimiento de requisitos complementarios asociados a estos indicadores. Esta estructura tiene como **objetivo simplificar el proceso evaluativo, fortalecer el foco en resultados estratégicos y reducir la carga asociada al seguimiento de indicadores.**

Otro elemento que debe considerar es el reporte de los indicadores de monitoreo. Estos indicadores, son un set de métricas, que no serán evaluadas en el total, pero que serán condición necesaria para evaluar el COMGES. Es decir, se evaluará el COMGES, solo a los Servicios de Salud que reporten el total de indicadores de monitoreo dispuestos a la fecha.

El modelo entonces se compone de tres elementos:

1. Evaluación de los indicadores principales, basada en la meta definida.
2. Evaluación del requisito complementario, cuando el indicador lo incorpora.
3. Reporte total de indicadores de monitoreo.

a. Evaluación de los Indicadores principales

Los indicadores que conforman cada Compromiso de Gestión evalúan el avance en áreas estratégicas de los Servicios de Salud. Cada uno posee un nombre, una fórmula, una fuente y meta establecida, la cual puede definirse en función de una mejora respecto de su línea base del año anterior o bien responder a una meta nacional, asociada a la propuesta técnica del referente MINSAL.

La evaluación del cumplimiento del indicador se realizará en base al grado de desempeño de cada Servicio de Salud respecto de la meta definida, según el proceso levantado por el referente técnico MINSAL, considerando la metodología específica de medición para cada uno de los indicadores propuestos para cada COMGES y, cuando corresponda, a la tabla de sensibilidad asociada a su medición.

b. Evaluación de los Requisitos asociados

Algunos indicadores que componen cada COMGES, incorporan requisitos, los que tienen por objetivo complementar la evaluación, a través de elementos que refuerzan la gestión y el proceso del indicador principal o abordan temáticas estratégicas de interés, por ejemplo: grupos priorizados, cumplimiento de planes específicos, monitoreos complementarios, entre otros.

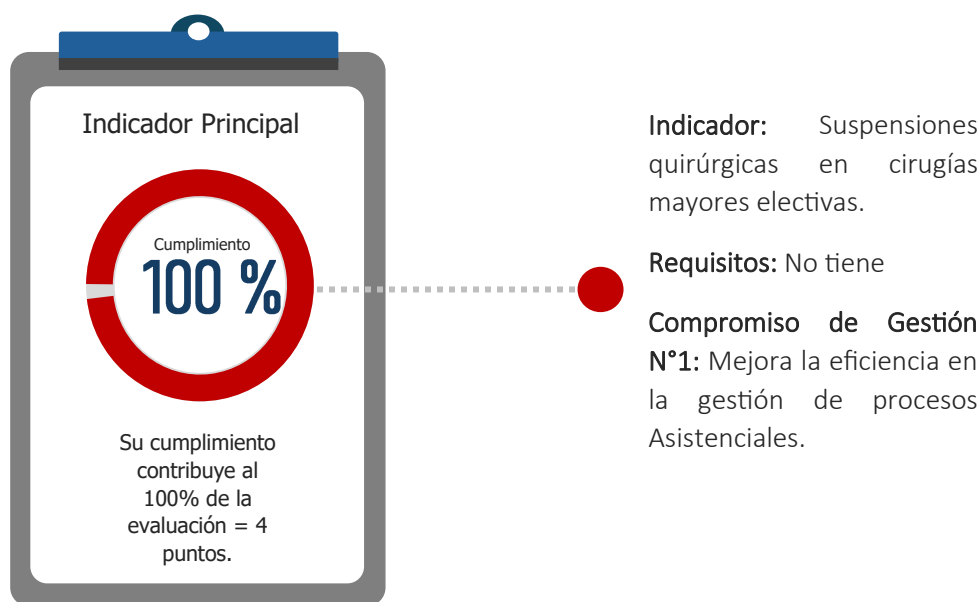
Cuando el indicador incorpore requisito, el puntaje del indicador principal se calculará según su tabla de sensibilidad en una escala de 0 a 4 puntos. El requisito no adicionará puntaje. En caso de incumplimiento técnico, no entrega o entrega fuera de plazo, se descontará 1 punto al puntaje obtenido por el indicador principal. La penalización no podrá llevar el resultado final a valores inferiores a 0.

c. Evaluación global del indicador

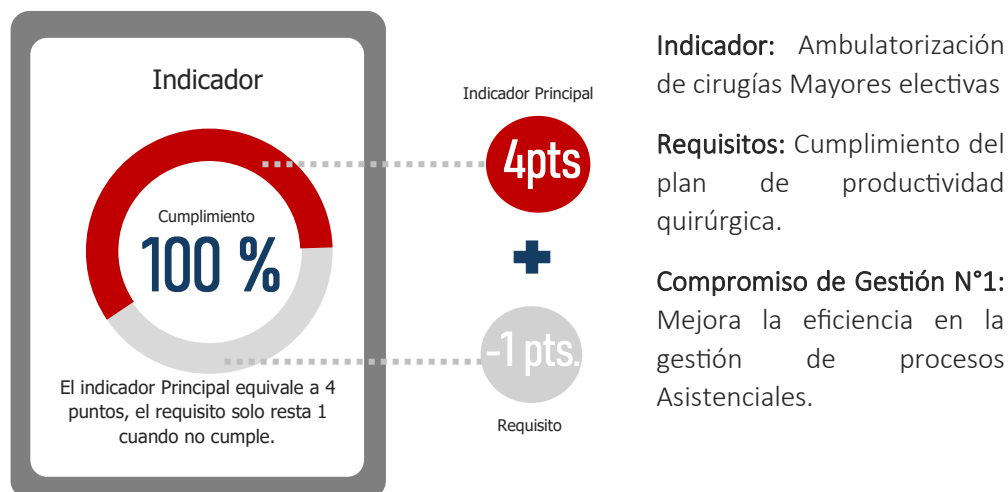
Cada indicador, con o sin requisitos asociados, tiene una ponderación específica dentro del COMGES al que pertenece. La evaluación global del indicador considera las siguientes variantes según el caso:

- En caso de que el indicador no cuente con un requisito asociado, su resultado final será equivalente al 100% de la ponderación asignada al COMGES.
- En caso de que el indicador incluya requisitos, el cumplimiento del indicador principal seguirá siendo 100% de la evaluación y el requisito no sumará puntos. En caso de no cumplir con el requisito, se restará un punto. En caso de que el resultado sea 0, no se restará el punto.

d. Esquema de evaluación para indicadores que no cuentan con requisitos.



e. Esquema de evaluación para indicadores que incluye requisitos.



f. Reporte de indicadores de monitoreo

Los indicadores de monitoreo son un set de métricas que será reportada por cada Servicio de Salud, en una planilla entregada por el Departamento de Control de Gestión de Subsecretaría de Redes Asistenciales. Este monitoreo se realizará una vez al año (corte diciembre) y será condición necesaria para evaluar los COMGES del Servicio de Salud. De no reportar un indicador, el COMGES no será evaluado.

g. Indicadores con requisitos

- 1.3 Cumplimiento de la tasa de donación de sangre.
- 3.1 Cumplimiento de Garantías explícitas de Salud (GES) en Red.
- 4.1. Ejecución de actividades al proceso de planificación, ejecución y monitoreo presupuestario
- 4.2. Implementación del plan gestión del riesgo de desastres
- 4.3 Índice del gasto en convenio con personas naturales respecto a la glosa autorizada vigente.
- 6.2 Plan de Ciberseguridad conforme a Ley 21.663.

VI. Tablas de sensibilidad y asignación de puntajes

La metodología de asignación de puntaje se establece a la definición e indicación de cada ficha técnica del indicador. El cumplimiento se determina en función de la disposición metodológica realizada para la evaluación del COMGES, en donde el nivel óptimo de cumplimiento se asocia a 4 puntos.

A continuación, la Tabla N°2 muestra, como ejemplo, la forma de asignación de puntaje para indicadores, según sus características distintivas:

Tabla N°2: Asignación de puntaje para indicadores.

Cumplimiento	Puntaje
≥100%	4 puntos
≥90%	3 puntos
≥80%	2 puntos
≥70%	1 punto

Cuando el indicador incorpore requisito, el puntaje del indicador principal se calculará según su tabla de sensibilidad en una escala de 0 a 4 puntos. El requisito no adicionará puntaje. En caso de incumplimiento técnico, no entrega o entrega fuera de plazo, se descontará 1 punto al puntaje obtenido por el indicador principal. La penalización no podrá llevar el resultado final a valores inferiores a 0.

VII. Sobre los indicadores de evaluación

Hitos claves

La evaluación de los COMGES del año 2026 se realizará con corte diciembre 2026. Periodo de retroalimentación marzo/abril 2027.

Cada indicador del COMGES debe contar, al menos, con un monitoreo general en las fechas establecidas para tal fin, independiente de que algunos indicadores requieran un seguimiento más frecuente, mensual, bimensual, trimestral o cuatrimestral, según lo determine el Referente Técnico de MINSAL.

El equipo de Control de Gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales dispondrá un formato para el registro de los indicadores.

Para evaluar los COMGES, todos los indicadores correspondientes deben ser sondeados previo a la evaluación.

Su propósito central es determinar el grado de avance, identificar oportunamente desviaciones respecto al comportamiento esperado, detectar eventuales problemas, orientar la toma de decisiones y permitir ajustes en la medición antes de la evaluación final del año.

Las fichas técnicas especifican y garantizan la existencia de una fuente y una ruta de información que permitan realizar esta tarea de forma concluyente dentro del periodo establecido.

Respecto a los indicadores de fuente oficial, para la evaluación anual se utilizará el cierre del calendario 2026; es decir, el cierre oficial conforme a cada una de las fuentes de datos.

A continuación, en la tabla N°3, se presenta el calendario oficial DEIS, en el cual se indica que, para la evaluación COMGES 2026, para la evaluación final, se considerará el corte publicado el 26/01/2027.

Tabla N°3: Calendario DEIS.

FECHAS OFICIALES DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTO SISTEMA DE CARGAS REM			
SISTEMA DE CARGAS REM			
AÑO 2026			
Información REM a cargar	Apertura de Puerto	Cierre de Puerto	Datos disponibles para Publicación
Enero 2026	Viernes 13 febrero	Viernes 20 febrero	Martes 24 febrero
Febrero 2026	Viernes 13 marzo	Viernes 20 marzo	Martes 24 de marzo
Marzo 2026	Miércoles 15 abril	Miércoles 22 abril	Viernes 24 abril
Abril 2026	Viernes 15 mayo	Lunes 25 mayo	Miércoles 27 mayo
Mayo 2026	Viernes 12 junio	Viernes 19 junio	Martes 23 junio
Junio 2026	Martes 14 Julio	Miércoles 22 Julio	Viernes 24 Julio
Julio 2026	Viernes 14 agosto	Viernes 21 agosto	Martes 25 agosto
Agosto 2026	Lunes 14 septiembre	Martes 22 septiembre	Viernes 25 septiembre
Septiembre 2026	Jueves 15 octubre	Jueves 22 octubre	Lunes 26 octubre
Octubre 2026	Viernes 13 noviembre	Viernes 20 noviembre	Martes 24 noviembre
Noviembre 2026	Martes 15 diciembre	Martes 22 diciembre	Jueves 24 diciembre
Diciembre 2026	Viernes 15 enero 2027	Viernes 22 enero 2027	Martes 26 enero 2027

Para la evaluación de indicadores con fuente oficial, no se considerarán datos cuyo origen y fecha de extracción sean posteriores a la fecha de corte final, o que no cuenten con una fecha de extracción claramente identificable.

Sobre indicadores de monitoreo

Los indicadores de monitoreo corresponden a un proceso sistemático, continuo y estructurado de recopilación, revisión y análisis de información, cuyo objetivo es evaluar el progreso, desempeño y funcionamiento de indicadores asociados a los COMGES, pero no considerados en la evaluación.

Los indicadores de monitoreo serán una condición necesaria para evaluar los COMGES 2026. Estos deben ser reportados en una planilla, la que debe estar completa. La gestión (cumplimiento de metas y estándares) de estos indicadores es responsabilidad del Referente Técnico MINSAL o la red como se articule el objetivo de este.

Existirá solo una instancia para reportar el cumplimiento de estos indicadores siendo una condición necesaria para evaluar los resultados del Servicio de Salud. Sin embargo, se deja establecido que las referencias técnicas del nivel central pueden proponer instancias intermedias de seguimiento para los indicadores de monitoreo, de forma paralela al proceso de evaluación de los COMGES.

El monitoreo no constituye un proceso de evaluación; por lo tanto, no implica asignación de puntajes, ni tampoco genera instancias de apelación respecto de los resultados.

Para indicadores de evaluación y monitoreo con fuente de datos oficial, los referentes técnicos del MINSAL serán responsables de disponer de la información correspondiente. En aquellos casos en que se requiera información proveniente de fuentes locales, el Referente Técnico MINSAL deberá entregar, de manera oportuna y rigurosa, todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades asociadas al indicador. Esto incluye planillas, formatos, reportes y cualquier otro documento pertinente. A su vez, los Servicios de Salud deberán remitir los datos exigidos para el monitoreo.

Adicionalmente, los referentes de Control de Gestión de los Servicios de Salud deberán ejecutar un seguimiento periódico y riguroso que permita identificar oportunamente desviaciones no deseadas, alertar a la autoridad correspondiente y promover la adopción de medidas correctivas.

Es importante destacar que este proceso de monitoreo no constituye una evaluación, solo una condición para medir el COMGES. Se trata, más bien, de una instancia técnica de seguimiento y retroalimentación destinada a registrar el trabajo en algunas líneas prioritarias.

Los indicadores de monitoreo no consideran requisito.

Sobre el proceso de evaluación

Respecto del proceso de evaluación final, se entregarán las definiciones concluyentes hacia fines de 2026. Estas considerarán, entre otros aspectos, lo siguiente:

- Fecha de publicación de datos provenientes de fuentes oficiales.
- Formato definitivo para evaluación de datos locales.
- Calendario para los Servicios de Salud, que incluirá fechas de disposición de planillas, plazos de evaluación, períodos de apelación y la publicación de los resultados finales del proceso evaluativo.
- Lineamientos técnicos, metodológicos y procedimientos para asegurar la trazabilidad y transparencia del proceso.

El equipo de Control de Gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales será el encargado de comunicar oportunamente estos procedimientos y canalizar los lineamientos con los Servicios de Salud de la Red.

Sobre las apelaciones.

Este proceso corresponde a la justificación argumentativa respecto de los resultados obtenidos en los indicadores COMGES, cuyo cumplimiento no alcanzó lo comprometido por parte del Servicio de Salud. Esta etapa, integra la carga de antecedentes y medios de verificación asociados a dichos argumentos, lo que corresponde a la apelación en sí misma, argumentos que deben ser ingresados en las carpetas SharePoint COMGES por los mismos Servicios de Salud y revisadas por cada Referente Técnico MINSAL.

La revisión y respuesta a las apelaciones es realizada por los referentes técnicos de MINSAL para cada indicador, quienes evalúan los antecedentes presentados y emiten una respuesta fundamentada, indicando la aceptación o rechazo de la apelación.

Posteriormente, el Departamento de Control de Gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales valida estas respuestas, revisando que cumplan con los criterios técnicos, metodológicos y procedimentales establecidos. Finalmente, se consolida la información y se recalcula el cumplimiento.

Indicadores de Evaluación

COMGES N°1. Eficiencia en la gestión de procesos asistenciales, calidad y seguridad del paciente

- 1.1 Suspensiones quirúrgicas en cirugía mayores electivas.
- 1.2. Derivaciones en APS al nivel secundario respecto a las consultas totales.
- 1.3. Cumplimiento de la tasa de donación de sangre.
- 1.4. Cumplimiento del proceso de acreditación en la etapa de ingreso de los establecimientos de Salud.

COMGES N°2. Estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento

- 2.1. Ingresos a la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP) de personas de 65 años o más.
- 2.2. Tasa de donantes efectivos en muerte encefálica por millón de población (PMP) generados por Servicio de Salud.

COMGES N°3: Gestión de los tiempos de espera.

- 3.1. Cumplimiento de Garantías explícitas en Salud (GES) en la red.
- 3.2. Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad médica.
- 3.3. Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad odontológica.
- 3.4. Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de intervenciones quirúrgicas mayores y menores.
- 3.5. Resolución de Lista de espera de consultas nuevas de especialidades médicas con destino APS en especialidades definidas.
- 3.6. Resolución de Lista de espera de especialidades odontológicas de endodoncia, prótesis removible y periodoncia en atención primaria de salud.
- 3.7. Resolución de Lista de espera de intervenciones quirúrgicas menores electivas en atención primaria de salud.

COMGES N°4. Gestión de riesgos, Recursos Humanos y financieros.

- 4.1. Ejecución de actividades al proceso de planificación, ejecución y monitoreo presupuestario.
- 4.2. Implementación del plan gestión del riesgo de desastres.
- 4.3. Índice del gasto en convenio con personas naturales respecto a la glosa autorizada vigente.

COMGES N°5: Prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer.

- 5.1. Nivel de cumplimiento efectivo de garantías GES en problemas de salud oncológicos.
- 5.2. Casos oncológicos No GES en lista de espera quirúrgica con espera menor a 90 días.
- 5.3. Cobertura de tamizaje para cáncer cervicouterino en establecimientos de APS municipales y dependientes de Servicio de Salud.
- 5.4. Cobertura efectiva de vacuna contra el VPH de NNA que cursan cuarto año básico con dosis nonavalente.

COMGES N°6: Sistemas de información y Salud Digital

6.1. Nivel de implementación de estrategias y/o células de Hospital Digital en establecimientos del Servicio de Salud.

6.2. Plan de Ciberseguridad conforme a Ley 21.663.

6.3. Implementación de Estrategia Tiempos De Espera Interoperable.

Indicadores de Monitoreo

1. Ambulatorización de cirugías mayores electivas.
2. Personas que abandonan durante el Proceso de Atención de Urgencia en las Unidades de Emergencia Hospitalaria Adulto y Pediátrica.
3. Días de estada en Hospitalización Domiciliaria.
4. Camas disponibles respecto de la dotación vigente.
5. Cobertura de gestantes en control con ecografía realizada 22 – 24 semanas de gestación.
6. Cumplimiento de supervisión del proceso de Eventos Centinela Priorizados de Reporte Inmediato (ECPRI).
7. Cumplimiento de test visual/rápido en los establecimientos de atención primaria.
8. Personas mayores de 15 años en hemodiálisis crónica con Fístula Arteriovenosa confeccionada.
9. Personas mayores de 15 años con enfermedad renal crónica en tratamiento de Peritoneodiálisis.
10. Personas que viven con VIH en control en establecimientos de los Servicios de Salud, que reciben tratamiento antirretroviral (TAR) y presentan carga viral indetectable.
11. Plan Operativo Anual de la Estrategia Nacional de Salud.
12. Tiempo de Espera a Consultas Nuevas de Especialidad médica.
13. Tiempo de Espera a Consultas Nuevas de Especialidad odontológica.
14. Tiempo de Espera a intervenciones quirúrgicas.
15. Especialidades médicas que cumplen con estándar de Altas en Centros de Especialidades Ambulatorias de Atención en Salud.
16. Índice de ausentismo laboral por Licencia médica curativa.
17. Implementación de protocolos de atención nuevos o adaptación de aquellos vigentes en establecimientos de salud, incorporando criterios de pertinencia cultural en la APS.
18. Implementación de Modelos de Salud Intercultural en Hospitales y Servicios de Salud.
19. Plan de acción de Plataforma “Sistema Integral de Atención a Personas SIAP – OIRS
20. Consultorías y teleconsultorías de Salud Mental en Establecimientos de Atención Primaria.
21. Intervenciones psicosociales grupales realizadas a personas en tratamiento por Salud Mental.
22. Procesos clínicos que cumplen con la evaluación de concordancia SIDRA-REM de las atenciones médicas de los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia.

5. Marco conceptual e indicadores que componen cada COMGES

Compromiso de Gestión N°1: Eficiencia en la gestión de procesos asistenciales, calidad y seguridad del paciente.

Objetivo estratégico

"Optimizar la gestión los procesos clínicos administrativos en la red de salud pública, para garantizar una atención oportuna, efectiva y centrada en las personas, mediante la mejora continua de los procesos, la digitalización y el fortalecimiento de articulación de la red entre los distintos niveles de atención."

Contexto del COMGES

El fortalecimiento de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en Chile es un objetivo estratégico que busca garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud, enmarcado en políticas públicas como la Ley N° 19.937 sobre Autoridad Sanitaria y Gestión, y los Objetivos Sanitarios 2030. Las RISS son esenciales para cumplir con compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades".

Atención Primaria de Salud (APS).

Las acciones claves para lo anterior incluyen mejorar la eficiencia en la Atención Primaria de Salud (APS). La derivación adecuada desde APS al nivel secundario, es esencial para la integración de las RISS. Este proceso beneficia la gestión del sistema, reduciendo consultas innecesarias, mejorando la resolutivez en la atención primaria. Por otro lado, la medición del Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS), que mide el desempeño de las comunas en la prestación de servicios esenciales, contribuye a que los Servicios de Salud participen activamente en corresponsabilidad a su rol gestor de red.

Eficiencia en procesos quirúrgicos y hospitalarios.

A nivel hospitalario la ambulatorización de cirugías mayores electivas ayuda a descongestionar hospitales y optimizar recursos, mejorando la eficiencia del sistema de salud y la atención centrada en la paciente.

Procesos de apoyo.

Desde la Subsecretaría de Redes de Asistenciales, se ha instruido a los Servicios de Salud implementar estrategias para optimizar los procesos de las unidades de apoyo, dentro de esto en el área de medicina transfusional se ha establecido metas anuales para el incremento de las donaciones de sangre de tipo altruistas, las cuales son esenciales para mejorar la calidad, seguridad y disponibilidad de los productos sanguíneos lábiles utilizados en terapia transfusional.

Durante el 2025, se definió establecer un compromiso de gestión para el logro de objetivos nacionales a largo plazo. Se espera que estas acciones lleven al aumento de la tasa de donación desde 19 en 2025 a 30 por cada 1.000 habitantes en el año 2030. Del mismo modo, se espera un aumento de un 10% anual de las donaciones altruistas en cada servicio de salud, lo cual permitirá lograr a nivel país el 100% de altruismo en el año 2030, con un especial énfasis en la donación del tipo altruista repetida o fidelizada.

Por otro lado, el fortalecimiento de los estándares de calidad y seguridad en la atención de salud es un objetivo prioritario para garantizar una atención efectiva, equitativa y centrada en el paciente. Este propósito se alinea con políticas públicas como la Ley N° 20.584 sobre derechos y deberes en salud, el Sistema Nacional de Acreditación de Prestadores Institucionales y el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos. A través de la adherencia a protocolos, la capacitación del personal y la implementación de sistemas de monitoreo, se busca promover la mejora continua en la Red Asistencial.

Indicadores

COMGES N°1. Eficiencia en la gestión de procesos asistenciales, calidad y seguridad del paciente

- 1.1 Suspensiones quirúrgicas en cirugía mayores electivas.
- 1.2. Derivaciones en APS al nivel secundario respecto a las consultas totales.
- 1.3. Cumplimiento de la tasa de donación de sangre.
- 1.4. Cumplimiento del proceso de acreditación en la etapa de ingreso de los establecimientos de Salud.

1.1. Suspensiones quirúrgicas en cirugía mayores electivas.

Mide el porcentaje de cirugías mayores electivas que son suspendidas por diversas causas, ya sean administrativas, logísticas u otras. Su análisis es crucial para identificar áreas de mejora en la programación quirúrgica, la gestión de recursos y la coordinación entre unidades involucradas, contribuyendo así a optimizar el uso de los quirófanos reduciendo dichas suspensiones por cualquier causa.

ID CG-SRA 30	Suspensiones quirúrgicas en cirugía mayores electivas				
DIGERA Departamento de Gestión Hospitalaria y Red de Urgencia					
Objetivo del Indicador	Minimizar la suspensión de cirugías mayores electivas a través de una gestión eficiente de la programación de tabla quirúrgica y medidas preventivas específicas para la optimización de procesos logísticos y administrativos.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de cirugías mayores electivas en horario hábil suspendidas / Número de cirugías mayores electivas programadas en horario hábil) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal Truncado			Polaridad	Los Valores bajos son Buenos
Meta	<=6,5% de suspensión				
Exclusiones	Establecimientos de baja complejidad y DFL 36.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	REM	

Tabla de Sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
$\leq 6,5\%$	4 puntos
$\leq 7,0\%$	3 puntos
$\leq 8,0\%$	2 puntos
$\leq 10,0\%$	1 punto
$> 10,0\%$	0 puntos

Definición de Términos

- **Cirugía Mayor Electiva:** Es la intervención quirúrgica mayor que, por el tipo de diagnóstico y las características clínicas del paciente puede ser diferida en el tiempo para su realización y programada en tabla quirúrgica.
- **Paciente condicional:** Es aquel que se programa más allá de las 8 horas de la tabla programada y queda en condición de suplencia frente a una probable suspensión de paciente o a la disponibilidad de quirófanos. No se debe contar con más de un 10,0% de pacientes condicionales en la programación del establecimiento. No se deben incluir

pacientes que se vean afectados por el ayuno (diabetes), preparaciones especiales, enfermedades de salud mental, aspectos especiales (persona mayor, ruralidad, dependiente de cuidados), menos de 2 años, ni aquellos que requieran cirugías prolongadas y/o complejas.

- **Paciente agregado:** Aquel paciente que no es programado en tabla quirúrgica, ni es condicional, y que dada su condición clínica requiere ser intervenido utilizando un quirófano de cirugía mayor siempre bajo la autorización de la jefatura de pabellón.
- **Paciente condicional intervenido:** Aquel paciente incluido en tabla quirúrgica como condicional y que fue intervenido en un quirófano de cirugía mayor.
- **Bloque quirúrgico:** Corresponde a un módulo dinámico, en el que se asigna a una determinada especialidad, un periodo de tiempo del uso del quirófano de cirugía mayor, según la demanda quirúrgica del establecimiento. La asignación a las distintas especialidades debe resultar de la evaluación mensual de indicadores de eficiencia en el uso de los quirófanos, el volumen de pacientes GES y la LE de pacientes no GES, entre otros. Su asignación es responsabilidad del encargado del subproceso de tabla quirúrgica.

Consideraciones Técnicas

Se considera solo cirugías electivas en horario hábil, ya que la suspensión se mide en el total de lo programado. Finalizado el año se envía por el referente DIGERA del Departamento de Gestión de la Información con el corte oficial MINSAL.

Finalizado el año se envían los datos REM por parte del referente del Departamento de Análisis e Información para la Gestión a referente DIGERA del Departamento de Red de Urgencia y Atención Cerrada para su derivación a las redes.

Manera se entrega la información: Planilla de datos REM

Cuando: De acuerdo a Calendario REM, enero 2027

Cuántas veces al año: Una vez al año

Fuente: REM

Formato: Excel

Observaciones: Se realiza monitoreo mensual de acuerdo a Calendario REM.

1.2. Derivaciones en APS al nivel secundario respecto a las consultas totales.

Indicador de producción que mide la relación entre la producción total de consultas y controles médicos y los casos que son derivados al siguiente nivel de atención, eso permite medir la capacidad resolutoria del equipo médico.

ID CG-SRA 85	Derivaciones en APS al nivel secundario respecto a las consultas totales.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Evaluar capacidad resolutoria del nivel primario, midiendo porcentaje de derivaciones a nivel secundario del total de atenciones médicas realizadas.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS / N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores bajos son Buenos
Meta	≤ 10%				
Exclusiones	Se excluyen en el denominador las consultas médicas generadas en los dispositivos de Urgencia (SAPU;SAR;SUR) Se excluyen del numerador las interconsultas generadas hacia dispositivos de Atención Primaria a través del programa de resolutoridad.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	REM	

Tabla de Sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
$\leq 10,0\%$	4 puntos
$\leq 11,5\%$	3 puntos
$\leq 13,0\%$	2 puntos
$\leq 14,5\%$	1 punto
$> 14,5\%$	0 puntos

Definición de Términos

SIC: Solicitud de Interconsulta

Consideraciones Técnicas

Lo esperado es que el porcentaje de derivación al nivel secundario de consultas y controles médicos sea menor o igual a 10%. Se excluyen del numerador las interconsultas generadas hacia dispositivos de Atención Primaria a través del programa de resolutoria.

En el denominador se incluye número de: consultas de morbilidad, todos los controles de salud realizados por médicos y la consulta de urgencia no SAPU, SUR, SAR ni SUC.

1.3. Cumplimiento de la tasa de donación de sangre.

Este indicador evalúa los resultados de las estrategias implementadas para incrementar la tasa por cada 1.000 habitantes y mejorar la calidad de las donaciones de sangre en los Servicios de Salud.

ID CG-SRA 21	Cumplimiento de la tasa de donación de sangre				
DIGERA Departamento de Gestión Ambulatoria y de Apoyo Diagnóstico					
Objetivo del Indicador	Aumentar la producción y calidad de las donaciones de sangre en los servicios de salud, promoviendo la cultura del altruismo repetido que garantice un suministro suficiente y seguro de sangre y productos sanguíneos lábiles para quien lo necesite.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	$\text{Cumplimiento} = \frac{\text{índice de donaciones obtenido}}{\text{Meta del año}} * 100$				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal Truncado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	Cumplimiento del 100% del índice definido. Según evaluación de suficiencia de productos sanguíneos lábiles (PSL): SS y establecimientos con suficiencia de PSL (donaciones > demanda transfusional) pueden mantener o aumentar altruismo repetido. SS y establecimientos sin suficiencia de PSL (demanda transfusional > donaciones) deben aumentar cantidad de donaciones y altruismo repetido.				
Exclusiones	Establecimientos de la red asistencial que no atienden donantes de sangre en ninguna modalidad. Aplica a donaciones por aféresis.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	REM	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥100,0%	4 puntos
≥95,0%	3 puntos
≥90,0%	2 puntos
≥80,0%	1 punto
<80,0%	0 punto

Requisitos

El requisito contiene tres componentes:

Componente 1: N° donaciones altruistas/ Total donaciones (ponderación 50%)

Se considera como cumplido cuando este valor es mayor o igual al 20%. En concordancia con periodo anterior, se debe aumentar un 10% al año hasta lograr un 100%.

Componente 2: N° donaciones altruistas repetidas/N° donaciones altruistas totales (ponderación 30%)

Se considera como cumplido cuando este valor es mayor o igual al 55% (promedio nacional 2025)

Componente 3: N° información entregada/N° de información solicitada (ponderación 20%)

Para este componente, se considera la entrega de información sobre capacidades instaladas en los sitios fijos y móviles autorizados y reconocidos por MINSAL para la atención de donantes de sangre. Este reporte podrá ser entregado a nivel de establecimiento o servicio de salud mediante una plataforma estandarizada y diseñada para ello.

Cálculo de porcentaje de cumplimiento del requisito:

$$(\text{Componente}_1 * 0,5 + \text{Componente}_2 * 0,3 + \text{Componente}_3 * 0,2) * 100$$

El requisito se considera cumplido cuando el valor obtenido es 80%

Definición de Términos

Fórmula Índice donaciones

$$\text{Índice de donaciones} = \frac{\text{N° donaciones totales} * 1000}{\text{Población vigente}}$$

- N° donaciones totales: Producción total informada en REM A25, sección A1.
- Población vigente: Población informada en diciembre del año anterior por FONASA

Cálculo de meta esperada por año:

$$\text{Meta del año} = \text{LB} + \frac{(\text{Meta} - \text{LB})}{\text{Periodos}} * \text{Periodo}$$

- Línea Base (LB): Tasa de donación año 2025
- Meta: 30
- Periodos = 5 Años (tener índice de 30 al año 2030) (2026 es el año 1)
- Periodo =1 para el año en curso

Con esto, se calcula cuánto debe aumentar la tasa cada año para alcanzar la meta país.

Ejemplo:

Supongamos que la línea base en 2025 para un servicio de salud fue 20.

Calcular el incremento anual:

$$\frac{\text{Meta-LB}}{5} = \frac{30 - 20}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Cada año se requiere aumentar 2 puntos.

Metas estimadas por año

Año	Periodo	Cálculo	Meta anual
2026	1	$20 + (2 \times 1)$	22
2027	2	$20 + (2 \times 2)$	24
2028	3	$20 + (2 \times 3)$	26
2029	4	$20 + (2 \times 4)$	28
2030	5	$20 + (2 \times 5)$	30

Las donaciones totales de sangre se refieren a la cantidad global de unidades de sangre recolectadas en un período determinado, incluyendo todos los tipos de donación. Estas pueden clasificarse en:

- Donaciones altruistas nuevas, son aquellas realizadas por personas que donan por primera vez de manera altruista, de manera libre y voluntaria, sin recibir dinero ni cualquier otra forma de pago o incentivo a cambio.
- Donaciones altruistas repetidas, son aquellas realizadas por personas que donan en forma regular al menos una vez cada 2 años de manera libre y voluntaria, sin recibir dinero ni cualquier otra forma de pago a cambio.
- Donaciones altruistas totales, corresponde a la suma de nuevas y repetidas.
- Donaciones de reposición, son aquellas realizadas por personas que donan para reponer/devolver la sangre utilizada por un paciente específico, familiar o un amigo.
- Donaciones de aféresis, corresponden a un proceso de obtención selectiva de un componente sanguíneo específico (glóbulos rojos, plaquetas o plasma) mediante equipos de aféresis que operan por separación o centrifugación. Estas donaciones se registran en el reporte de producción del sitio de atención de donantes, dado que su obtención debe realizarse bajo un modelo de donación altruista y repetida.

La suma de estos tipos de donaciones constituyen el total de sangre recolectada en un sitio fijo de donación (hospital o casa del donante) y colecta móvil perteneciente a la jurisdicción territorial del servicio de salud.

La demanda transfusional de un establecimiento o Servicio de Salud corresponde a las necesidades estimadas de concentrados de glóbulos rojos (CGR) totales que proyecta utilizar en terapia transfusional durante el año en curso, con el objetivo de cubrir en forma eficiente y oportuna las necesidades de los usuarios de su red. Se utiliza los CGR (de todos los grupos sanguíneos) como trazadores de la demanda futura y su fórmula de cálculo fue definida en las orientaciones técnicas de este COMGES durante 2025.

La tasa de donación de sangre es un indicador definido por la Organización Mundial de la Salud² (OMS) que expresa la cantidad de donaciones de sangre realizadas en una población durante un período determinado, en relación con el tamaño de dicha población. Este indicador permite evaluar la disponibilidad y suficiencia del suministro de sangre en un país y revela diferencias según sus niveles de ingresos. Además, constituye una herramienta fundamental para monitorear el acceso a un suministro sanguíneo seguro.

Este indicador permite:

- Evaluar el nivel de participación de la población en la donación de sangre.
- Medir la autosuficiencia del sistema de sangre de un país, región o servicio de salud.
- Facilitar la comparación entre distintos territorios o períodos de tiempo.

Se calcula con la fórmula **(Número de donaciones de sangre / Población) × 1.000** y se expresa como donaciones por cada 1.000 habitantes por año.

Para los servicios de salud que cuentan con centros de sangre, se espera que alcancen y mantengan tasas superiores a 30 donaciones por cada 1.000 habitantes. Esto se basa en que los sistemas locales consolidados, con altos niveles de donación altruista y una fuerte fidelización de donantes habituales, tienden a presentar un mejor desempeño, una mayor estabilidad del stock y menor variabilidad estacional.

Consideraciones Técnicas

Se ha definido que los establecimientos de la red asistencial podrán atender donantes de sangre, siempre y cuando cuenten con un sitio fijo intrahospitalario, con una casa del donante de sangre o que realicen actividades de colecta móvil de sangre, y que estos estén autorizados por el Ministerio de Salud, según las orientaciones técnicas de este compromiso de gestión. Todas estas actividades deben ser realizadas bajo las normativas establecidas por el ministerio e ir en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Sangre.

El reporte de datos desde los equipos de atención de donantes será realizado de forma habitual en plataforma REM Serie A25 denominado “*Servicios de Sangre*”, sección A1: Población donante. La visualización de la información reportada podrá ser realizada por los referentes COMGES o unidades de apoyo en cada servicio de salud mediante una plataforma diseñada para ello.

² Organización Mundial de la Salud. (2025, 30 de mayo). Seguridad y disponibilidad de la sangre. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability> (Consultado el 10 de febrero de 2026)

Para los cálculos de metas 2026, se ha considerado los cumplimientos de donaciones altruistas y totales durante 2025 en todos los servicios de salud del país y el ajuste respectivo acordado con cada equipo técnico. No se requiere medio de verificación por parte de los Servicios de Salud a MINSAL, ya que el dato corresponde a la fuente oficial REM. La consolidación se realiza por MINSAL, de manera centralizada, de acuerdo a los cortes definidos y visualizados por los Servicios de Salud y establecimientos de manera mensualizada. Por otra parte, Referente Técnico MINSAL del indicador envía por correo electrónico a Control de Gestión de Gabinete los resultados de los indicadores por Servicio de Salud con fecha del corte a evaluar.

1.4. Cumplimiento del proceso acreditación en la etapa de ingreso de los establecimientos de Salud.

Este indicador refleja el número de Establecimientos de Salud de Atención Primaria que ingresan al proceso de acreditación por Servicio de Salud, dando cumplimiento a la Garantía de Calidad establecida en el Decreto GES 2025-2028.

ID CG-SRA 9	Cumplimiento del proceso de acreditación en la etapa de ingreso de los establecimientos de Salud.				
DIGERA Departamento de Seguridad y Calidad de la Atención					
Objetivo del Indicador	Contribuir a mejorar la calidad y seguridad del paciente, a través del cumplimiento de la Garantía de Calidad en la Atención Primaria de Salud.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de establecimientos de salud de APS del Servicio de Salud con ingreso al proceso de acreditación a la SIS / Número de establecimientos comprometidos en la meta según lo programado) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100%				
Exclusiones	No hay				
Fuente Numerador	LOCAL		Fuente Denominador	LOCAL	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
100,0%	4 puntos
< 100,0%	0 puntos

Definición de Términos

Ingreso proceso de acreditación: para efectos de COMGES, se refiere al ingreso de solicitud a la Superintendencia de Salud (SIS), teniendo cumplido todos los requisitos obligatorios, que permitan iniciar el proceso de acreditación o bien su reacreditación.

APS: Atención Primaria de Salud

Establecimiento de Salud de APS: establecimientos de atención primaria de salud (establecimientos de atención abierta de baja complejidad de dependencia municipal, delegados o de Servicio de Salud), puede incluir CESFAM, CGR, CGU.

CESFAM: Centro de Salud Familiar

CGR: Consultorio General Rural
CGU: Consultorio General Urbano
SIS: Superintendencia de Salud.

Consideraciones Técnicas

Los Establecimientos de Salud de Atención Primaria (APS) considerados son los Centro de Salud Familiar (CESFAM), Consultorio General Urbano (CGU) y Consultorio General Rural (CGR) con sus diversas dependencias (postas de salud rural, CECOSF, Urgencia, otros).

Cada Servicio de Salud apoyará a los establecimientos de su red para presentar la solicitud de acreditación o de reacreditación antes del 31 de diciembre del 2026 o según su vigencia. El número de CESFAM por cada Servicio de Salud será definido por el Ministerio de Salud a fin de alcanzar progresivamente una cobertura del 80% al 1° de julio del 2028.

Responsable del envío del informe: Referente de Seguridad y Calidad del Servicio de Salud.

Dirigido a: Departamento de Seguridad y Calidad, DIGERA, MINSAL.

Fecha de envío: 15 días después del corte semestral (Julio 2026 y Enero 2027)

Medio de envío: correo electrónico.

Compromiso de Gestión N°2: Estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento en la Red Asistencial.

Objetivo estratégico

“Mejorar la calidad de vida de las personas y sus entornos reduciendo la carga de enfermedad en la población a través de acciones de prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y atención continua”.

Contexto

El fortalecimiento de la calidad de vida de la población y la reducción de la carga de enfermedad requieren estrategias integrales que aborden la prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y atención continua. Este enfoque está alineado con políticas públicas y los Objetivos Sanitarios 2030. A través de la implementación de protocolos, la capacitación del personal y el monitoreo de indicadores clave, se busca garantizar una atención equitativa y efectiva, que aborde tempranamente problemas de salud prevenibles y contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas y sus familias.

Atención a adultos mayores y personas con dependencia severa

La Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas ECICEP fortalece la atención integral de los adultos mayores, evitando hospitalizaciones prolongadas y facilitando la atención domiciliaria. El aumento de ingresos a esta estrategia es clave para mejorar su calidad de vida.

Por otro lado, el Programa de dependencia severa garantiza una atención integral (física, emocional y social) en el domicilio, dotando a cuidadores y familias de herramientas para el cuidado adecuado. La elaboración e implementación de planes de cuidados optimiza la gestión de recursos y evita hospitalizaciones innecesarias. Además, el apoyo a cuidadores es esencial para asegurar la continuidad del cuidado y prevenir su agotamiento físico y emocional, mediante la capacitación y acompañamiento especializado.

Fortalecimiento a la donación de órganos y trasplante

En Chile, la donación y el trasplante de órganos representa un desafío sanitario y estructural permanente, condicionado principalmente por variables clínicas y socio culturales. A pesar de los avances médicos y legislativos, como la Ley 19.451 y sus modificaciones posteriores, la tasa de donantes efectivos en muerte encefálica, se ha mantenido por debajo de los estándares definidos en la OCDE. Esta brecha ha contribuido a un aumento sostenido en la demanda de órganos, generando un incremento progresivo de las listas de espera de pacientes que requieren trasplantes.

Para abordar esta problemática, se han implementado diversas estrategias destinadas a fortalecer el sistema nacional de donación y trasplantes. Entre ellas, se destaca el fortalecimiento normativo a través de protocolos hospitalarios para la identificación y gestión de potenciales donantes en la Red Asistencial; la formación y entrenamiento continuo de los Coordinadores Locales de Procuramiento (CLP), equipos clínicos y referentes de los Servicios de Salud; así como también la difusión de

campañas de concientización y educación orientadas a fomentar la cultura de la donación de órganos. Estas últimas, buscan superar las barreras que están asociadas al desconocimiento, a los mitos socio – culturales y a la desconfianza institucional, factores que históricamente han limitado la generación de donantes efectivos.

Es claro que todas aquellas acciones orientadas a promover una transformación hacia una cultura de la donación, permitirán obtener mejores resultados, favoreciendo un acceso equitativo, oportuno, seguro y de calidad a los trasplantes; sin embargo, el inicio de este cambio debe surgir desde una comunidad sanitaria educada, ética y comprometida, capaz de acoger a las familias y a la sociedad en general en este proceso cultural que el país requiere, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema de salud, al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.

Finalmente, la medición de la tasa de donantes efectivos no solo es una herramienta clave para evaluar la eficiencia del sistema sanitario en la generación de donantes efectivos; sino que, además, permite medir el impacto de las políticas públicas, la capacidad institucional y los factores que influyen en la donación de órganos.

Indicadores:

Compromiso de Gestión N°2: Estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento en la Red Asistencial.

- 2.1. Ingresos a la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP) de personas de 65 años o más.
- 2.2. Tasa de donantes efectivos en muerte encefálica por millón de población generados por Servicio de Salud.

2.1. Ingresos a la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP) de personas de 65 años o más.

Este indicador evalúa el porcentaje de ingreso de personas de 65 y más años a la Estrategia de Cuidado Integral, asegurando la continuidad del proceso iniciado en 2019. Se articula con la planificación y ejecución de cuidados integrales en APS (ingreso a ECICEP, Plan de Cuidado Integral, Controles Integrales y Seguimiento), abarcando desde promoción y prevención hasta atención curativa y paliativa, mediante la colaboración entre equipos gestor de MAIS/ECICEP y diversas estrategias de atención para personas mayores.

ID CG-SRA 41	Ingresos a la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP) de personas de 65 años o más.				
DIVAP Departamento de Desarrollo e Integración en Atención Primaria					
Objetivo del Indicador	Monitorizar el porcentaje de ingreso de personas de 65 y más años a la Estrategia de Cuidado Integral, fortaleciendo la gestión y el acompañamiento técnico de los Servicios de Salud. Esto permitirá optimizar la implementación de un cuidado integral, continuo y centrado en la persona mayor, tanto en la atención primaria como en la red asistencial.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de personas de 65 y más años ingresadas a la Estrategia de Cuidado Integral/Número de personas de 65 y más años comprometidas a ingresar a la Estrategia de Cuidado Integral) x100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100% de las personas de 65 y más años, según el total comprometido, ingresadas a la Estrategia de Cuidado Integral.				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	LOCAL	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥100%	4 puntos
≥91%	3 puntos
≥81%	2 puntos
≥70%	1 punto
<70%	0 puntos

Definición de Términos

MAIS/ECICEP: El cuidado integral centrado en la persona, desde el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) se entiende como la consideración de las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales en todas las etapas del proceso del curso de vida y en relevancia del estado de salud-enfermedad. Estas se abordan mediante planes de cuidados integrales, consensuados y continuos coordinando las prestaciones de salud.

Consideraciones Técnicas

Desde 2019, el Ministerio de Salud ha priorizado el cuidado integral de personas mayores a través de COMGES y el acompañamiento técnico de los Servicios de Salud. En 2020, se formalizó la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP), basada en los principios del MAIS, para promover la prevención y el manejo de la cronicidad en adultos mayores. Su implementación, liderada por Equipos Gestores, articula diversas líneas de acción en atención primaria y especializada. La población comprometida a ingresar corresponde a personas de 65 años y más, definidas según el avance progresivo de la estrategia y el consenso entre los Servicios de Salud y el Depto. de Desarrollo e Integración de DIVAP.

Este indicador se desarrolla en todos los Servicios de Salud, quienes en consenso con DIVAP, luego de un proceso de revisión de antecedentes, fijan una meta de ingresos de personas de 65 y más años a ECICEP. Para medir este indicador los ingresos registrados por REM, deben ser consistentes con los respectivos planes de cuidado.

Se considerará como línea Base los ingresos realizados a ECICEP el año anterior, la meta comprometida el año anterior, las líneas de acción desarrolladas desde los Servicios de Salud y la población de personas mayores a cargo para la definición de la población comprometida a ingresar.

2.2. Tasa de donantes efectivos en muerte encefálica por millón de población (PMP) generados por Servicio de Salud.

Este indicador mide la tasa de donantes efectivos a nivel nacional y por Servicio de Salud. Evalúa la cantidad de donantes efectivos en muerte encefálica, calculados por millón de habitantes y distribuidos según el desempeño de los Servicios de Salud. Se utiliza para medir la capacidad de los Servicios de Salud en la generación de donantes, proporcionando información clave para mejorar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplantes.

ID CG-SRA 15	Tasa de donantes efectivos en muerte encefálica por millón de población (PMP) generados por Servicio de Salud.				
DIGERA Unidad de Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos, Tejidos					
Objetivo del Indicador	Incrementar la disponibilidad de órganos sólidos para trasplantes en los establecimientos hospitalarios de la red asistencial, fortaleciendo el proceso de donación y procuramiento de órganos y tejidos.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número total de donantes efectivos en muerte encefálica generados por cada Servicio de Salud / Población censada según INE 2024 por Servicio de Salud) x 1.000.000				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Tasa	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	1 Decimal Truncado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	Tasa nacional y por Servicio de Salud de > 12 donantes efectivos en muerte encefálica pmp.				
Exclusiones	SS Arauco y Araucanía Norte no cumplen criterios para evaluación COMGES 2026.				
Fuente Numerador	SIDOT		Fuente Denominador	INE	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
$\geq 12,0$	4 puntos
$\geq 9,0$	3 puntos
$\geq 6,0$	2 puntos
$\geq 4,0$	1 punto
$< 4,0$	0 puntos

Definición de Términos

Potencial donante: Corresponde a todo posible donante que ha sido certificado en muerte encefálica o muerte por criterio neurológico.

Donante efectivo (DE): Es todo aquel potencial donante que hace ingreso a pabellón.

Consideraciones Técnicas

Los Servicios de Salud deben supervisar la existencia y/o facilitar la implementación de las siguientes medidas, orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del proceso de donación y procuramiento de órganos y tejidos en la red asistencial.

Diseñar y ejecutar un plan anual de capacitación anual en materias de donación, procuramiento y trasplante de órganos y tejidos, dirigido a profesionales médicos, enfermeras, kinesiólogos de las Unidades de Paciente Crítico (UPC), Unidad de Emergencia (EUH) y SAMU, así como a funcionarios del ámbito clínico en general.

Asegurar la disponibilidad de espacios físicos adecuados para la comunicación oportuna, confidencial y digna con las familias de potenciales donantes.

Desarrollar e implementar un plan de intervención que garantice la disponibilidad de quirófanos con atención 24/7 durante los 365 días del año, en hospitales generadores de donantes y en hospitales trasplantadores.

Ejecutar un plan de difusión comunitaria sobre la donación y el trasplante de órganos y tejidos, en coordinación con los Departamentos de Comunicaciones de los Servicios de Salud y establecimientos asistenciales de la red.

Se adjunta como anexo tabla con Líneas Base (LB) y metas de cumplimiento definidas para el año 2026, desagregadas por Servicio de Salud.

Para los Servicios de Salud Concepción, Biobío y Araucanía Sur, el cálculo de los indicadores se realizará considerando exclusivamente la población censada correspondientes a su red asistencial, conforme a la información de población censada según INE 2024.

Para efectos del cálculo de la tasa nacional se considera la población censada según INE 2024.

En conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.451, para el cálculo de la tasa de donantes efectivos se considerará el total de donantes efectivos gestionados por las Coordinaciones Locales de Procuramiento (CLP) que hayan desarrollado procesos de donación en establecimientos de salud privados de su red asistencial.

Anexo: Tasa de donantes efectivos en muerte encefálica por millón de población (PMP) generados por Servicios de Salud.

Servicios de Salud	Población censada según INE 2024	Número de donantes efectivos (Meta 2026)
SS Arica	244.569	3
SS Iquique	369.806	5
SS Antofagasta	635.416	8
SS Atacama	299.180	4
SS Coquimbo	832.864	11
SS Valparaíso San Antonio	510.450	7
SS Viña del Mar Quillota	1.118.288	15
SS Aconcagua	271.400	4
SS Metropolitano Norte	1.038.772	14
SS Metropolitano Occidente	1.253.896	16
SS Metropolitano Central	1.208.581	16
SS Metropolitano Oriente	1.335.563	17
SS Metropolitano Sur	1.215.861	16
SS Metropolitano Sur Oriente	1.352.868	18
SS O'Higgins	978.343	13
SS Maule	1.123.008	15
SS Ñuble	512.289	7
SS Concepción	684.517	9
SS Talcahuano	340.931	4
SS Biobío	421.380	6
SS Araucanía sur	803.777	10
SS Valdivia	398.230	5
SS Osorno	239.107	3
SS Del Reloncaví	474.312	6
SS Chiloé	176.865	2
SS Aysén	100.745	1
SS Magallanes	166.537	2

Compromiso de Gestión N°3: Gestión de los tiempos de espera.

Objetivo estratégico

"Disminuir los tiempos y priorizar la resolución de casos de pacientes con mayor antigüedad de espera en la atención a través de la optimización de la gestión de la demanda, el uso eficiente de los recursos y la implementación de estrategias innovadoras para la resolución oportuna de consultas y procedimientos."

Contexto

El objetivo de disminuir los tiempos de espera en la atención de salud se fundamenta en la necesidad de garantizar un acceso equitativo, oportuno y de calidad para toda la población. Este propósito se alinea con políticas públicas como la Ley N° 20.584 sobre derechos y deberes en salud, el Régimen General de Garantías en Salud (Ley N° 19.966) y los Objetivos Sanitarios 2030. A través de la optimización de la gestión de la demanda, el uso eficiente de los recursos y la implementación de estrategias innovadoras, se busca resolver consultas de especialidad y procedimientos quirúrgicos médicos y odontológicos de manera oportuna.

Optimización de la Atención Primaria y Especializada: Garantías GES y Reducción de Tiempos de Espera en Salud.

Fomento de la resolutiveidad en la Atención Primaria de Salud

La derivación de casos desde especialidades médicas hacia la Atención Primaria de Salud optimiza la gestión de la demanda al descongestionar los niveles secundarios y terciarios. Esto permite una atención más rápida y eficiente, especialmente en especialidades como oftalmología y dermatología, donde la demanda es alta, la estrategia de atención de especialidad en APS espera contribuir a la disminución de casos de la Lista de espera de consultas nuevas de especialidades médicas con destino APS en especialidades definidas.

La resolución de listas de espera en especialidades odontológicas como endodoncia, prótesis removible y periodoncia fortalece la capacidad resolutive de la APS, descongestionando los niveles secundarios y reduciendo los tiempos de espera para procedimientos especializados, ofreciendo una atención en los territorios.

Mejora en los tiempos para atención de especialidad e intervenciones quirúrgica

La reducción de la mediana de espera para consultas nuevas de especialidad médica y odontológica aborda la atención a aquellos casos que requieren una evaluación inicial para continuar su atención en los niveles de especialidad, refleja una gestión eficiente de la demanda, priorizando casos según su urgencia y optimizando el uso de los recursos disponibles en la Red Asistencial. La implementación de estrategias innovadoras, como la atención en horarios extendidos y el uso de tecnologías digitales, ha permitido reducir los tiempos de espera en especialidades odontológicas y médicas, mejorando la calidad de vida de los usuarios.

La disminución de la mediana de días de espera para intervenciones quirúrgicas se logra mediante la programación eficiente de quirófanos y la priorización de casos según su complejidad y prioridad, permitiendo una resolución más oportuna de procedimientos mayores y menores.

Por otro lado, aquellos casos con mayor tiempo de espera para consulta nueva de especialidad médica y odontológica deben ser priorizados y atendidos para dar continuidad a su atención, lo que se impulsa a través de la medición de la resolución de lista de espera del percentil 75 de consulta nueva de especialidad médica y odontológica, puesto que la atención prioritaria de casos en el percentil 75 de espera asegura que los pacientes con mayor tiempo en espera reciban atención oportuna, permitiendo atender casos con mayor espera de manera más rápida, utilizando estrategias como la redistribución de recursos, extensión horaria, promoviendo la equidad y optimizando la gestión de la demanda.

La priorización de intervenciones quirúrgicas mayores y menores en el percentil 75 reduce los tiempos de espera para pacientes con mayor antigüedad en la lista de espera, optimizando el uso de quirófanos y recursos humanos, por lo que la vigilancia de la resolución de lista de espera del percentil 75 de intervenciones quirúrgicas mayores y menores contribuirá a priorizar la atención en aquellas personas que llevan más tiempo esperando para atención secundaria, dando una solución a sus problemas de salud. Complementariamente la resolución de Lista de espera por intervenciones quirúrgicas menores electivas en establecimientos de baja complejidad, pretende descongestionar la espera para hospitales de mayor complejidad, permitiendo una atención más rápida y eficiente para procedimientos electivos en los establecimientos de menor complejidad. Por último, la disminución de casos en lista de espera para intervenciones quirúrgicas de incontinencia urinaria femenina responde a la necesidad de atender prioritariamente la salud de las mujeres, garantizando una atención oportuna y mejorando su calidad de vida.

Garantías Explícitas en Salud (GES)

El cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud (GES) asegura que los pacientes reciban atención dentro de plazos establecidos para cada problema de salud, optimizando los recursos disponibles y priorizando casos críticos. Este enfoque reduce significativamente los tiempos de espera para los problemas de salud que integran el GES.

La resolución de garantías GES exceptuadas transitorias sin prestación acumuladas, aborda aquellos casos pendientes por resolución, promoviendo la equidad en el acceso y reduciendo la acumulación de casos de espera de atención. Esto se logra mediante estrategias de priorización y gestión eficiente de los recursos.

Indicadores:

- 3.1. Cumplimiento de Garantías explícitas en Salud (GES) en la red.
- 3.2. Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad médica.
- 3.3. Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad odontológica.
- 3.4. Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de intervenciones quirúrgicas mayores y menores.
- 3.5. Resolución de Lista de espera de consultas nuevas de especialidades médicas con destino APS en especialidades definidas.
- 3.6. Resolución de Lista de espera de especialidades odontológicas de endodoncia, prótesis removible y periodoncia en atención primaria de salud.
- 3.7. Resolución de Lista de espera de intervenciones quirúrgicas menores electivas en atención primaria de salud.

3.1. Cumplimiento de Garantías explícitas en Salud (GES) en la red.

Este indicador mide el nivel del cumplimiento GES en la red a la Ley GES, según los problemas de salud y sus garantías definidas en el decreto vigente (N°29/2025). El no cumplimiento es falta a la normativa vigente, por lo que la red debe usar todos los espacios de gestión posibles para su resolución.

ID CG-SRA 78	Cumplimiento de Garantías explícitas en Salud (GES) en la red.				
DIGERA Departamento GES y Redes Complejas					
Objetivo del Indicador	Velar por el adecuado acceso y gestión para la entrega oportuna de las Garantías Explícitas en Salud.				
Responsable de gestión	Dirección del Establecimiento				
Fórmula de Cálculo	((Garantías Cumplidas + Garantías Exceptuadas + Garantías Incumplidas Atendidas) en el año t / (Garantías Cumplidas + Garantías Exceptuadas + Garantías Incumplidas Atendidas + Garantías Incumplidas No Atendidas) en el año t + Garantías Retrasadas acumuladas)) * 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	2 Decimal Truncado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100% de cumplimiento de Garantías explícitas en Salud (GES) en la red.				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SIGGES		Fuente Denominador	SIGGES	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥ 99,50%	4 puntos
< 99,50%	0 puntos

Requisitos

Disminución de Garantías Retrasadas del año 2025 o anteriores en un 100% (año anterior)

Definición de Términos

GES: Garantías Explícitas en Salud.

GO: Garantías de Oportunidad.

Garantías Cumplidas: En esta agrupación se consideran las garantías realizadas dentro del plazo máximo que señala el decreto.

Garantías Exceptuadas: podrán exceptuarse de dar cumplimiento a una garantía de oportunidad (Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos, Superintendencia de Salud), cuando por causa imputable al beneficiario o por fuerza mayor derivada de su estado de salud, sea imposible otorgar la prestación en el plazo establecido, dando lugar a una nueva gestión del caso.

Garantías Incumplidas Atendidas: es aquella garantía de oportunidad realizada fuera del plazo garantizado para cada problema de salud incluido en GES.

Garantías Incumplida No atendida: El establecimiento no logró realizar la atención garantizada dentro de los tiempos establecidos, y es imposible entregarla en forma tardía por una condición o decisión del paciente.

Garantías Retrasadas Acumuladas: Corresponde a aquellas que no evidencian en SIGGES una atención, ya sea por no registro de esta o por no realización de la prestación.

Consideraciones Técnicas

El universo considera las garantías acumuladas del mes de enero al corte, en este caso de enero a diciembre, salvo las garantías retrasadas que considera el acumulado total (incluye años anteriores).

El monitoreo para la gestión es directo de la plataforma SIGGES, es diario con reportería actualizada, por lo que la oportunidad del registro impacta directo al cumplimiento de este indicador.

Es importante señalar que para lograr buen cumplimiento se deben gestionar las garantías de oportunidad desde su estado de vigencia, es decir, las que se encuentren dentro del plazo garantizado.

La medición se realiza mensualmente desde el nivel central. FONASA entrega la información a DIGERA cada mes, y esta es puesta a disposición de la red a través de carpetas compartidas.

En la evaluación final, se puede apelar casos retrasados por causas externas, las cuales se nombran a continuación:

- Falta de causal de excepción en la normativa de la SIS
- Falta de causal de cierre de garantía
- Errores del sistema SIGGES.
- Estas apelaciones serán revisadas por los referentes técnicos para su aceptación o rechazo.
- El universo considera las garantías acumuladas desde enero hasta el corte, excepto las garantías retrasadas, que incluyen acumulados de años anteriores.

Proceso:

- 1.FONASA envía a Referente Registro SIGGES de DIGERA el corte oficial de GO Retrasada, archivo excel (21 de cada mes, calendario definido por FONASA).
- 2.Ref.Registro SIGGES de DIGERA envía por mail (archivo excel) a Referente SIGGES de SS el corte oficial de GO retrasadas.
- 3.Posterior a esto, FONASA envía BBDD de cumplimiento a Referente Registro SIGGES de DIGERA (archivo excel).
- 4.Ref. Registro SIGGES de DIGERA analiza y elabora archivo final con el cumplimiento GES que disponibiliza en carpetas compartidas a los Referente SIGGES de SS (se envía mail a la red con esta información)

3.2. Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad médica.

Este indicador mide el porcentaje de casos disminuidos de lista de espera para CNE, sobre el percentil 75. De acuerdo con línea base establecida al corte del 31 de diciembre de 2025.

ID CG-SRA 81	Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad médica				
DIGERA Departamento de Análisis e Información para la Gestión					
Objetivo del Indicador	Evaluar la disminución de los casos de mayor antigüedad en lista de espera para consulta nueva de especialidad.				
Responsable de gestión	Dirección del Establecimiento				
Fórmula de Cálculo	(Número de casos disminuidos de la Lista de Espera para CNE médica sobre el percentil 75 / Número total de casos en la Lista de Espera para CNE médica sobre el percentil 75) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	Disminuir el 95,0% de los casos del percentil 75 de antigüedad.				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	SIGTE	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥ 95,0%	4 puntos
≥ 80,0%	3 puntos
≥ 70,0%	2 puntos
≥ 60,0%	1 punto
< 60,0%	0 puntos

Definición de Términos

Listas de Espera: Es el registro con los casos de todas las personas que han recibido indicación de atención, sea esta para: consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica; realización de procedimiento en atención especializada; intervención quirúrgica mayor y/o menor programada. Las que deben ser otorgadas por un profesional autorizado para su ejercicio en la red asistencial, teniendo documentada la solicitud de atención en el formulario correspondiente. La inclusión en el registro debe considerar a todas las personas, aun cuando la atención requerida no forme parte de

la cartera de servicios del establecimiento de referencia, en cuyo caso, el gestor de red debe resolver, en primera instancia, a través de la oferta de su red, o en su defecto, mediante la gestión con otras redes.

SIGTE: Nombre que recibe el “Sistema Informático de Gestión de Tiempos de Espera”, provisto por MINSAL, y que contiene los datos de registro disponibles y en línea de las listas de Espera de consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, de intervenciones quirúrgicas mayores y menores electivas, y otras que se definan.

Fecha de entrada: Corresponde a la fecha de indicación de la atención, la que es realizada por el médico u otro profesional autorizado y que es documentada en el formulario correspondiente. Esta fecha de indicación será válida tanto para las indicaciones provenientes desde APS, como niveles secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de Servicio de Salud.

Causal de egreso: Indica la causal de salida de la Lista de Espera de un paciente, definidas según Norma Técnica N°118 del año 2011 y sus actualizaciones.

Anualidad: Término utilizado para referirse al año de entrada de los casos de las personas que se encuentran en listas de espera registradas en SIGTE.

Consideraciones Técnicas

Se entregará línea de base y meta de resolución anual calculados con la totalidad de casos incluidos en el corte del 31 de diciembre 2025. Se consideran para evaluación egresos por todas las causales.

El calendario de corte de información será entregado dentro del primer semestre del año 2026.

La fuente oficial para trabajar estos indicadores es el SIGTE. El cumplimiento del trabajo realizado para los COMGES se encuentra bajo el marco normativo vigente de gestión de Listas de Espera no GES, exigiendo la veracidad, oportunidad y completitud de la información declarada en SIGTE y sus respectivos respaldos de gestión.

Los traslados coordinados, los casos en casuales 3 y las postergaciones vigentes al cierre del trimestre, se descuentan específicamente en corte a evaluar. Se realizará un monitoreo mensual en base a los registros y los resultados obtenidos.

Medio de Verificación: Registro SIGTE

Responsable de Medio de Verificación: Unidad de gestión de información DIGERA

Fecha de entrega de Medio de Verificación: Corte Oficial de SIGTE, último día del mes posterior al corte

Medio de envío de Medio de Verificación: BBDD compartida, publicación en Visor gestor.

El cumplimiento de este indicador considera las regularizaciones de registro posteriores a la elaboración de la línea de base, que cumplan con el criterio de antigüedad definido para cada Servicio de Salud, lo que no implicará una modificación de la Línea de Base, siendo la fecha límite el criterio guía.

3.3. Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad odontológica.

Este indicador mide el porcentaje de casos disminuidos de lista de espera para CNE odontológica sobre el percentil 75, de acuerdo a línea base establecida al corte del 31 de diciembre de 2025.

ID CG-SRA 82	Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad odontológica				
DIGERA Departamento de Análisis e Información para la Gestión					
Objetivo del Indicador	Evaluar la disminución de los casos de mayor antigüedad en lista de espera para consulta nueva de especialidad odontológica.				
Responsable de gestión	Jefes de Servicios Clínicos del Establecimiento				
Fórmula de Cálculo	((Número de casos disminuidos de la Lista de Espera para CNE odontológica (excluyendo ortodoncia) sobre el percentil 75 del corte del 31 de diciembre 2025 + Número de casos disminuidos de la Lista de Espera para CNE de ortodoncia sobre el percentil 75 del corte del 31 de diciembre 2025))/((Número total de casos en la Lista de Espera para CNE odontológica (excluyendo ortodoncia) sobre el percentil 75 al corte del 31 de diciembre 2025 + Número total de casos en la Lista de Espera para CNE ortodoncia sobre el percentil 75 al corte del 31 de diciembre 2025)) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	Disminuir el 95,0% de los casos del percentil 75 de antigüedad				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	SIGTE	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥ 95,0%	4 puntos
≥ 80,0%	3 puntos
≥ 70,0%	2 puntos
≥ 60,0%	1 punto
< 60,0%	0 puntos

Definición de Términos

Listas de Espera: Es el registro con los casos de todas las personas que han recibido indicación de atención, sea esta para: consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica; realización de procedimiento en atención especializada; intervención quirúrgica mayor y/o menor programada. Las que deben ser otorgadas por un profesional autorizado para su ejercicio en la red asistencial,

teniendo documentada la solicitud de atención en el formulario correspondiente. La inclusión en el registro debe considerar a todas las personas, aun cuando la atención requerida no forme parte de la cartera de servicios del establecimiento de referencia, en cuyo caso, el gestor de red debe resolver, en primera instancia, a través de la oferta de su red, o en su defecto, mediante la gestión con otras redes.

SIGTE: Nombre que recibe el “Sistema Informático de Gestión de Tiempos de Espera”, provisto por MINSAL, y que contiene los datos de registro disponibles y en línea de las listas de Espera de consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, de intervenciones quirúrgicas mayores y menores electivas, y otras que se definan.

Fecha de entrada: Corresponde a la fecha de indicación de la atención, la que es realizada por el médico u otro profesional autorizado y que es documentada en el formulario correspondiente. Esta fecha de indicación será válida tanto para las indicaciones provenientes desde APS, como niveles secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de Servicio de Salud.

Causal de egreso: Indica la causal de salida de la Lista de Espera de un paciente, definidas según Norma Técnica N°118 del año 2011 y sus actualizaciones.

Anualidad: Término utilizado para referirse al año de entrada de los casos de las personas que se encuentran en listas de espera registradas en SIGTE.

Consideraciones Técnicas

Se entregará línea de base y meta de resolución anual. Se consideran para evaluación egresos por todas las causales.

El calendario de corte de información será entregado dentro del primer semestre del año 2026. La fuente oficial para trabajar estos indicadores es el SIGTE. El cumplimiento del trabajo realizado para los COMGES se encuentra bajo el marco normativo vigente de gestión de Listas de Espera no GES, exigiendo la veracidad, oportunidad y completitud de la información declarada en SIGTE y sus respectivos respaldos de gestión. Los traslados coordinados, los casos en casuales 3 y las postergaciones vigentes al cierre del trimestre, se descuentan específicamente en corte a evaluar. Se realizará un monitoreo mensual en base a los registros y los resultados obtenidos.

El medio de verificación es Registro SIGTE.

La fecha de entrega del Medio de Verificación va en concordancia con el Corte Oficial de SIGTE, que es el último día del mes posterior al corte.

La forma de envío del Medio de Verificación es a través de la Base de Datos compartida, el resumen de indicadores de Lista de Espera y la publicación de datos en Visor Gestor.

El responsable del Medio de Verificación es la Unidad de Gestión de Información DIGERA.

El cumplimiento de este indicador considera las regularizaciones de registro posteriores a la elaboración de la línea de base, que cumplan con el criterio de antigüedad definido para cada Servicio de Salud, lo que no implicará una modificación de la Línea de Base, siendo la fecha límite el criterio guía.

3.4. Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de intervenciones quirúrgicas mayores y menores.

Este indicador mide el porcentaje de casos disminuidos de lista de espera para intervenciones quirúrgicas mayores y menores, sobre el percentil 75, de acuerdo con línea base establecida al corte del 31 de diciembre de 2025.

ID CG-SRA 83	Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de intervenciones quirúrgicas mayores y menores				
DIGERA Departamento de Análisis e Información para la Gestión					
Objetivo del Indicador	Evaluar la disminución de los casos de mayor antigüedad en lista de espera para intervenciones quirúrgicas mayores y menores.				
Responsable de gestión	Subdirección Médica del Establecimiento				
Fórmula de Cálculo	(Número de casos resueltos de la Lista de Espera de intervenciones quirúrgicas electivas mayores y menores pertenecientes al percentil 75 / Número total de casos en la Lista de Espera de intervenciones quirúrgicas electivas mayores y menores pertenecientes al percentil 75) x 100.				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	Disminuir el 95,0% de los casos del percentil 75 de antigüedad				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	SIGTE	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥ 95,0%	4 puntos
≥ 80,0%	3 puntos
≥ 70,0%	2 puntos
≥ 60,0%	1 punto
< 60,0%	0 puntos

Definición de Términos

Listas de Espera: Es el registro con los casos de todas las personas que han recibido indicación de atención, sea esta para: consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica; realización de procedimiento en atención especializada; intervención quirúrgica mayor y/o menor programada. Las que deben ser otorgadas por un profesional autorizado para su ejercicio en la red asistencial, teniendo documentada la solicitud de atención en el formulario correspondiente. La inclusión en el registro debe considerar a todas las personas, aun cuando la atención requerida no forme parte de la cartera de servicios del establecimiento de referencia, en cuyo caso, el gestor de red debe resolver,

en primera instancia, a través de la oferta de su red, o en su defecto, mediante la gestión con otras redes.

SIGTE: Nombre que recibe el “Sistema Informático de Gestión de Tiempos de Espera”, provisto por MINSAL, y que contiene los datos de registro disponibles y en línea de las listas de Espera de consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, de intervenciones quirúrgicas mayores y menores electivas, y otras que se definan.

Fecha de entrada: Corresponde a la fecha de indicación de la atención, la que es realizada por el/la médico/a u otro/a profesional autorizado/a y que es documentada en el formulario correspondiente. Esta fecha de indicación será válida tanto para las indicaciones provenientes desde APS, como niveles secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de Servicio de Salud.

Causal de Egreso: Indica la causal de salida de la Lista de Espera de un paciente, definidas según Norma Técnica N°118 del año 2011 y sus actualizaciones.

Anualidad: Término utilizado para referirse al año de entrada de los casos de las personas que se encuentran en listas de espera registradas en SIGTE.

Consideraciones Técnicas

Se entregará línea de base y meta de resolución anual. Se consideran para evaluación egresos por todas las causales.

El calendario de corte de información será entregado dentro del primer semestre del año 2026.

La fuente oficial para trabajar estos indicadores es el SIGTE.

El cumplimiento del trabajo realizado para los COMGES se encuentra bajo el marco normativo vigente de gestión de Listas de Espera no GES, exigiendo la veracidad, oportunidad y completitud de la información declarada en SIGTE y sus respectivos respaldos de gestión.

Los traslados coordinados, los casos en casuales 3 y las postergaciones vigentes al cierre del trimestre, se descuentan específicamente en corte a evaluar.

Se realizará un monitoreo mensual en base a los registros y los resultados obtenidos.

El medio de verificación es Registro SIGTE.

La fecha de entrega del Medio de Verificación va en concordancia con el Corte Oficial de SIGTE, que es el último día del mes posterior al corte.

La forma de envío del Medio de Verificación es a través de la Base de Datos compartida, el resumen de indicadores de Lista de Espera y la publicación de datos en Visor Gestor.

El responsable del Medio de Verificación es la Unidad de Gestión de Información DIGERA.

El cumplimiento de este indicador considera las regularizaciones de registro posteriores a la elaboración de la línea de base, que cumplan con el criterio de antigüedad definido para cada Servicio de Salud, lo que no implicará una modificación de la Línea de Base, siendo la fecha límite el criterio guía.

3.5. Resolución de Lista de espera de consultas nuevas de especialidades médicas con destino APS en especialidades definidas.

Mide la reducción de casos en la lista de espera de consultas nuevas de especialidades médicas con destino APS, evaluando la capacidad de respuesta de las especialidades definidas. Se promueve la equidad en el acceso y tiempos de espera dignos para los pacientes.

ID CG-SRA 52	Resolución de Lista de espera de consultas nuevas de especialidades médicas con destino APS en especialidades definidas.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Disminuir los casos en Lista de Espera para consultas nuevas de especialidades médicas con destino APS en especialidades definidas.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Casos disminuidos de la lista de espera de CNE médicas con destino APS en especialidades definidas, ingresados con fecha igual o anterior 31 de diciembre de año 2025 / Casos comprometidos a disminuir de la lista de espera de CNE médicas con destino APS) x 100.				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100% de la meta definida				
Exclusiones	APS sin exclusiones				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	SIGTE	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
100,0%	4 puntos
≥75,0%	3 puntos
≥50,0%	2 puntos
≥25,0%	1 punto
<25,0%	0 puntos

Definición de Términos

Listas de Espera: Es el registro con los casos de todas las personas que han recibido indicación de atención, sea esta para: consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica; realización de procedimiento en atención especializada; intervención quirúrgica mayor y/o menor programada. Las que deben ser otorgadas por un profesional autorizado para su ejercicio en la red asistencial, teniendo documentada la solicitud de atención en el formulario correspondiente. La inclusión en el

registro debe considerar a todas las personas, aún cuando la atención requerida no forme parte de la cartera de servicios del establecimiento de referencia, en cuyo caso, el gestor de red debe resolver, en primera instancia, a través de la oferta de su red, o en su defecto, mediante la gestión con otras redes.- SIGTE: Nombre que recibe el “Sistema Informático de Gestión de Tiempos de Espera”, provisto por MINSAL, y que contiene los datos de registro disponibles y en línea de las listas de Espera de consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, de intervenciones quirúrgicas mayores y menores electivas, y otras que se definan.- Fecha de entrada: Corresponde a la fecha de indicación de la atención, realizada por el médico u otro profesional autorizado y que es documentada en el formulario correspondiente. Esta fecha de indicación será válida tanto para las indicaciones provenientes desde APS, como niveles secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de Servicio de Salud.- Causal de Egreso: Indica la causal de salida de la Lista de Espera de un paciente, definidas según Norma Técnica N°118 del año 2011 y sus actualizaciones.- Anualidad: Término utilizado para referirse al año de entrada de los casos de las personas que se encuentran en listas de espera registradas en SIGTE.

Consideraciones Técnicas

Especialidades definidas:

Oftalmología, Ginecología (Climaterio), Otorrinolaringología y Dermatología.

Cada establecimiento debe revisar su oferta y redestinar a nivel de atención que corresponda en caso de no contar con la prestación demandada.

3.6. Resolución de Lista de espera de especialidades odontológicas de endodoncia, prótesis removible y periodoncia en atención primaria de salud.

Evalúa los egresos de lista de espera de las especialidades de endodoncia, prótesis removible y periodoncia, realizados por APS. Refleja la gestión de APS en la resolución de casos mediante los recursos que se otorgan vía PRAPS de Estrategias de Salud Bucal, considerando además criterio de antigüedad.

ID CG-SRA 53	Resolución de Lista de espera de especialidades odontológicas de endodoncia, prótesis removible y periodoncia en atención primaria de salud.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Resolver casos en espera de atención de Especialidad Odontológica (endodoncia, prótesis removible y periodoncia) ingresados a Sistema Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), mediante utilización de Programas de Reforzamiento de Estrategias de Salud Bucal				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Casos egresados por APS en odontología (endodoncia, prótesis removible y periodoncia) ingresados a LE desde 2026 hacia atrás / Capacidad resolutoria vía PRAPS comprometida) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100% del cumplimiento de la meta comprometida por cada Servicio de Salud.				
Exclusiones	Egresos de lista de espera de las especialidades de prótesis removible, endodoncia, periodoncia realizados en nivel secundario.				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	LOCAL	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
= 100,0%	4 puntos
≥75,0%	3 puntos
≥50,0%	2 puntos
≥25,0%	1 punto
<25,0%	0 puntos

Definición de Términos

LE: Lista de Espera.

PRAPS: Programa de Reforzamiento de la APS.

Capacidad de resolución: capacidad de egresar casos de LE con los recursos asignados vía PRAPS.

Consideraciones Técnicas

Los egresos considerados son los que se realizan por establecimientos que reciben financiamiento del Programa de Reformazamiento de la APS para resolutiveidad de especialidades de prótesis removible, endodoncia, periodoncia. Se consideran todas las causales de egreso.

Se consideran egresos válidos para los casos que ingresaron a lista de espera hasta el 31 de diciembre del 2026.

Los egresos son los que se reportan vía SIGTE, para las especialidades de endodoncia código SIGTE 09 003, prótesis removible código SIGTE 09 011 y periodoncia código SIGTE 09 010.

Las metas son diferenciadas por Servicios de Salud.

3.7. Resolución de Lista de espera de intervenciones quirúrgicas menores electivas en atención primaria de salud.

Mide la reducción de casos en la lista de espera de intervenciones quirúrgicas menores, evaluando la capacidad de respuesta. Se promueve la equidad en el acceso y tiempos de espera dignos para los pacientes.

ID CG-SRA 56	Resolución de Lista de espera de intervenciones quirúrgicas menores electivas en atención primaria de salud.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Disminuir los casos en Lista de Espera para intervenciones quirúrgicas menores electivas en establecimientos de atención primaria de salud.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de casos disminuidos de la Lista de espera de intervenciones quirúrgicas menores electivas del universo establecido / Número total de casos comprometidos) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100% de la meta definida.				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	SIGTE	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
100,0%	4 puntos
≥90,0%	3 puntos
≥80,0%	2 puntos
≥70,0%	1 punto
<70,0%	0 puntos

Definición de Términos

Listas de Espera: Es el registro con los casos de todas las personas que han recibido indicación de atención, sea esta para: consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica; realización de procedimiento en atención especializada; intervención quirúrgica mayor y/o menor programada. Las atenciones deben ser otorgadas por un profesional autorizado para su ejercicio en la red asistencial, teniendo documentada la solicitud de atención en el formulario correspondiente. La inclusión en el registro debe considerar a todas las personas, aun cuando la atención requerida no forme parte de la cartera de servicios del establecimiento de referencia, en cuyo caso, el gestor de red debe resolver,

en primera instancia, a través de la oferta de su red, o en su defecto, mediante la gestión con otras redes.

SIGTE: Nombre que recibe el “Sistema de Información de Gestión de Tiempos de Espera”, provisto por MINSAL, y que contiene los datos de registro disponibles y en línea de las listas de espera de consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, de intervenciones quirúrgicas mayores y menores electivas, y otras que se definan.

Fecha de entrada: Corresponde a la fecha de indicación de la atención, la que es realizada por el médico u otro profesional autorizado y que es documentada en el formulario correspondiente. Esta fecha de indicación será válida tanto para las indicaciones provenientes desde APS, como niveles secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de Servicio de Salud.

Causal de Egreso: Indica la causal de salida de la lista de espera de un paciente, definidas según Norma Técnica N°118 del año 2011 y sus actualizaciones.

Anualidad: Término utilizado para referirse al año de entrada de los casos de las personas que se encuentran en listas de espera registradas en SIGTE.

Consideraciones Técnicas

Cada servicio debe revisar su oferta para redestinar al nivel que corresponde, en caso de no contar con la prestación que se demanda.

Universo Establecido: Corresponde a todos los casos ingresados con fecha igual o anterior al 31 de diciembre del año 2025.

Compromiso de Gestión N°4: Gestión de Riesgos, Recursos Humanos y financieros.

Objetivo estratégico

“Mejorar la planificación y uso eficiente de los recursos humanos y financieros en la Red Asistencial, asegurando su disponibilidad, distribución equitativa y sustentabilidad en el tiempo para garantizar una atención de calidad, en ambientes laborales libres de violencia”.

Contexto

El fortalecimiento de la Red Asistencial en Chile requiere una gestión estratégica que optimice los recursos humanos y financieros, asegurando su distribución equitativa y sustentabilidad. Este enfoque está alineado con políticas públicas como la Ley N° 19.937 sobre Autoridad Sanitaria y Gestión, la Política Nacional de Salud y los Objetivos Sanitarios 2030. Además, se busca garantizar ambientes laborales libres de violencia, promoviendo el bienestar del personal de salud y la calidad de la atención.

Planificación y uso eficiente de los recursos

La planificación presupuestaria y el seguimiento de costos de producción son esenciales para garantizar la eficiencia financiera en la Red Asistencial. Este proceso está regulado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda y permite identificar áreas de mejora en la asignación de recursos, asegurando su uso sustentable y equitativo, es por lo anterior que el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los informes de planificación presupuestaria y seguimiento de los costos de producción, contribuyen a garantizar la eficiencia financiera de la Red. Por otro lado, el uso del Sistema de Gestión de Costos (SIGCOM) permite monitorear y evaluar el desempeño financiero de los establecimientos hospitalarios. La validación de reportes cubo 9 asegura la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos, contribuyendo a la sustentabilidad del sistema, por lo que se impulsa a través de la medición de los Establecimientos hospitalarios con reportes cubo 9 de SIGCOM validados.

Por último y con el fin de disponer de equipamiento médico, infraestructura, ambulancias y equipos industriales en buenas condiciones, es que la implementación y ejecución de planes de mantenimiento preventivo asegura la continuidad operativa de los equipos críticos, reduciendo costos asociados a reparaciones y fallas, lo que se medirá a través del indicador de ejecución del Plan anual de mantenimiento preventivo de equipos médicos, infraestructura, ambulancias y equipos industriales.

Gestión de Riesgo de Desastres en la Red Asistencial

La gestión del riesgo de desastres en hospitales fortalece la resiliencia del sistema de salud, garantizando la continuidad de los servicios en situaciones de emergencia. Este enfoque está respaldado por la Ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante

Desastres, por lo que se medirá a los Hospitales con implementación de Gestión del Riesgo de Desastres.

Recursos humanos en salud

El personal de salud es fundamental para el funcionamiento y la efectividad del sistema de salud, el monitoreo del ausentismo laboral permite identificar factores que afectan la productividad y el bienestar del personal de salud, el seguimiento del ausentismo a través del índice de ausentismo laboral por Licencia médica curativa permite implementar estrategias de prevención y apoyo biopsicosocial en el personal de salud. Además, este año se agrega la confección de un plan de ausentismo con enfoque de género. Este enfoque busca reconocer y abordar las diferencias en los factores que inciden en el ausentismo laboral entre hombres y mujeres, considerando variables como la doble carga laboral, las responsabilidades de cuidado y las condiciones particulares de trabajo. La implementación de un plan con perspectiva de género permitirá desarrollar estrategias de apoyo más equitativas, promoviendo un ambiente laboral inclusivo y con mayores oportunidades para todos los trabajadores de la salud.

El control del gasto en convenios con personal naturales asegura la eficiencia financiera y la correcta asignación de recursos en la Red Asistencial. El Índice del gasto en convenio con personas naturales respecto a la glosa autorizada vigente, se vincula a los lineamientos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Ministerio de Hacienda para evaluar la eficiencia del gasto y si se está cumpliendo lo previsto.

En el contexto del convenio 190 de la OIT, sobre violencia y acoso en el trabajo, el seguimiento de los Procedimientos disciplinarios por VALS cerrados en los plazos estipulados por ley garantiza la transparencia y el respeto al debido proceso, contribuyendo al respeto de los derechos del personal de salud.

Indicadores:

Compromiso de Gestión N°4: Gestión de Riesgos, Recursos Humanos y financieros

- 4.1. Ejecución de actividades al proceso de planificación, ejecución y monitoreo presupuestario.
- 4.2. Implementación del plan gestión del riesgo de desastres.
- 4.3. Índice del gasto en convenio con personas naturales respecto a la glosa autorizada vigente.

4.1. Ejecución de actividades al proceso de planificación, ejecución y monitoreo presupuestario.

Este indicador mide el cumplimiento de requisitos exigidos a los Servicios de Salud asociados al proceso de planificación y monitoreo de la ejecución presupuestaria.

ID CG-SRA 153	Ejecución de actividades al proceso de planificación, ejecución y monitoreo presupuestario				
PRESUPUESTO Departamento de Gestión Presupuestaria					
Objetivo del Indicador	Evaluar el nivel gestión de las actividades asociadas al proceso de planificación presupuestaria, ejecución y monitoreo del gasto, que facilite la toma de decisiones y la asignación eficiente de recursos.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(puntaje obtenido en gestiones ejecutadas al corte/ puntaje asociado a las gestiones planificadas al corte) x100 Se adjuntará rúbrica con cada una de las gestiones y puntaje que se asigna				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100 puntos				
Exclusiones	Excluye CRS Maipú y CRS Cordillera				
Fuente Numerador	Datos con Validación de Nivel Central		Fuente Denominador	Datos con Validación de Nivel Central	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥ 80,0%	4 puntos
≥70,0%	3 puntos
≥60,0%	2 puntos
≥50,0%	1 punto
<50,0%	0 puntos

Requisitos

Los requisitos exigidos son:

1. Actividades que respalden la Planificación presupuestaria del 2026 del Servicio de Salud.
2. Entrega de informes mensuales de ejecución presupuestaria, diferenciando entre deuda de arrastre y gasto operacional.
3. Entrega de reporte de rotación de inventario mensual.
4. Revisión del listado de facturas pendientes de devengo
5. Estado de regularización de la deuda de arrastre de periodos anteriores.
6. Avances en la interoperabilidad de bodegas con CENABAST.
7. Todos los establecimientos habilitados en el sistema de costos deben contar con los 12 reportes del año validados al cierre del indicador.

Definición de Términos

Los establecimientos y los Servicios de Salud, considerando sus proyecciones operacionales y compromisos vigentes, el cual es utilizado por los directivos de distintos niveles y entidades para estimar los recursos necesarios para la continuidad operacional. Este proceso se rige por lineamientos orientados a asegurar coherencia entre la programación asistencial y la disponibilidad financiera, priorizando gastos legales e ineludibles, la eficiencia en el uso de los recursos y la trazabilidad de las decisiones presupuestarias, en concordancia con la normativa vigente y los objetivos sanitarios definidos por la autoridad.

Deuda de arrastre: Obligaciones pendientes de pago correspondientes a ejercicios presupuestarios anteriores que no fueron regularizadas en su período de origen. Su adecuada identificación y control constituye un eje central de la planificación presupuestaria, dado su impacto directo en el presupuesto del ejercicio en curso, debiendo ser gestionada bajo criterios de priorización, antigüedad y continuidad operacional, conforme a los lineamientos de sostenibilidad financiera del sector.

SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado): Plataforma oficial de registro, ejecución y seguimiento presupuestario y contable de las instituciones públicas. Su utilización permite asegurar la consistencia, oportunidad y trazabilidad de la información financiera, constituyéndose como la base para el control presupuestario, la toma de decisiones y la rendición de cuentas ante los organismos de control.

Subtítulo 22: Clasificación presupuestaria correspondiente a Bienes y Servicios de Consumo. Incluye gastos operacionales como insumos, arriendos, servicios básicos, mantenciones, contratos de servicios y otros gastos corrientes, los cuales deben ser planificados bajo criterios de eficiencia, priorización de gastos ineludibles y coherencia con la programación asistencial, conforme a los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Consideraciones Técnicas

El objetivo es evaluar las actividades asociadas al ciclo de planificación y seguimiento de la ejecución presupuestaria. Para ello se han definido 6 hitos de trabajo, con actividades específicas, anuales o mensuales que serán evaluadas de acuerdo con su nivel de completitud, cuyo puntaje se detalla en la siguiente tabla:

PAUTA DE EVALUACIÓN		Puntaje	Mes de corte evaluación	100% del puntaje	50% del puntaje	0% del puntaje
1.	Planificación presupuestaria	34				
1.1	Informe cualitativo consolidado por Servicio de Salud	14	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.2	Planificación presupuestaria	11	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.3	Asco	1	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.4	Vigilancia	1	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.5	Vencimiento garantía de equipos	1	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.6	Mantenimiento e infraestructura	1	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.7	Alimentación funcionarios	1	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.8	Arriendo de inmuebles	1	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.9	Fármacos	1	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.10	Reporte rotación de inventario	1	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
1.11	Compras de servicios	1	Marzo	Entrega completa	Entrega incompleta	No entrega
2.	Informes mensuales de ejecución presupuestaria	10				
2.1	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes marzo	1	Abril	Entrega completa	N/A	No entrega
2.2	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes abril	1	Mayo	Entrega completa	N/A	No entrega
2.3	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes mayo	1	Junio	Entrega completa	N/A	No entrega
2.4	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes junio	1	Julio	Entrega completa	N/A	No entrega
2.5	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes julio	1	Agosto	Entrega completa	N/A	No entrega
2.6	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes agosto	1	Septiembre	Entrega completa	N/A	No entrega
2.7	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes septiembre	1	Octubre	Entrega completa	N/A	No entrega
2.8	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes octubre	1	Noviembre	Entrega completa	N/A	No entrega
2.9	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes noviembre	1	Diciembre	Entrega completa	N/A	No entrega
2.10	Reporte deuda de arrastre/gasto operacional mes diciembre	1	Enero	Entrega completa	N/A	No entrega
3.	Rotación de inventario	10				
3.1	Reporte rotación de inventario mes marzo	1	Abril	Entrega completa	N/A	No entrega
3.2	Reporte rotación de inventario mes abril	1	Mayo	Entrega completa	N/A	No entrega
3.3	Reporte rotación de inventario mes mayo	1	Junio	Entrega completa	N/A	No entrega
3.4	Reporte rotación de inventario mes junio	1	Julio	Entrega completa	N/A	No entrega
3.5	Reporte rotación de inventario mes julio	1	Agosto	Entrega completa	N/A	No entrega
3.6	Reporte rotación de inventario mes agosto	1	Septiembre	Entrega completa	N/A	No entrega
3.7	Reporte rotación de inventario mes septiembre	1	Octubre	Entrega completa	N/A	No entrega
3.8	Reporte rotación de inventario mes octubre	1	Noviembre	Entrega completa	N/A	No entrega
3.9	Reporte rotación de inventario mes noviembre	1	Diciembre	Entrega completa	N/A	No entrega
3.10	Reporte rotación de inventario mes diciembre	1	Enero	Entrega completa	N/A	No entrega
4.	Revisión de listados de facturas pendientes de devengo	16				
4.1	Listado DTE acumulado a marzo	4	Abril	Entrega completa	N/A	No entrega
4.2	Listado DTE acumulado a junio	4	Julio	Entrega completa	N/A	No entrega
4.3	Listado DTE acumulado a septiembre	4	Octubre	Entrega completa	N/A	No entrega
4.4	Listado DTE acumulado a diciembre	4	Enero	Entrega completa	N/A	No entrega
5.	Regularización de un 90% a marzo del devengo de la deuda de arrastre	20				
5.1	% Devengo deuda de arrastre	20	Abril	Devengo de más del 90% de la deuda de arrastre	Devengo entre el 80% y 89% de la deuda de arrastre	Devengo de menos del 80% de la deuda de arrastre
6.	Interoperabilidad bodegas con CENABAST	10				
6.1	Establecimientos independientes y dependientes deben contar con los visores conectados con CENABAST	10	Diciembre	Cumple con la totalidad de visores (Independientes y Dependientes)	Cumplimiento parcial	Sin Visores, ningún establecimiento
TOTAL PUNTAJE		100				

4.2. Implementación del plan gestión del riesgo de desastres.

Este indicador busca mejorar el nivel de gestión del riesgo de desastre, tanto en los Servicios de Salud, como en los Hospitales, conociendo las capacidades actualizadas y los distintos planes con que cuentan los establecimientos. Así también relevar la importancia de asignar al personal correspondiente para este tipo de acciones.

ID CG-SRA 50	Implementación del plan gestión del riesgo de desastres				
GABINETE MINISTRO(A) División de Emergencias Sanitarias					
Objetivo del Indicador	Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios de Salud y Hospitales de la Red.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de hospitales que cumplen con la implementación de las acciones de gestión del riesgo de desastres / total de hospitales del Servicio de Salud) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100% de establecimientos con acciones cumplidas en gestión del riesgo de desastres.				
Exclusiones	Otro tipo de establecimientos que no sean Hospitales				
Fuente Numerador	LOCAL		Fuente Denominador	LOCAL	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
100%	4 puntos
≥90%	3 puntos
≥80%	2 puntos
≥70%	1 punto
<70%	0 puntos

Requisitos

Entregar un informe de avance que indique el cumplimiento las siguientes 2 acciones en el 100% de los hospitales del Servicio de Salud.

1. Servicios de Salud y Hospitales con Encargado de Gestión del Riesgo de Desastre.
2. Servicios de Salud y Hospitales con Plan de Respuesta actualizado.

El primer informe debe entregarse antes de finalizado el mes de junio de 2026, enviado vía correo electrónico al Referente Técnico MINSAL, con copia a Control De Gestión de la SRA. El segundo

informe debe ser entregado antes de finalizado el mes de noviembre de 2026, vía correo electrónico al Referente Técnico con copia a Control De Gestión de la SRA.

Verificables solicitados para el requisito:

1. Resoluciones con nombramientos de encargados para GRD, desde Director del Hospital y de Servicio de Salud con fecha de corte al 30/10/2026.
2. Resoluciones con planes de Respuesta con nuevo formato enviado el 2025, desde Director del Hospital y de Servicio de Salud con fecha de corte al 15/12/2026.

Definición de Términos

GRD: Gestión de Riesgo y Desastre.

MIDAS: Modernización de la Información Digital de la Autoridad Sanitaria.

Ficha de capacidades: ficha en la plataforma MIDAS donde los hospitales informan autonomías, estado de líneas vitales, equipo de telecomunicaciones, gases clínicos, etc.

Plan de respuesta: es un conjunto de procedimientos y protocolos que describen cómo una organización responderá a situaciones de emergencia.

Plan de telecomunicaciones: Conjunto de procedimientos y flujos de comunicación con los distintos medios disponibles.

Consideraciones Técnicas

Meta indicador principal: Para el caso de los establecimientos, estos deben cumplir con 100% de las acciones para la implementación de la gestión del riesgo de desastres.

Implementación acciones del plan gestión del riesgo de desastres.

1. Hospitales con Plan de Telecomunicaciones de emergencia actualizado.
2. Encargados de gestión del riesgo con acceso a Módulo de Emergencia MIDAS.
3. Hospitales con fichas de capacidades identificadas y actualizadas.

Para el indicador principal cada servicio de salud uno de enviar resoluciones pertinentes a cada acción el último día hábil del mes de junio, para realizar u monitoreo y con 31 de diciembre enviar las resoluciones finales de cada establecimiento al RF encargado del indicador y subirlas a SharePoint.

Verificables solicitados al final del proceso:

1. Resoluciones con planes de telecomunicaciones, desde Director del Hospital con fecha de corte al 30/10/2026.
2. Resoluciones con nombramiento de encargados de MIDAS por Resolución, desde Director del Hospital con fecha de corte al 30/10/2026.
3. Relleno o actualización de las fichas de capacidades de los Hospitales en la plataforma MIDAS, con fecha de al 30/10/2026.

4.3. Índice del gasto en convenio con personas naturales respecto a la glosa autorizada vigente.

Este indicador cuantifica el ajuste del gasto en honorarios médicos y no médicos del periodo a la glosa vigente respectiva.

ID CG-SRA 35	Índice del gasto en convenio con personas naturales respecto a la glosa autorizada vigente.				
DIGEPEP Departamento de Gestión Normativa y Presupuestaria					
Objetivo del Indicador	Ajustar el gasto en honorarios médicos y no médicos al marco presupuestario autorizado.				
Responsable de gestión	Subdirección de Gestión de Personas del Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Gasto en convenio con personas naturales no médicos + Gasto en convenio con personas naturales médicos)/(Glosa en convenio con personas naturales no médicos + Glosa en convenio con personas naturales médicos)				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Índice	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	2 Decimal Aproximado			Polaridad	Los Valores bajos son Buenos
Meta	<=1,00				
Exclusiones	No aplica				
Fuente Numerador	SIGFE		Fuente Denominador	Ley de Presupuestos y Decretos Modificatorios del año	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
$\leq 1,00$	4 puntos
$\leq 1,01$	3 puntos
$\leq 1,02$	2 puntos
$\leq 1,04$	1 punto
$> 1,04$	0 puntos

Requisitos

Requisito: Consistencia entre el gasto en SIRH vs SIFGE.

Los Establecimientos deberán efectuar el pago a través Modulo de Honorarios de SIRH.

I.- Se entiende por consistencia, si el pago efectivo de honorarios Sub. 21 realizado a través del SIRH es consistente con el registro en SIGFE al menos en un 80%.

II.- La consistencia se medirá a través de un informe trimestral detallando la información de cada establecimiento, según formato enviado por nivel central. El informe debe ser enviado en PDF y ser firmado por el Subdirector de Gestión de Personas del Servicio de Salud.

El informe deberá contener cuadro resumen con los valores pagados por cada establecimiento bajo concepto de HSA registrados en SIRH y SIGFE según mes de pago y porcentaje de consistencia.

Además, reporte de análisis de diferencias, donde debe indicar y explicar las diferencias nominales, es decir, que funcionarios y por qué motivo no son consistente entre los sistemas de registro, ya sea por oportunidad del procesamiento de la información declaración u otro de conocimiento del establecimiento.

El plazo de entrega de los Informes debe ser a más tardar los días 20 de cada mes terminado el trimestre.

Servicios de Salud con registro desfasado en SIGFE

En el caso exclusivo de los Servicios de Salud que registran en SIGFE el pago desfasado un mes posterior a la fecha de pago en el módulo de SIRH, deberán reportar los pagos de los tres meses correspondientes al registro en SIGFE. Por ejemplo, en SIGFE lo registrado en enero 2026 corresponde a los pagos efectuados en diciembre 2025 en SIRH, por lo cual la consistencia se revisará respecto a los montos pagados en SIRH en los meses de diciembre 2025, enero y febrero 2026 y registrados en SIGFE en enero, febrero y marzo 2026. Esto se repetirá en los siguientes trimestres. Los Servicios de Salud en esta situación lo deberán informar en el primer reporte de información. Se solicita a cada referente enviar datos de contacto al correo uri.hidalgo@minsal.cl para compartir el formato y el cuadro resumen de consistencias.

Definición de Términos

SIGFE: Sistema de Información para la Gestión Financiera del estado SIRH: Sistema de Información de Recursos Humanos.

RESOLUCIÓN EXENTA DEL SERVICIO DE SALUD: Dictada por el Director de Servicio de Salud, en donde distribuye glosa de Honorarios Médicos y no Médicos a los establecimientos, al cierre del ejercicio presupuestario del año.

SUBTÍTULO 21: Comprende los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal. **GLOSA:** Regulan o establece precisiones o limitaciones al alcance de los gastos contemplados en cada partida.

GLOSA AUTORIZADA VIGENTE: Esta glosa permite la contratación de personal a honorarios hasta el límite establecido por el presupuesto autorizado. Es una herramienta importante para la gestión de recursos humanos en el sector salud, asegurando que las contrataciones se realicen dentro de los parámetros financieros aprobados.

CONSISTENCIA DEL REGISTRO ENTRE SIFGE Y SIRH: Se refiere a la sincronización y precisión de los datos entre el Sistema de Información para la Gestión Financiera del estado (SIFGE) y el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH). Esta consistencia es esencial para asegurar que la información financiera y de Recursos humanos sea coherente y esté actualizada en ambos sistemas.

Consideraciones Técnicas

El gasto total de honorarios asimilados a las leyes N°18.834, N°15.076 y/o N°19.664, está considerado en el subtítulo presupuestario 21-03-001.

Compromiso de Gestión N°5: Prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer.

Objetivo estratégico

“Fortalecer la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer, garantizando el acceso equitativo a la atención oncológica, la reducción de tiempos de espera y la mejora en la calidad de vida de los pacientes.”

Contexto

El fortalecimiento de la atención oncológica en Chile requiere estrategias integrales que aborden la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer, asegurando el acceso equitativo y la reducción de los tiempos de espera. Este enfoque está alineado con políticas públicas como el Plan Nacional del Cáncer, el Régimen General de Garantías en Salud (Ley N° 19.966) y los Objetivos Sanitarios 2030. A través de la implementación de protocolos, la capacitación del personal y el monitoreo de indicadores clave, se busca garantizar una atención efectiva y centrada en el paciente.

Fortalecimiento de la Prevención del Cáncer: Cobertura de Vacunación contra el VPH y Tamizaje Cervicouterino en la Atención Primaria

La vacunación contra el virus papiloma humano VPH es una medida preventiva esencial para reducir la incidencia de cáncer cervicouterino y otros tipos de cáncer asociados a este virus en la población. En Chile, la vacuna contra el VPH se incorporó al *Programa Nacional de Inmunización* en 2014, inicialmente dirigida a niñas y, desde 2019, extendida a niños de 4° básico. La estrategia de vacunación busca alcanzar una alta cobertura para garantizar la protección de la población escolar y contribuir a la eliminación del cáncer cervicouterino como problema de salud pública, por lo que se mide la cobertura efectiva de vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH) en niños, niñas y adolescentes que cursan 4° año básico con dosis nonavalente.

Para potenciar este objetivo, la cobertura de tamizaje para cáncer cervicouterino en establecimientos de APS municipales y dependientes de Servicio de Salud, es una estrategia clave para la detección temprana de lesiones precancerosas y la reducción de la mortalidad por esta enfermedad. En Chile, este procedimiento está inserto en el *Programa Nacional de Pesquisa y Control del Cáncer Cervicouterino*, iniciado en 1987 y basado en recomendaciones de la OPS/OMS. La cobertura de este tamizaje en la Atención Primaria de Salud es fundamental para garantizar el acceso equitativo a la prevención, especialmente en poblaciones vulnerables.

Cumplimiento atención en problemas de salud oncológicos

Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas oncológicas No GES representan un desafío para la equidad en el acceso a la atención, además de ser una prioridad de Gobierno, por lo que la gestión eficiente de estas listas, mediante estrategias de priorización y optimización de recursos, permite reducir los tiempos de espera y garantizar el tratamiento oportuno de los pacientes. La implementación de sistemas de monitoreo y mejora continua es fundamental para asegurar la

resolución de estos casos dentro de los plazos establecidos, lo que se medirá a través del indicador Lista de espera de intervención quirúrgica por problemas de salud oncológicos no GES resueltos en menos de 90 días.

Indicadores:

Compromiso de Gestión N°5: Prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer.

- 5.1. Nivel de cumplimiento efectivo de garantías GES en problemas de salud oncológicos
- 5.2. Casos oncológicos No GES en lista de espera quirúrgica con espera menor a 90 días
- 5.3. Cobertura de tamizaje para cáncer cervicouterino en establecimientos de APS municipales y dependientes de Servicio de Salud.
- 5.4. Cobertura efectiva de vacuna contra el VPH de NNA que cursan cuarto año básico con dosis nonavalente.

5.1. Nivel de cumplimiento efectivo de garantías GES en problemas de salud oncológicos.

Este indicador mide el nivel del cumplimiento en la red a la Ley GES, según los problemas de salud y sus garantías definidas en el decreto vigente (N°72/2022). Se enfoca en resolver 17 problemas de salud clasificados como oncológicos. El no cumplimiento es falta a la normativa vigente, por lo que la red debe usar todos los espacios de gestión posibles para su resolución.

ID CG-SRA 18	Nivel de cumplimiento efectivo de garantías GES en problemas de salud oncológicos				
DIGERA Departamento GES y Redes Complejas					
Objetivo del Indicador	Fortalecer la detección temprana de patologías oncológicas y la entrega oportuna de prestaciones para los pacientes oncológicos.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de Garantías Cumplidas + Garantías Exceptuadas + Garantías Incumplidas Atendidas) / (Número de Garantías Cumplidas + Garantías Exceptuadas + Garantías Incumplidas Atendidas + Garantías Incumplidas no Atendidas + Garantías Retrasadas)*100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	2 Decimal Aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100% de cumplimiento GES oncológico				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SIGGES		Fuente Denominador	SIGGES	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
100,00%	4 puntos
< 100,00%	0 puntos

Definición de Términos

Garantías Cumplidas: En esta agrupación se consideran las garantías realizadas dentro del plazo máximo que señala el decreto.

Garantías Exceptuadas: podrán exceptuarse de dar cumplimiento a una garantía de oportunidad (Superintendencia de Salud), cuando por causa imputable al beneficiario o por fuerza mayor derivada de su estado de salud, sea imposible otorgar la prestación en el plazo establecido, dando lugar a una nueva gestión del caso.

Garantías Incumplidas Atendidas: es aquella garantía de oportunidad realizada fuera del plazo garantizado para cada problema de salud incluido en GES.

Garantías Incumplida No atendida: El establecimiento no logró realizar la atención garantizada dentro de los tiempos establecidos, y es imposible entregarla en forma tardía por una condición o decisión del paciente.

Garantías Retrasadas Acumuladas: Corresponde a aquellas que no evidencian en SIGGES una atención, ya sea por no registro de esta o por no realización de la prestación.

Consideraciones Técnicas

El monitoreo de la gestión se realiza directamente desde la plataforma SIGGES, con reportería actualizada diariamente. La oportunidad del registro impacta directamente en el cumplimiento del indicador.

Para lograr un buen cumplimiento, es esencial gestionar las garantías de oportunidad dentro de su plazo de vigencia. Esto permite conocer la demanda real de prestaciones en la red, programar la oferta y identificar brechas para definir estrategias que aseguren el cumplimiento del 100%, según la normativa.

La medición se realiza mensualmente desde el nivel central. FONASA entrega la información a DIGERA cada mes, y esta se pone a disposición de la red mediante carpetas compartidas.

En la evaluación final, se puede apelar casos retrasados por causas externas, las cuales se nombran a continuación:

- Falta de causal de excepción en la normativa de la SIS
- Falta de causal de cierre de garantía
- Errores del sistema SIGGES.
- Estas apelaciones serán revisadas por los referentes técnicos para su aceptación o rechazo.

El universo considera las garantías acumuladas desde enero hasta el corte, excepto las garantías retrasadas, que incluyen acumulados de años anteriores.

Los problemas de Salud considerados para la evaluación del presente indicador se enumeran a continuación:

- 03- CÁNCER CERVICOUTERINO
- 04- ALIVIO DEL DOLOR
- 08- CÁNCER DE MAMA
- 14- CÁNCER INFANTIL
- 16- CÁNCER DE TESTÍCULO
- 17- LINFOMA

- 27- CÁNCER GÁSTRICO
 - 28- CÁNCER DE PRÓSTATA
 - 45- LEUCEMIA ADULTO
 - 70- CÁNCER COLORECTAL
 - 71- CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL
 - 72- CÁNCER VESICAL
 - 73- OSTEOSARCOMA
 - 81- CÁNCER DE PULMÓN
 - 82- CÁNCER DE TIROIDE
 - 83- CÁNCER RENAL
 - 84- MIELOMA MÚLTIPLE
-
1. FONASA envía a Referente Registro SIGGES de DIGERA el corte oficial de GO Retrasada, archivo excel (21 de cada mes, calendario definido por FONASA)
 2. Ref. Registro SIGGES de DIGERA envía por mail (archivo excel) a Referente SIGGES de SS el corte oficial de GO retrasadas.
 3. Posterior a esto, FONASA envía BBDD de cumplimiento a Referente Registro SIGGES de DIGERA (archivo excel).
 4. Ref. Registro SIGGES de DIGERA analiza y elabora archivo final con el cumplimiento GES que disponibiliza en carpetas compartidas a los Referente SIGGES de SS (se envía mail a la red con esta información)

5.2. Casos oncológicos No GES en lista de espera quirúrgica con espera menor a 90 días.

Este indicador evalúa la gestión de los casos en la lista de espera quirúrgica oncológica no GES, enfocándose en la respuesta oportuna del sistema de salud. Su adecuada gestión garantiza la continuidad del tratamiento oncológico, priorizando la urgencia médica, la oportunidad, la equidad y la eficiencia en la reasignación de recursos para minimizar impactos negativos en el pronóstico de los pacientes y mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos.

ID CG-SRA 22	Casos oncológicos No GES en lista de espera quirúrgica con espera menor a 90 días				
DIGERA Departamento GES y Redes Complejas					
Objetivo del Indicador	Disminuir los tiempos de espera para cirugía de pacientes oncológicos no GES clasificados como Oncológicos tratamiento.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	((Número de casos en LEIQ con un tiempo de espera igual o menor a 90 días desde el ingreso al registro / Número Total de casos en LEIQ que requieren resolución quirúrgica desde el ingreso al registro) X 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	80% de casos en LEIQ clasificados como Oncológicos tratamiento* con un tiempo de espera igual o menor a 90 días.				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	SIGTE	

Cumplimiento	Puntaje
≥80,0%	4 puntos
≥75,0%	3 puntos
≥70,0%	2 puntos
≥65,0%	1 punto
<65,0%	0 puntos

Definición de Términos

SIGTE: Sistema de Gestión de Tiempo de Espera.

LEIQ: Lista de espera de intervenciones quirúrgicas.

Número de casos en LEIQ: Identificados como casos confirmados de cáncer y clasificados como Oncológico-tratamiento que requieren resolución quirúrgica + casos sospechosos/indeterminados pendientes de clasificar, por cada Servicio de Salud

Consideraciones Técnicas

1. El Departamento de Análisis de la Información para la Gestión realiza corte mensual de Lista de Espera Quirúrgica.
2. El mismo departamento aplica de algoritmo de clasificación de casos sospechosos de cáncer y envía la los SS para su revisión, clasificación y registro (edición directa en SIGTE).
3. Los SS revisan, clasificación y registran (edición directa en SIGTE).
4. La unidad de Oncología del Depto. Ges evalúa cumplimiento del indicador de acuerdo con fórmula de cálculo y registra en Sistema de registro de Control de Gestión de la SRA, para conocimiento y revisión por parte de SS.

5.3. Cobertura de tamizaje para cáncer cervicouterino en establecimientos de APS municipales y dependientes de Servicio de Salud.

Este indicador mide la variación porcentual de la cobertura de tamizaje para cáncer cervicouterino en establecimientos de APS municipales y dependientes de Servicio de Salud, del año 2026 en relación con el año 2025. Se espera que los Servicios de Salud avancen en cobertura, reduciendo la brecha en un 30% (para llegar al gold estándar 80%). Este compromiso de gestión viene a contribuir al indicador de cobertura de cada establecimiento, comuna, servicio de salud y región, como también a la meta nacional, donde se espera lograr y mantener una cobertura de 80% de mujeres entre 25-64 años tamizaje vigente en establecimientos municipal (meta sanitaria N°2 de la ley 19.813), junto con contribuir a la meta sanitaria N°3 Ley 18.834, de los establecimientos APS dependiente.

ID CG-SRA 38	Cobertura de tamizaje para cáncer cervicouterino en establecimientos de APS municipales y dependientes de Servicio de Salud.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Fortalecer la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer cervicouterino.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Cobertura de tamizaje para cáncer cervicouterino obtenida en el año 2026 / meta de cobertura de tamizaje para cáncer cervicouterino) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100% de la meta establecida				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	LOCAL	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥95,0%	4 puntos
≥90,0%	3 puntos
≥85,0%	2 puntos
≥80,0%	1 punto
<80,0%	0 puntos

Definición de Términos

Cobertura: Corresponde al porcentaje de población que es cubierta por un determinado programa.

PAP: Papanicolau o citología exfoliativa. Corresponde al estudio de celular del cuello uterino que, mediante análisis microscópico, permite evaluar alteraciones celulares que pudieran reflejar una patología.

APS: Atención Primaria de salud que considera establecimientos dependientes del Servicio de Salud y municipios.

PIV: Población inscrita y validez de Fonasa. Corresponde a la cantidad de beneficiarios inscritos en el sistema público de salud y que es reportada por Fonasa, y que son cubiertos según tipo de dependencia.

VPH: Virus papiloma humano

Tamizaje Primario por VPH: corresponde a los tamizajes para CaCu realizados solo con test de VPH.

CO-TEST: corresponde al tamizaje para CaCu que considera la prueba VPH en el mismo momento que la toma del PAP.

Consideraciones Técnicas

Cobertura: $(N^{\circ} \text{ de mujeres}^* \text{ de 25 a 64 años con tamizaje vigente para cáncer cervicouterino} / N^{\circ} \text{ de mujeres}^* \text{ de 25 a 64 años pertenecientes a la atención primaria}) * 100$

Número de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje vigente para cáncer cervicouterino: mujeres y personas transmasculino de 25 a 64 años con tamizaje vigente para cáncer cervicouterino.

N° de mujeres de 25 a 64 años pertenecientes a la atención primaria: corresponde a las mujeres inscritas validadas en establecimientos de APS municipal + adscritas en establecimientos dependientes de Servicio de Salud + beneficiarias de establecimientos pertenecientes a entidades en convenio DFL 36 *incluye mujeres y personas transmasculinos.

La meta corresponde a reducir el 30% de brecha para alcanzar el 80% de mujeres y personas transmasculinos de 25 a 64 años con PAP Vigente en los últimos 3 años o Test VPH vigente en los últimos 5 años.

En los establecimientos APS sin implementación Test de VPH, mantendrán su población en base a tamizaje por PAP:

Número de mujeres y personas transmasculinos de 25 a 64 años, inscritas validadas (y adscritas en el caso de APS dependiente) con PAP vigente a diciembre 2026.

En los establecimientos APS que cuentan con PAP y Test de VPH, incluyendo los tomados en el extrasistema, corte diciembre.

Una vez implementado el tamizaje primario por VPH (cualquier modalidad de toma), como oferta de la red, financiamiento propio del servicio de salud, proyectos locales o iniciativas intersectoriales, deberán sumarse en el cálculo:

Número de mujeres con PAP vigente 25 a 64 años Vigente en los últimos 3 años (2024, 2025, 2026).
Número de mujeres con Test VPH tomados en los años 2022 y 2023.

Número de mujeres con VPH vigente 30 a 64 años como tamizaje primario (tomados desde la fecha de inicio de tamizaje primario por VPH)

Para establecimientos que cuentan con Citoweb, la cobertura conjunta de mujeres con tamizaje vigente para cáncer cervicouterino, considerando PAP y VPH, se extraerá en forma automatizada.

Los servicios de salud que no tengan brecha para llegar al 80%, deberán al menos mantener la cobertura de tamizajes lograda el año 2025.

Respecto de las fuentes:

-En el numerador: mujeres y personas transmasculinos con tamizaje vigente se debe utilizar el REM P12, sección A, este REM de la serie P debe ser alimentado desde:

Sistema informático Citoweb, REVICAN o Plataforma de desarrollo local (dependiendo del sistema que use el Servicio de Salud),

Registro local de mujeres y transmasculinos de 25 a 64 años con PAP o Test de VPH vigente tomados en extra sistema.

Registro local de VPH tomados en estrategias institucionales.

-En el denominador, para la APS municipal, se debe considerar lo informado por FONASA en la última validación de la población de mujeres de 25 a 64 años del año 2026 (el denominador utilizado para la meta 2 de la ley 19.813). Para la APS dependiente de servicio de salud, considerar la población de mujeres de 25 a 64 años adscritas para el año 2026 (el denominador utilizado para la meta 3 de la ley 18.834 validado por el referente técnico de servicio de salud). Ambas poblaciones se deben sumar para obtener el denominador.

Nota: Los servicios de salud que tengan coberturas $\geq 60\%$ en el 2026 y mantengan su cobertura respecto del año anterior, tendrá puntaje 4.

Se solicitará a través de Ordinario, que cada Servicio de Salud valide la población de sus establecimientos dependientes y de los establecimientos DFL 36.

5.4. Cobertura efectiva de vacuna contra el VPH de NNA que cursan cuarto año básico con dosis nonavalente.

El indicador mide la cobertura de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niños, niñas y adolescentes que cursan cuarto básico. La administración de la vacuna se realiza principalmente en establecimientos educacionales, como parte de una estrategia de salud pública orientada a la prevención de enfermedades asociadas al VPH y a la protección de la población infantil y juvenil.

ID CG-SRA 59	Cobertura efectiva de vacuna contra el VPH de NNA que cursan cuarto año básico con dosis nonavalente.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Aumentar la cobertura de vacunación, en escolares residente en Chile que cursa cuarto año básico, como estrategia de prevención, para disminuir la incidencia de patologías asociadas al contagio por Virus de Papiloma humano.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(NNA vacunados con dosis única de VPH nonavalente en cuarto básico/NNA matriculados en cuarto básico) X 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Anual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	≥90% de NNA de cuarto año básico vacunados contra VPH.				
Exclusiones	La única contraindicación para la vacunación es por indicación médica que denote alguna condición de salud que exceda los riesgos a los beneficios de la inmunización.				
Fuente Numerador	PNI		Fuente Denominador	PNI	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
$\geq 90,0\%$	4 puntos
$\geq 75,0\%$	3 puntos
$\geq 65,0\%$	2 puntos
$\geq 55,0\%$	1 punto
$< 55,0\%$	0 puntos

Definición de Términos

Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI): Su misión es “proteger a la población contra las enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública de acuerdo con la evidencia científica y el desarrollo biotecnológico” a través del acceso garantizado de vacunas e inmunoglobulinas según decreto de obligatoriedad vigente, en los establecimientos de atención primaria de salud y vacunatorios privados en convenio.

Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI): Desde el 1 de enero del 2013, el RNI es el sistema oficial de registro y recolección de los eventos de vacunación programáticas y de campañas del PNI. En el 2017 se conforma como el repositorio único nacional para todos los establecimientos de salud públicos y privados en convenio con la autoridad sanitaria. Es de carácter nominal, permitiendo la trazabilidad de cada producto biológico y persona inmunizada.

NNA: niños, niñas y adolescentes.

Virus Papiloma Humano (VPH): Grupo de más de 200 virus relacionados que pueden causar verrugas o, en algunos casos, cáncer. Algunos tipos de VPH de alto riesgo pueden causar cáncer de cuello uterino, ano, pene, vulva, vagina y garganta.

Vacunas contra VPH dosis nonavalente: Protege contra 9 tipos de VPH que son de bajo riesgo oncogénico (6 y 11) pero producen verrugas y de alto riesgo oncogénico (16,18, 31, 33, 45, 52, 58).

Consideraciones Técnicas

El denominador estará compuesto por los matriculados en 4° año básico, según informe el Ministerio de Educación (MINEDUC) durante el primer semestre de 2026.

Este avance se medirá por ocurrencia a nivel comunal, esto es el número de vacunados en una comuna dividido por los matriculados en dicha comuna.

Con respecto a la evaluación anual, se deberá cumplir el 100% de la meta esperada de vacunación acumulada de julio a diciembre del 2026, esto es 90% de avance del proceso de vacunación con VPH. El sobrecumplimiento se considerará como un 100%.

La vacunación se realiza en todos los establecimientos educacionales públicos y privados del país y es ejecutada por el personal de los vacunatorios de los establecimientos de salud de atención primaria (APS).

Aquellos NNA que por algún motivo no fueron vacunados en su establecimiento educacional, podrán acudir a cualquier otro vacunatorio del sistema público o privado en convenio con la SEREMI de Salud correspondiente.

Aquellos NNA que se vacunen directamente en un establecimiento de salud serán considerados en el numerador correspondiente a la comuna donde pertenece el centro vacunador.

La vacunación escolar se realiza durante el segundo semestre de cada año, según las orientaciones emitidas por el nivel central y de acuerdo con la planificación de los establecimientos de salud.

Se debe asegurar la vacunación para el grupo objetivo que presenta deserción escolar y aquellos que no asisten a establecimientos educacionales en forma regular o los que rinden exámenes libres, realizando una adecuada identificación de esta población vulnerable.

Se debe vacunar a la población que se encuentre en instituciones públicas o privadas como aulas hospitalarias, residencias, hogares, ejemplo: SENAME y Mejor Niñez, Pequeño Cottolengo, Fundación San José, entre otros.

En las Escuelas Especiales de enseñanza básica la vacunación se debe realizar en el curso correspondiente definido en el Decreto N°83/2015 (MINEDUC), según niveles homologables a los cursos a vacunar (edad correspondiente al curso + 2 años).

Se debe respetar la edad mínima de 9 años para la administración de la vacuna de acuerdo al registro sanitario autorizado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Compromiso de Gestión N°6: Sistemas de información y Salud Digital.

Objetivo estratégico

“Implementar y fortalecer un sistema de información integrado en la Red Asistencial, que permita compartir datos clínicos y de gestión entre los distintos establecimientos, favoreciendo la continuidad del cuidado, la coordinación inter-niveles y la toma de decisiones basada en información oportuna y de calidad”

La literatura sobre sistemas integrados enfatiza que la interoperabilidad entre plataformas clínicas y administrativas constituye uno de los determinantes más importantes para la mejora de la gestión sanitaria. Diversos estudios muestran que los sistemas de información integrados permiten mayor coordinación asistencial, disminuyen eventos adversos, optimizan la referencia y contrarreferencia, y fortalecen la vigilancia epidemiológica basada en el territorio. Además, facilitan procesos de planificación estratégica, monitoreo de calidad y evaluación de resultados sanitarios relevantes.

La OPS establece que las RISS deben disponer de “un sistema de información integrado que vincule todos los establecimientos y niveles de atención, apoye la toma de decisiones clínicas y de gestión, y permita el seguimiento continuo de las personas a lo largo de la red” (OPS, 2010). Esta orientación coincide con la evidencia internacional que propone que la transformación de sistemas de salud no se logra solo mediante reformas organizacionales, sino también mediante la creación de infraestructuras tecnológicas robustas, seguras y accesibles, capaces de sostener modelos de atención más equitativos, eficientes y centrados en el ciclo vital.

De este modo, el objetivo formulado no solo responde a un estándar técnico, sino que se alinea con los principios de cuidado continuo, enfoque territorial, pertinencia cultural y participación informada de usuarios y comunidades. En síntesis, avanzar en sistemas de información integrados permite materializar una red que trabaja de forma articulada, dialoga entre niveles, reconoce trayectorias reales de cuidado y reduce las brechas derivadas de la fragmentación histórica.

Indicador

Compromiso de Gestión N°6: Sistemas de información y Salud Digital

- 6.1. Nivel de implementación de estrategias y/o células de Hospital Digital en establecimientos del Servicio de Salud.
- 6.2. Plan de Ciberseguridad conforme a Ley 21.663
- 6.3. Implementación de Estrategia Tiempos De Espera Interoperable.

6.1. Nivel de implementación de estrategias y/o células de Hospital Digital en establecimientos del Servicio de Salud.

Este indicador mide el porcentaje de establecimientos de salud de un Servicio de Salud que ha implementado al menos 2 estrategias o Células de Hospital Digital en un período determinado. Evalúa el grado de adopción y expansión de las estrategias digitales en la Red Asistencial, asegurando que los establecimientos de salud integren soluciones digitales para mejorar el acceso, eficiencia, calidad y oportunidad de la atención en salud.

ID CG-SRA 44	Nivel de implementación de estrategias y/o células de Hospital Digital en establecimientos del Servicio de Salud				
Salud Digital Unidad de Estadística y Control de Gestión					
Objetivo del Indicador	Promover la implementación y desarrollo de la telemedicina en la red asistencial mediante estrategias y Células de Hospital Digital en todos los niveles de atención.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Establecimientos que cumplen con el mínimo de estrategias definidas / Número de establecimientos evaluados) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100%				
Exclusiones	No están considerados los establecimientos que clasificados según Listado de Establecimientos DEIS, corresponde a Postas de Salud Rural. No se considera la Célula Oftalmología (DART) y Hospital Digital Rural.				
Fuente Numerador	Sistema de Registro de HD		Fuente Denominador	Sistema de Registro de HD	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥100%	4 puntos
≥75%	3 puntos
≥50%	2 puntos
≥40%	1 punto
<40%	0 puntos

Definición de Términos

Línea Base: corresponde a la cantidad de establecimientos con producción en 2 o más estrategias de HD durante el año 2025, sin considerar las Postas de Salud Rural.

Un mayor porcentaje de cumplimiento indica que más establecimientos han incorporado al menos 2 estrategias de Hospital Digital, promoviendo un avance en la transformación digital del sistema de salud. Mientras que un porcentaje bajo refleja una adopción limitada, lo que podría señalar la necesidad de mayor apoyo técnico, capacitación o incentivos para la implementación.

Consideraciones Técnicas

Para la evaluación del indicador se consideran a todos los establecimientos salud, en sus 3 niveles de atención según Listado de Establecimientos DEIS (versión actualizada a la fecha de evaluación), con excepción de las Postas de Salud Rural.

Para la definición de cumplimiento los establecimientos de la línea base deberán mantenerse o aumentar en la cantidad de prestaciones solicitadas a HD para ser considerados.

Se medirá también:

Mantener y/o aumentar la producción de prestaciones de Hospital Digital solicitadas por los establecimientos del Servicio de Salud, en el período a evaluar, respecto al mismo periodo 2025. Este punto es considerado como exigencia mínima para evaluar el indicador, es decir, si la producción al corte 2026 es menor a la producción en el mismo corte del año 2025, se asigna 0% cumplimiento.

6.2. Plan de Ciberseguridad conforme a Ley 21.663

De cara al 2025, el foco del Indicador se centró en la implementación prioritaria de los controles críticos identificados en la brecha y avanzar en la conformación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para los Servicios de Salud y Hospitales de Alta Complejidad.

Para el año 2026, el principal desafío será cumplir con las nuevas exigencias de la Ley N° 21.663 de Ciberseguridad, que establece obligaciones para los Organismos de Interés Vital (OIV), entre ellos el sector salud. Esto implica que cada institución deberá prepararse mejor, contando con una gobernanza clara, monitoreo permanente, y planes de respuesta ante incidentes que sigan buenas prácticas y estándares reconocidos como ISO 27001 y el Marco Nacional de Ciberseguridad.

El presente COMGES busca ayudar a las instituciones del Sector a avanzar en esa dirección, implementando un Plan de Ciberseguridad propio, que permita cumplir con las exigencias de la ley, proteger sus servicios críticos y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles ataques o fallas tecnológicas.

ID CG-SRA 138	Plan de Ciberseguridad conforme a Ley 21.663				
GABINETE MINISTRO(A) Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones					
Objetivo del Indicador	Garantizar la implementación del Plan de Ciberseguridad para el Sector Salud conforme con la Ley N° 21.663 y la línea base del MINSAL, contribuyendo a la protección de servicios críticos y continuidad operativa				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Medidas implementadas del Plan de Ciberseguridad/ Total de medidas definidas según línea base) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Anual
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	80%				
Exclusiones	No hay				
Fuente Numerador	Datos con Validación de Nivel Central		Fuente Denominador	Datos con Validación de Nivel Central	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥80%	4 puntos
≥75%	3 puntos
≥70%	2 puntos
≥60%	1 punto
<60%	0 puntos

Requisitos

Frecuencia de medición: Anual.

Periodo de evaluación del cumplimiento: Anual.

Meta sugerida para 2026: Alcanzar un 80% de implementación efectiva de las medidas del Plan de Ciberseguridad Institucional, conforme a la línea base definida por el MINSAL.

Fuente de verificación: Informe de avance del Plan de Ciberseguridad, validado por la Unidad de Ciberseguridad y Seguridad de la Información del MINSAL.

Fuente de datos: Políticas y procedimientos formalizados, resoluciones exentas, registros de sistemas de información, informes de proveedores, herramientas de monitoreo de seguridad y reportes complementarios.

Criterio por eje estratégico: Para considerar un eje como cumplido, deberá verificarse el 100% de los medios de verificación asociados.

Definición de Términos

Activos de información: toda información o recurso relacionado para la creación, almacenamiento, gestión o transmisión de dicha información. Podrán ser activos materiales (RRHH especializados, aparatos, equipos, redes, instalaciones, soportes y sistemas de almacenamiento) o intangibles (datos, aplicaciones, sistemas operativos, bases de datos, imagen, reputación, marcas de la organización)

Activo informático: toda información almacenada en una red y sistema informático que tenga valor para una persona u organización.

Autenticación: propiedad de la información que da cuenta de su origen legítimo.

Agencia: la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que se conocerá en forma abreviada como ANCI.

Auditorías de seguridad: procesos de control destinados a revisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos que se derivan del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

Ciberataque: intento de destruir, exponer, alterar, deshabilitar, o exfiltrar u obtener acceso o hacer uso no autorizado de un activo informático.

Incidente de ciberseguridad: Todo evento que perjudique o comprometa la confidencialidad o integridad de la información, la disponibilidad o resiliencia de las redes y sistemas informáticos, o la autenticación de los procesos ejecutados o implementados en las redes y sistemas informáticos.

Ciberseguridad: Preservación de la confidencialidad e integridad de la información y de la disponibilidad y resiliencia de las redes y sistemas informáticos, con el objetivo de proteger a las personas, la sociedad, las organizaciones o las naciones de incidentes de ciberseguridad.

Confidencialidad: Propiedad que consiste en que la información no es accedida o entregada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

Continuidad de servicios: Adoptar las medidas que permitan proveer un nivel mínimo de servicio, entendiendo por esto las prestaciones propias del sistema, reduciendo el riesgo de eventos que puedan dar lugar a una interrupción o inestabilidad en las operaciones de la entidad, manteniendo niveles aceptables y propiciando la recuperación de los servicios de las tecnologías de la información (TI) en el menor tiempo posible.

Concienciación, Educación y Capacitación en Seguridad de la Información: Es el proceso de sensibilización y formación continua del personal sobre riesgos de ciberseguridad, buenas prácticas y cumplimiento normativo. Se deben realizar programas de capacitación periódicos, simulacros de incidentes y campañas de concienciación para fortalecer la cultura de seguridad en la organización.

Derechos de Acceso: Privilegios y permisos asignados a usuarios, sistemas y aplicaciones para acceder a recursos de información dentro de una organización. Su objetivo es garantizar que solo las personas o sistemas autorizados puedan visualizar, modificar o administrar información y activos tecnológicos, minimizando el riesgo de accesos no autorizados o uso indebido de los datos.

Disponibilidad: Propiedad que consiste en que la información está disponible y es utilizable cuando es requerida por un individuo, entidad o proceso autorizado.

Datos Personales o datos de carácter personal: Los datos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, con independencia de su soporte.

Datos Sensibles: Datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática o CSIRT: Centros multidisciplinarios que tienen por objeto prevenir, detectar, gestionar y responder a incidentes de ciberseguridad o ciberataques, en forma rápida y efectiva, y que actúan conforme a procedimientos y políticas predefinidas, ayudando a mitigar sus efectos.

Gestión de incidentes: Procedimientos para la detección, análisis, manejo, contención y resolución de un incidente de ciberseguridad y responder ante ésta.

Gestión de Cambios: Comprende la planificación, control y auditoría de modificaciones en sistemas, aplicaciones o infraestructura tecnológica, con el objetivo de minimizar riesgos de seguridad. Debe

incluir la evaluación de impactos, pruebas previas, aprobación formal y documentación de cada cambio implementado.

Incidente: Evento inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento de la seguridad de las redes, equipos y sistemas de información (véase también ciberincidente).

Interrupción: Se refiere a cualquier evento que afecte la continuidad operativa de los servicios de información, pudiendo ser causado por incidentes de seguridad, fallos técnicos o desastres naturales. Se deben implementar planes de continuidad del negocio (BCP) y recuperación ante desastres (DRP) para mitigar el impacto de interrupciones y asegurar la resiliencia de los sistemas.

Infraestructura crítica: las instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya afectación, degradación, denegación, interrupción o destrucción cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medioambiente o a la seguridad del país. Se entiende por este concepto la infraestructura indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud.

Integridad: Propiedad que consiste en que la información no ha sido modificada o destruida sin autorización.

Nube privada: La infraestructura de la nube se aprovisiona para uso exclusivo de una única organización aun cuando comprenda múltiples unidades de dicha organización. Puede ser propiedad, administrado y operado por la organización, un tercero o una combinación de ellos, y puede existir dentro o fuera de las instalaciones de la organización.

Nube pública: La infraestructura y los recursos lógicos que forman parte del entorno se encuentran disponibles para el público en general a través de Internet. Suele ser propiedad de un Prestador de Servicios que gestiona la infraestructura y el servicio o servicios que se ofrecen.

Protección de los activos de información: Adoptar las medidas que resguarden la seguridad física de los dispositivos, así como los accesos a éstos.

Red y sistema informático: conjunto de dispositivos, cables, enlaces, enrutadores u otros equipos de comunicaciones o sistemas que almacenen, procesen o transmitan datos digitales.

Resiliencia: Capacidad de las redes y sistemas informáticos para seguir operando luego de un incidente de ciberseguridad, aunque sea en un estado degradado, debilitado o segmentado, y la capacidad de las redes y sistemas informáticos para recuperar sus funciones después de un incidente de ciberseguridad.

Respaldo: La información de respaldo (backup) se refiere al proceso de copiar y almacenar datos críticos para garantizar su disponibilidad en caso de pérdida, corrupción, o incidentes de seguridad como ataques cibernéticos, fallas de hardware o desastres naturales.

Riesgo de Ciberseguridad: Toda circunstancia o hecho razonablemente identificable que tenga un posible efecto adverso en la seguridad de las redes, equipos y sistemas de información. Se puede cuantificar como la probabilidad de materialización de una de las amenazas antes mencionadas que produzca un impacto en términos de operatividad, o de integridad, confidencialidad o disponibilidad de datos.

Seguridad de la información: Conjunto de medidas preventivas y reactivas de los organismos administradores y sus respectivos sistemas tecnológicos, que tienen por objeto resguardar y proteger la información, asegurando la confidencialidad, integridad, autenticidad y disponibilidad de los datos, continuidad de servicios y protección de activos de información.

Seguridad de la Información en la Relación con Proveedores: Define la importancia de establecer requisitos de seguridad en los contratos con proveedores de tecnología y servicios, asegurando que cumplan con normativas y estándares de seguridad. Deben incluirse cláusulas sobre confidencialidad, gestión de accesos, protección de datos y cumplimiento de auditorías de seguridad.

Tratamiento de datos: Cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.

Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotado por una o más amenazas informáticas.

Consideraciones Técnicas

Detalle de consideraciones técnicas se incluirá en anexo Orientaciones Técnicas del Indicador.

6.3. Implementación de Estrategia Tiempos de Espera Interoperable.

Evaluar el despliegue territorial de la implementación de la Estrategia de Tiempos de Espera Interoperable en el contexto de las solicitudes de Consulta Nueva de Especialidad No GES para usuarios de la red asistencial.

ID CG-SRA 145	Implementación de Estrategia Tiempos de Espera Interoperable				
GABINETE MINISTRO(A) Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones					
Objetivo del Indicador	Porcentaje de establecimientos de un Servicio de Salud que están interoperando para el caso de uso 2.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de establecimientos APS interoperando para el CNE origen y destino APS) / (Número total de establecimientos APS que cumplen condiciones habilitantes) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	2 Decimal Aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	70% de los establecimientos del SS interoperando para CNE de APS a APS al 31 de diciembre de 2026				
Exclusiones	Se excluyen los establecimientos que no generan SIC para CNE al ámbito electivo y/o que no cuenten con registro clínico electrónico (o no tengan contrato vigente con su proveedor) o no tengan conectividad a internet.				
Fuente Numerador	Datos con Validación de Nivel Central		Fuente Denominador	Datos con Validación de Nivel Central	

Tabla de sensibilidad

Cumplimiento	Puntaje
≥70,00%	4 puntos
<70,00%	0 puntos

Nivel de aplicación

Todos los establecimientos de salud de nivel primario que generan solicitudes de interconsulta (SIC) para consulta nueva de especialidad (CNE).

Requisito

El 90% de los establecimientos del SS interoperando para CNE de APS a Secundario APS al 31 de diciembre de 2026.

Fórmula de Cálculo

Indicador A: establecimientos participantes de APS, que cumplen con la tributación a lista de espera

(Establecimientos que tributan SIC en TEI con sobre 40% de SIC tributadas en SIGTE) / (SIC emitidas desde APS, registradas en SIGTE)

Indicador B: establecimientos participantes del nivel hospitalario (secundarios o terciarios) que cumplen con la tributación a lista de espera

(Establecimientos con más del 40% SIC cursadas en agendamiento y/o terminadas en base TEI) / (SIC recepcionadas en base TEI)

Determinación del cumplimiento:

$$A*0,75 + B*0,25$$

Código de la fuente del numerador

Para el indicador A: Establecimientos que tributan SIC en TEI con sobre 40% de SIC tributadas en SIGTE.

Para el indicador B: Establecimientos con más del 40% de SIC cursadas en agendamiento y/o terminadas en base TEI.

Código de la fuente del denominador

Para el indicador A: SIC emitidas desde APS, registradas en SIGTE **Para el indicador B:** SIC recepcionadas en base TEI

Definición de Términos

Interoperabilidad: Capacidad de los distintos sistemas y aplicaciones de acceder, intercambiar, integrar y usar datos de forma colaborativa y coordinada mediante la utilización de interfaces y estándares semánticos y sintácticos comunes, dentro o fuera de un mismo ámbito institucional, regional y nacional, para proporcionar una usabilidad rápida y fluida de la información dentro de los procesos sanitarios y asistenciales.

FHIR: Estándar sintáctico para el intercambio de información de salud

Estrategia Tiempos de Espera Interoperable: Estrategia Ministerial para modernizar el proceso de Lista de Espera a través de la Interoperabilidad de la solicitud de interconsulta.

Guía de Implementación: Conjunto de directrices para el desarrollo de sistema de información que garanticen la interoperabilidad. Para el caso de Tiempos de Espera Interoperable, la Guía de Implementación actualizada será la informada a la red mediante la resolución correspondiente.

Consideraciones Técnicas

Para el cálculo del denominador, se utilizará como fuente primaria la tabla de establecimientos DEIS publicada al 31 de agosto de 2026, la cual debe ser validada por el Servicio de Salud, justificando con evidencia aquellos establecimientos que cumplan con alguna de las causales de exclusión. Se aplicarán los filtros señalados en el manual del cálculo del indicador, incluyendo las excepciones asociadas.

Para el cálculo del numerador, cada Servicio de Salud deberá informar los establecimientos que están interoperando para el caso de uso de nueva consulta de especialidad origen APS y destino Secundario, lo que será verificado a través del análisis de la mensajería almacenada en la plataforma de Interoperabilidad MINSAL.

Consideraciones técnicas propias del proceso y la implementación estarán contenidas en el lineamiento normativo correspondiente.

6. Indicadores de Monitoreo Obligatorio

1. Ambulatorización de cirugías mayores electivas.

El indicador de Ambulatorización de cirugías mayores electivas mide la proporción de Cirugías Mayores Ambulatorias (CMA) respecto al total de cirugías mayores electivas. Su propósito es optimizar el uso de los recursos disponibles en salud, además de mejorar la experiencia del paciente al ofrecerle la posibilidad de una recuperación en el hogar.

ID CG-SRA 29	Ambulatorización de cirugías mayores electivas				
DIGERA Departamento de Gestión Hospitalaria y Red de Urgencia					
Objetivo del Indicador	Incrementar la realización de Cirugías Mayores Ambulatorias (CMA) en comparación con las cirugías mayores electivas totales, favoreciendo una utilización más eficiente de los recursos y mejorando la experiencia del paciente.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de cirugías mayores electivas ambulatorias realizadas /Número de cirugías mayores electivas totales realizadas) X 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	Entero con 1 decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	Obtener al final de trienio 50% de Ambulatorización				
Exclusiones	Hospitales de baja complejidad, Institutos y bajo DFL 36.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	REM	

Definición de Términos

Cirugía Mayor Electiva: Es la intervención quirúrgica mayor que, por el tipo de diagnóstico y las características clínicas del paciente puede ser diferida en el tiempo para su realización y programada en tabla quirúrgica.

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) Electiva: corresponde a una intervención quirúrgica mayor, que de acuerdo con diagnóstico y condición clínica de la persona puede ser electiva ambulatoria. Se realiza en el quirófano ambulatorio o central y es considerada ambulatoria, cuando la admisión, la intervención quirúrgica, quirófano mayor ambulatorio o central, la recuperación y el alta del paciente ocurren, en menos de 24 horas. El periodo de observación posoperatorio debe ser realizado en una unidad destinada a este fin y no en una cama de dotación, una vez pasado el tiempo de recuperación anestésica, el paciente vuelve a su domicilio.

Producción quirúrgica de cirugías mayores electivas: Corresponde al número total de cirugías mayores electivas (ambulatorias y no ambulatorias) realizadas en los establecimientos del país y debidamente registradas en los Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM).

Consideraciones Técnicas

La información REM será entregada por el referente DIGERA del Departamento de Análisis e Información para la Gestión a referente DIGERA del Departamento de Red de Urgencia y Atención Cerrada.

Manera de entrega de información: Planilla de datos REM

Cuando: De acuerdo a Calendario REM, enero 2027

Cuántas veces al año: Una vez al año

Fuente: REM

Formato: Excel

Observaciones: Se realiza monitoreo mensual de acuerdo a Calendario REM.

2. Personas que abandonan durante el Proceso de Atención de Urgencia en las Unidades de Emergencia Hospitalaria Adulto y Pediátrica.

Este indicador mide el porcentaje de pacientes que, tras ser admitidos/as con generación de DAU en la Unidad de Emergencia Hospitalaria, se retiran antes de completar su atención médica, ya sea sin ser evaluados/as por un profesional o sin recibir el alta correspondiente. El propósito es evaluar la eficiencia y calidad del servicio de urgencias, dado que el abandono incrementa el riesgo de complicaciones graves o la muerte en las personas usuarias, además reflejar insatisfacción con la atención por la demora en esta.

ID CG-SRA 57	Personas que abandonan durante el Proceso de Atención de Urgencia en las Unidades de Emergencia Hospitalaria Adulto y Pediátrica.				
DIGERA Departamento de Gestión Hospitalaria y Red de Urgencia					
Objetivo del Indicador	Disminuir el porcentaje de pacientes que no completan el proceso de Atención Médica en Unidades de Emergencia Hospitalaria.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	((Número total de DAU generados en las Unidades de Emergencia Hospitalaria Adulto y Pediátrica – Número total de altas desde las Unidades de Emergencia Hospitalaria Adulto y Pediátrica) / Número total de DAU generados en las Unidades de Emergencia Hospitalaria Adulto y Pediátrica).				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores bajos son Buenos
Meta	≤10% de personas que abandonan durante el proceso de atención de urgencia				
Exclusiones	Urgencia Gineco-Obstétrica				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	REM	

Definición de Términos

Abandono: se refiere a los pacientes que, habiendo sido admitidos en el servicio de urgencias, se retiran antes de recibir una evaluación médica o antes de obtener una disposición final (alta médica, hospitalización, derivación a otro servicio o fallecimiento).

Porcentaje de abandono: se calcula en relación al total de pacientes admitidos con generación de DAU en urgencias durante un periodo determinado, y debe ser medido de manera continua para identificar tendencias y posibles áreas de intervención.

Numerador: debe considerar a todas las personas que se retiran posterior a la generación del DAU, en cualquier etapa del proceso de atención de urgencia, incluso aquellas que no alcanzan a recibir atención médica y se retiran desde la sala de espera.

Consideraciones Técnicas

Este indicador mide el porcentaje de pacientes que no completan la atención médica, por sobre el total de la demanda de atención de urgencia.

Se considera atención de urgencia, a pacientes admitidos, con generación de DAU cuya atención completó el proceso de atención de urgencia y resultaron en una alta médica. Se incluye atención médica pediátrica y adulto.

Fuente de datos REM, reporte oficial, según calendario de fechas REM. El responsable de remitir este reporte es el Coordinador de la Red de Urgencia de los Servicios de Salud, quien debe recibir los datos de el/los establecimientos a evaluar en el periodo indicado y revisar estos datos antes de que sean subidos a la carpeta COMGES, también será el responsable de liderar y enviar el documento oficial del análisis del indicador y su plan de mejora, si el resultado lo requiere. (todo indicador que no cumple con la meta Ministerial debe tener plan de mejora).

3. Días de estada en Hospitalización Domiciliaria.

El promedio días de estada nos permite conocer la duración de la internación de los pacientes y evaluar en qué medida la estadía de un paciente se prolonga más allá de lo admisible. Con el seguimiento de este indicador se mejorará la gestión del recurso cupo/cama en las Unidades de Hospitalización Domiciliaria (UHD) de todo el país.

ID CG-SRA 26	Días de estada en Hospitalización Domiciliaria.				
DIGERA Departamento de Gestión Hospitalaria y Red de Urgencia					
Objetivo del Indicador	Optimizar la duración de las estancias de los pacientes en Hospitalización Domiciliaria, garantizando una rotación adecuada y un uso eficiente del recurso cupo/cama, mediante el cumplimiento de un promedio de días de estada $\leq 8,5$ días.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	Número de establecimientos del Servicio de Salud que cumplen la meta de días de estada en Hospitalización Domiciliaria / Número de establecimientos del Servicio de Salud evaluados				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Número	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Dicotómico
Meta	100% de la meta asignada				
Exclusiones	Hospitales que no cuenten con unidades de Hospitalización Domiciliaria o no recibieran recursos desde MINSAL para su implementación.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	REM	

Definición de Términos

Días personas atendidas: Es el número total de días que el paciente se encuentra bajo los cuidados de hospitalización domiciliaria. Corresponde a la sumatoria de días totales de hospitalización por paciente durante el mes.

Consideraciones Técnicas

Las Unidades de Hospitalización Domiciliaria (UHD) deben monitorear constantemente que sus pacientes no prolonguen innecesariamente sus hospitalizaciones. Para ello, se utiliza el indicador de Días de Estada, que no debe exceder la meta asignada para cada establecimiento.

Fórmula: Días personas atendidas / Personas atendidas.

Dado que es fundamental mantener este indicador como Meta Nacional de $\leq 8,5$ días, debemos orientar los esfuerzos a sostener o reducir dicho promedio, de acuerdo con la línea de base (LB) de cada establecimiento con el fin de que todos los establecimientos puedan lograrlo.

- LB se considera lo logrado al 2do corte COMGES 2025.

- El verificador son los datos REM A 21, sección C1.

Debido a lo anteriormente explicado, es que este año se solicitará una meta específica para cada establecimiento, la cual será fijada en base a su LB 2025.

1.- Para aquellos con LB menor e igual a 8.5 deben mantenerse = o < a 8.5

2.- Para aquellos con LB mayor a 8.5 se dividieron en 2 grupos:

- Aquellos donde su diferencia entre la LB y la meta nacional sea igual o superior a 10, donde se le solicita disminuir el 50% de su brecha.

- Aquellos donde su diferencia entre la LB y la meta nacional sea menor que 10, donde se le solicita disminuir 33,3% de su brecha.

La responsabilidad de cumplimiento del indicador es compartida entre la subdirección médica de cada establecimiento y el Servicio de Salud.

Las metas serán compartidas como anexo.

1. Extracción de la información: El Departamento de Análisis e Información para la Gestión de DIGERA realiza la extracción de datos de Hospitalización Domiciliaria al momento del corte.

2. Corte semestral: Se enviará un corte semestral a los referentes de Hospitalización Domiciliaria DIGERA.

3. Revisión de los datos: El referente técnico de DIGERA revisará los datos, analizando y contrastando con la meta establecida.

4. Camas disponibles respecto de la dotación vigente.

El propósito del indicador tiene por finalidad monitorear y asegurar la habilitación efectiva del total de camas reconocidas en el proceso de dotación vigente para el año 2026, garantizando la mantención de la oferta asistencial comprometida por la red.

ID CG-SRA 27	Camas disponibles respecto de la dotación vigente.				
DIGERA Departamento de Gestión Hospitalaria y Red de Urgencia					
Objetivo del Indicador	Optimizar la utilización de camas disponibles para garantizar una gestión eficiente de los recursos de salud.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	[Total Días Camas Disponibles/ (Total Camas por Resolución * total días año calendario)]				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Mixto
Meta	95%				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	REM 20		Fuente Denominador	REM 20	

Definición de Términos

Camas de dotación: camas asignadas al establecimiento por la autoridad competente, instaladas y dispuestas las 24 horas del día para la hospitalización de pacientes, que funcionan regularmente en períodos de actividad normal. NT 201 /2018.

Consideraciones Técnicas

Aunque no se establecerá como requisito la entrega de un Plan de Mitigación o de un Plan de Apertura de Camas, se sugiere que dichos instrumentos sean objeto de monitoreo y seguimiento por parte del Servicio de Salud, en calidad de mecanismo de control intermedio.

Se considera un acta semestral de cotejo, para verificar que los datos del establecimiento son los mismos que se encuentran en DEIS. Acta debe ser descargada de REM por el RT del servicio de salud, y derivada a RT de nivel central.

5. Cobertura de gestantes en control con ecografía realizada 22 – 24 semanas de gestación.

Este indicador mide el porcentaje de gestantes bajo control con ecografía de screening de 22-24 semanas. Se espera que los servicios de salud avancen en obtener mejores coberturas considerando que la ecografía obstétrica en atención primaria (APS) tiene por finalidad reducir la morbilidad asociada a problemas de salud fetal y materna neonatal prevalentes en la población, al constituirse en tamizaje esencial para gestantes que se controlan en los establecimientos de APS.

ID CG-SRA 40	Cobertura de gestantes en control con ecografía realizada 22 – 24 semanas de gestación.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Incrementar la cobertura de gestantes con ecografía obstétrica de screening 22-24 semanas de gestación, para reducir la morbilidad asociada a problemas de salud fetal y materna neonatal prevalentes en la población.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Total de gestantes con ecografía de 22 a 24 semanas de gestación / Total gestantes bajo control) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	25%				
Exclusiones	APS dependiente de servicios de salud				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	REM	

Definición de Términos

22-24 semanas: Corresponde al período de gestación que se considera para el monitoreo, el cual abarca desde el inicio de la semana 22 hasta el final de la semana 24.

Gestantes ingresadas: Corresponde a las gestantes que ingresan a control prenatal, sin importar las semanas gestacionales.

Ecografía de segundo trimestre de 22-24 semanas: Examen ultrasonográfico realizado a gestante en el segundo trimestre cuyo objetivo es realizar un screening preventivo con el fin de pesquisar oportunamente factores de riesgo o condiciones que se asocian con malos resultados perinatales, permitiendo la intervención oportuna en algunas de estas situaciones. Si bien se debe promover que sea entre 22 y 24 semanas.

Consideraciones Técnicas

Al mes de julio del año 2025, los establecimientos de APS lograron a nivel nacional una cobertura del 21,2% de las ecografías de 22 - 24 semanas. Este porcentaje varía significativamente entre los Servicios de Salud. Para 2026 se establece una meta de 25%, en la cual aquellos establecimientos que tengan un cumplimiento a diciembre de 2025 superior a dicho porcentaje deben mantener o aumentar su cobertura. En el caso de aquellos establecimientos que tengan una cobertura menor al 25% deberán alcanzar o superar este porcentaje.

6. Cumplimiento de supervisión del proceso de Eventos Centinela Priorizados de Reporte Inmediato (ECPRI).

Este indicador refleja las acciones y gestiones de supervisión realizadas por el Servicio de Salud de los Eventos Centinela Priorizados (ECPRI) reportados por su red de Establecimientos de Salud de Atención Cerrada.

ID CG-SRA 8	Cumplimiento de supervisión del proceso de Eventos Centinela Priorizados de Reporte Inmediato (ECPRI)				
DIGERA Departamento de Seguridad y Calidad de la Atención					
Objetivo del Indicador	Mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente, a través de la supervisión del proceso de notificación y análisis de ECPRI.				
Responsable de gestión	Dirección del Establecimiento				
Fórmula de Cálculo	(Número de ECPRI de hospitales con supervisión realizadas por el Servicio de Salud / Total de ECPRI reportados de hospitales en el SS) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	≥ 90% de los ECPRI supervisados				
Exclusiones	ECPRI notificados en las últimas 15 días ³ , antes de elaborar el informe				
Fuente Numerador	LOCAL		Fuente Denominador	LOCAL	

Definición de Términos

Eventos Centinela Priorizados (ECPRI): Todo evento, confirmado o en sospecha, que cumple con las características que se especifican en la tabla 2 del “Manual de eventos centinela priorizados para reporte inmediato” disponible en: <https://www.minsal.cl/seguridad-y-calidad-de-la-atencion-marco-legal/>

Supervisión por Servicio de Salud (SS): Para efectos de este COMGES, se entenderá por “supervisión realizada” a las acciones de apoyo del Servicio de Salud correspondiente al menos a dos actividades por ECPRI. Cuyo verificador será el “Informe de supervisión de los ECPRI del Servicio de Salud”.

Consideraciones Técnicas

Los ECPRI que deben considerarse en la supervisión de los Servicios de Salud, son los señalados en el Manual de eventos centinela priorizados para reporte inmediato vigente. Las acciones de supervisión pueden realizarse en cualquier etapa del proceso de manejo del ECPRI, las que deben quedar documentadas.

³ Corresponde a días corridos

Se debe utilizar el formato establecido por referencia técnica para informar. El MV es elaborado por el Departamento de Calidad y Seguridad del Servicio de Salud y entregado a su equipo de Control de Gestión, para que el equipo de Control de Gestión lo envíe a su contraparte de Control de Gestión del Ministerio de Salud, por los medios que el equipo ministerial ha establecido para ello. La fecha de envío está asociada a la establecida por Control de Gestión como corte.

7. Cumplimiento de test visual/rápido en los establecimientos de atención primaria.

Este indicador mide el incremento de test visual/rápido realizados en la atención primaria. Se espera que el cumplimiento de este indicador permita mejorar la detección y el tratamiento oportuno de la infección por VIH en la población. Cuenta con un requisito asociado, donde se espera que exista un aumento en la realización de test en la población específica de hombres.

ID CG-SRA 24	Cumplimiento de test visual/rápido en los establecimientos de atención primaria.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Mantener y/o aumentar la realización de test visual/rápido en los establecimientos de atención primaria.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	Fórmula 1: (Número de test visual/rápido VIH realizados en establecimientos de atención primaria en el año 2026- Número de test visual/rápido VIH realizados en establecimientos de atención primaria en el año 2025) / Número de test visual/rápido VIH realizados en establecimientos de atención primaria en el año 2025) x 100 Fórmula 2: ((Número de test visual/rápido VIH realizados a hombres en establecimientos de atención primaria en el periodo (año t)- Número de test visual/rápido VIH realizados a hombres establecimientos de atención primaria del Servicio de Salud del periodo (año t-1)) / Número de test visual/rápido VIH realizado a hombres en establecimientos de atención primaria del Servicio de Salud en el periodo (año t-1)) x100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	Mantener y/o aumentar la producción del año 2026 según línea base 2025. Aumento de 5% de test realizados a hombres durante el año 2026.				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SURVIH		Fuente Denominador	SURVIH	

Definición de Términos

Test visual/ Rápido VIH: corresponde a la técnica por inmunocromatografía, que detecta la presencia del virus de inmunodeficiencia (VIH) en muestra de sangre capilar. SURVIH: Sistema único de registro de VIH del MINSAL.

Establecimientos de Atención Primaria: corresponden a CESFAM, CECOSF, Hospital Comunitario, Postas, SAR, SAPU, Espacio Amigable u otro dispositivo de atención con oferta de test visual/rápido de VIH informado por el S.S, independiente de la modalidad (demanda espontánea, en consulta, EMP, actividades extramuros, ronda de salud, etc.)

Consideraciones Técnicas

Como verificador el Servicio de Salud deberá informar en archivo (planilla Excel) en formato MINSAL, 10 días hábiles luego del corte, el N° de número de test visual / rápido de VIH acumulado al corte por establecimiento.

Si bien la evaluación es anual, los datos de SURVIH son de reporte mensual, por lo que se sugiere a los Servicios de Salud llevar un monitoreo mensual del indicador.

Se espera que exista un aumento de test realizados en la población específica de hombres. Se evaluarán solo los establecimientos que el Servicio de Salud informe que disponen de oferta de Test visual/ rápido de VIH durante el año 2025.

8. Personas mayores de 15 años en hemodiálisis crónica con Fístula Arteriovenosa confeccionada.

Este indicador mide el porcentaje de personas adultas en hemodiálisis crónica, que cuentan con fístula arteriovenosa (nativa o protésica) como acceso vascular para su terapia dialítica, en relación al total de pacientes en hemodiálisis crónica.

ID CG-SRA 14	Personas mayores de 15 años en hemodiálisis crónica con Fístula Arteriovenosa confeccionada.				
DIGERA Departamento de Gestión Ambulatoria y de Apoyo Diagnóstico					
Objetivo del Indicador	Aumentar la prevalencia de FAV como acceso vascular en los pacientes que se realizan hemodiálisis crónica.				
Responsable de gestión	Subdirección Médica del Establecimiento				
Fórmula de Cálculo	(Número de pacientes mayores de 15 años en hemodiálisis crónica con FAV realizada/Total de pacientes mayores de 15 años en hemodiálisis crónica) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	70%				
Exclusiones	Pacientes menores de 15 años				
Fuente Numerador	SIGGES		Fuente Denominador	SIGGES	

Definición de Términos

Hemodiálisis: Es una técnica de depuración extracorpórea que suple parcialmente las funciones del riñón (excreción de agua y solutos, y equilibrio electrolítico), mediante el uso de un dializador con membrana semipermeable. Cabe destacar que esta terapia no reemplaza las funciones endocrinas ni metabólicas del órgano.

Accesos Vasculares para Hemodiálisis son:

Fístula Arteriovenosa (FAV): Es el acceso vascular definitivo de elección, creado mediante cirugía ambulatoria. Se clasifica en:

FAV Nativa: Unión directa (anastomosis) entre una arteria y una vena del paciente. Requiere un periodo de maduración de 8 a 12 semanas para su uso. Su funcionalidad debe evaluarse en el postoperatorio, al primer trimestre de uso y anualmente por un especialista.

FAV Protésica (Injerto): Interposición de un conducto sintético entre una arteria y una vena. Su principal ventaja es un tiempo de espera menor, pudiendo utilizarse 4 semanas después de la intervención.

Catéter de Hemodiálisis: Acceso vascular transitorio (percutáneo o tunelizado) insertado en venas centrales. Pese a su utilidad inmediata, conlleva una alta morbilidad por complicaciones infecciosas (IAAS) y trombóticas, lo que incrementa el riesgo de largas estancias hospitalarias y mortalidad en comparación con FAV.

Consideraciones Técnicas

Indicador aplica a todos los Servicios de Salud.

Se consideran todos los pacientes beneficiarios Fonasa en terapia dialítica tanto del sector público como en prestadores privados.

El registro en SIGGES debe realizarse según normativa vigente, siendo los medios verificadores para este indicador: registro de las prestaciones otorgadas de tratamiento de hemodiálisis códigos 1901028 o 1901029 en el año 2026 y en el caso de FAV, las Garantías de oportunidad conferidas y cerradas con prestaciones otorgadas códigos 2501031, 2501032, 250133 o 2501034.

Dado que los datos para el cálculo del indicador se extraen desde los registros SIGGES, el Medio de Verificación es centralizado en DIGERA. La referente de salud renal y SIGGES DIGERA envían vía correo electrónico a los referentes de salud renal y SIGGES de los Servicios de Salud.

9. Personas mayores de 15 años con enfermedad renal crónica en tratamiento de Peritoneodiálisis.

El indicador mide el porcentaje de pacientes en terapia de sustitución renal a través de Peritoneodiálisis en relación con el total de pacientes dializados (hemodiálisis y Peritoneodiálisis). El propósito es otorgar un mayor acceso, a los pacientes con ERC Etapa V a esta terapia, la que tiene múltiples beneficios clínicos y de calidad de vida.

ID CG-SRA 13	Personas mayores de 15 años con enfermedad renal crónica en tratamiento de Peritoneodiálisis.				
DIGERA Departamento de Gestión Ambulatoria y de Apoyo Diagnóstico					
Objetivo del Indicador	Cuantificar los pacientes en tratamiento de peritoneodiálisis (PD) como terapia de sustitución renal crónica.				
Responsable de gestión	Subdirección Médica del Establecimiento				
Fórmula de Cálculo	(Número de pacientes mayores de 15 años en tratamiento de Peritoneodialisis crónica / Total de pacientes mayores de 15 años en tratamiento de hemodiálisis y peritoneodialisis crónica) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	≥ 20% de los pacientes en tratamiento de peritoneodiálisis (PD)				
Exclusiones	No aplica a pacientes menores de 15 años.				
Fuente Numerador	SIGGES		Fuente Denominador	SIGGES	

Definición de Términos

Peritoneodiálisis (PD): Es una técnica de depuración extrarrenal que utiliza el peritoneo del paciente como membrana de intercambio para líquidos y solutos. Requiere la instalación de un catéter permanente en la cavidad abdominal y puede realizarse de forma manual (ambulatoria) o automatizada (mediante cicladora), permitiendo al paciente realizar el tratamiento en su domicilio.

Consideraciones Técnicas

Indicador aplica a todos los Servicios de Salud independiente si tienen o no la cartera de prestación de Peritoneodiálisis.

Se consideran todos los pacientes beneficiarios Fonasa en terapia dialítica tanto del sector público como en prestadores privados.

El registro en SIGGES debe realizarse según normativa vigente, siendo los medios verificadores para este indicador: registro de prestaciones otorgadas de tratamiento de Peritoneodiálisis en el año 2026 códigos 1901025 o 1901026 y su Garantía de Oportunidad de Tratamiento de Peritoneodiálisis

conferida; y registro de prestaciones otorgadas de tratamiento hemodiálisis en el año 2026 códigos 1901028 o 1901029 y su correspondiente Garantía de Oportunidad de Tratamiento hemodiálisis conferida.

Dado que los datos para el cálculo del indicador se extraen desde los registros SIGGES, el MV es centralizado en DIGERA. La referente de Salud Renal y SIGGES DIGERA envían vía correo electrónico a los referentes de Salud Renal y SIGGES de los SS.

10. Personas que viven con VIH en control en establecimientos de los Servicios de Salud, que reciben tratamiento antirretroviral (TAR) y presentan carga viral indetectable.

Este indicador busca contribuir al cumplimiento de las metas ONUSIDA 95-95-95, a través de la monitorización de personas viviendo con VIH que están en TAR y que han alcanzado la supresión viral.

ID CG-SRA 88	Personas que viven con VIH en control en establecimientos de los Servicios de Salud, que reciben tratamiento antirretroviral (TAR) y presentan carga viral indetectable.				
DIPRECE Departamento Prevención y Control VIH e ITS					
Objetivo del Indicador	Contribuir al cumplimiento de las metas 95-95-95 mediante la monitorización de personas en TAR y la verificación de la supresión virológica alcanzada				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	Personas que viven con VIH bajo control en TAR y con carga viral indetectable / Total de personas viviendo con VIH bajo control que se encuentran en terapia antirretroviral				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	95%				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	REM	

Definición de Términos

Población bajo control: Considera a las personas con atención vigente a la fecha de reporte. Se entiende por atención vigente la atención realizada por el equipo profesional del establecimiento con prestaciones para personas viviendo con VIH (presencial o telemática) y/o retiro de TAR (cualquier modalidad).

Terapia antirretroviral: Fármacos indicados a las personas que viven con VIH, con el objetivo de evitar la replicación viral, lograr la supresión virológica y mejorar la calidad de vida.

Carga viral indetectable: Corresponde a personas que viven con VIH, que se encuentran en tratamiento antirretroviral y tienen una carga viral suprimida (< 1000 copias/ml).

Consideraciones Técnicas

La fuente de información para este indicador será el REM serie P 11 sección A, por lo cual es muy importante que cada establecimiento y Servicio de Salud realicen un trabajo coordinado para asegurar el correcto registro y concordancia en los datos reportados.

11. Plan Operativo Anual de la Estrategia Nacional de Salud.

La gestión basada en resultados, como un atributo de las RISS, aporta a la organización con un enfoque de gestión en la cual se asegura que sus procesos, productos y servicios contribuyen al logro de resultados definidos.

En este contexto, cabe destacar que la Estrategia Nacional de Salud emplea este enfoque, definiendo objetivos y metas en temas priorizados a nivel nacional, así como la generación de cadenas de resultados, con el propósito que cada nivel genere su plan operativo.

Dicho plan es clave para ir avanzando en los resultados sanitarios, dado que una planificación conjunta, alineada y con involucramiento de la autoridad tiene mayor sostenibilidad y posibilidad de incidir en el logro de los resultados.

ID CG-SRA 116	Plan Operativo Anual de la Estrategia Nacional de Salud				
DIPLAS Departamento Estrategia Nacional de Salud					
Objetivo del Indicador	Formular y monitorear el cumplimiento de la planificación operacional anual (POA)				
Responsable de gestión	Dirección del Establecimiento				
Fórmula de Cálculo	(Número de acciones ejecutadas del plan operativo anual / Número total de acciones planificadas del plan operativo anual) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	Según lo establecido por la referencia técnica al 31 de marzo 2026.				
Exclusiones	Este indicador No posee Exclusiones				
Fuente Numerador	SIMPO		Fuente Denominador	SIMPO	

Definición de Términos

POA: Plan Operativo Anual

SIMPO: Sistema Informático de Monitoreo del Plan Operativo

Consideraciones Técnicas

Al 31 de marzo se debe contar con el plan formulado en SIMPO, el cual se extraerá desde dicha plataforma y constituirá el denominador para establecer el cumplimiento de ejecución.

El referente ENS coordinará con las subdirecciones y/o departamentos la formulación del plan, basándose en la Orientaciones para la planificación operativa 2026⁴, y comprometerán las temáticas a incluir, con objeto de formular actividades en al menos el 70% de los temas y la totalidad de los objetivos estratégicos.

De acuerdo a las fechas presentes en la orientación para la planificación 2026, se debe reportar trimestralmente las actividades en SIMPO, con los medios de verificación correspondientes:

- Primer corte: reportar las actividades planificadas en enero-marzo con fecha 22 de abril.
- Segundo corte: reportar las actividades planificadas en abril-junio con fecha 22 de julio.
- Tercer corte: reportar las actividades planificadas en julio-septiembre con fecha 21 de octubre.
- Cuarto corte: reportar las actividades planificadas en octubre-diciembre con fecha 08 de enero 2027

⁴ La Orientación para la planificación operativa 2026 se encuentra disponible en el SIMPO.

12. Tiempo de Espera a Consultas Nuevas de Especialidad médica.

Este indicador mide la reducción de la mediana de días de espera para consultas nuevas de especialidad médica, reflejando avances en la optimización del acceso a atención.

ID CG-SRA 51	Tiempo de Espera a Consultas Nuevas de Especialidad médica.				
DIGERA Departamento de Análisis e Información para la Gestión					
Objetivo del Indicador	Disminuir los Tiempos de Espera para la consulta nueva de especialidades Médicas (CNEM)				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Días disminuidos de la mediana de espera en Lista de Espera de consultas nuevas de especialidades médicas / Total de días de la mediana de espera comprometidos a disminuir en la Lista de Espera de consultas nuevas de especialidades médicas) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores bajos son Buenos
Meta	100% de la meta establecida				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	SIGTE	

Definición de Términos

Listas de Espera: Es el registro con los casos de todas las personas que han recibido indicación de atención, sea esta para: consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica; realización de procedimiento en atención especializada; intervención quirúrgica mayor y/o menor programada. Las que deben ser otorgadas por un profesional autorizado para su ejercicio en la red asistencial, teniendo documentada la solicitud de atención en el formulario correspondiente. La inclusión en el registro debe considerar a todas las personas, aún cuando la atención requerida no forme parte de la cartera de servicios del establecimiento de referencia, en cuyo caso, el gestor de red debe resolver, en primera instancia, a través de la oferta de su red, o en su defecto, mediante la gestión con otras redes.

SIGTE: Nombre que recibe el “Sistema Informático de Gestión de Tiempos de Espera”, provisto por MINSAL, y que contiene los datos de registro disponibles y en línea de las listas de Espera de consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, de intervenciones quirúrgicas mayores y menores electivas, y otras que se definan.

Fecha de entrada: Corresponde a la fecha de indicación de la atención, la que es realizada por el médico u otro profesional autorizado y que es documentada en el formulario correspondiente. Esta

fecha de indicación será válida tanto para las indicaciones provenientes desde APS, como niveles secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de Servicio de Salud.

Causal de Egreso: Indica la causal de salida de la Lista de Espera de un paciente, definidas según Norma Técnica N°118 del año 2011 y sus actualizaciones.

Anualidad: Término utilizado para referirse al año de entrada de los casos de las personas que se encuentran en listas de espera registradas en SIGTE.

Servicio de Protección Especializada: Servicio público con enfoque intersectorial, sujeto a la fiscalización de la Subsecretaría de la Niñez y que forma parte del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Se constituye a partir de la publicación de la Ley N° 21.302. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados.

SENAME: El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde el día 01 de octubre de 2021, se enfoca exclusivamente al área de justicia y reinserción juvenil, encargándose de la atención de adolescentes y jóvenes que han estado en conflicto con la Ley entre los 14 y 17 años, y que han sido imputados o condenados, por medio de intervenciones oportunas, pertinentes y de calidad en el marco del respeto a sus derechos fundamentales.

Lista Servicio de Protección Especializada y SENAME (En contextos residenciales): Lista de Espera de pacientes SENAME total, que cumplan con criterios de registro en SIGTE a la espera de consultas nuevas de especialidad. Por contextos residenciales se entiende aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes vigentes en programas residenciales y Familias de Acogida del Servicio de Protección Especializada, y en Centros Privativos de Libertad e Internación Provisoria (CIP-CRC) y Semicerrados de SENAME.

Ley VALECH: Persona reconocida por el Estado de Chile como víctima de prisión política y tortura. **Ley RETTIG:** Persona reconocida por el Estado de Chile como familiar de persona detenida desaparecida o familiar de persona ejecutada política.

Ley de Exoneración Política: Persona reconocida por el Estado de Chile como exonerada por expulsión de manera involuntaria en su trabajo por motivos políticos.

Consideraciones Técnicas

Cálculo de meta

- Mediana $X \leq 150$ días: la meta es mantener.
- Mediana $X \leq 200$ días: la meta es mantener, si aumenta se aplica la tabla de sensibilidad en base a su aumento. (invertida)

- Mediana $201 \geq X \leq 290$ días: la meta es reducir un 15%.
- Mediana $X > 290$ días: la meta es reducir un 30%

El Medio de verificación es una estructura Excel enviada vía email a cada referente de registro y gestión de LE de los Servicios de Salud a fin del mes siguiente al corte. Además, en Visor Gestor se publica la medición de mediana de días de espera actualizada que se encuentra en línea para los referentes con acceso.

13. Tiempo de Espera a Consultas Nuevas de Especialidad odontológica.

Este indicador mide la reducción de la mediana de días de espera para consultas nuevas de especialidad Odontológica, reflejando avances en la optimización del acceso a atención.

ID CG-SRA 54	Tiempo de Espera a Consultas Nuevas de Especialidad odontológica.				
DIGERA Departamento de Gestión Ambulatoria y de Apoyo Diagnóstico					
Objetivo del Indicador	Disminuir los Tiempos de Espera para Consulta Nueva de Especialidad odontológica				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Días disminuidos de la mediana de espera en Lista de Espera de consultas nuevas de especialidades odontológicas / Total de días de la mediana de espera comprometidos a disminuir en la Lista de Espera de consultas nuevas de especialidades odontológicas) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores bajos son Buenos
Meta	- Mediana $X \leq 150$ días: la meta es mantener - Mediana $X \leq 200$ días: la meta es mantener, si aumenta se aplica la tabla de sensibilidad en base a su aumento. (invertida) - Mediana $201 \geq X \leq 290$ días: la meta es reducir un 15% - Mediana $X \geq 290$ días: meta es reducir un 25%				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	SIGTE	

Definición de Términos

Listas de Espera: Es el registro con los casos de todas las personas que han recibido indicación de atención, sea esta para: consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica; realización de procedimiento en atención especializada; intervención quirúrgica mayor y/o menor programada. Las que deben ser otorgadas por un profesional autorizado para su ejercicio en la red asistencial, teniendo documentada la solicitud de atención en el formulario correspondiente. La inclusión en el registro debe considerar a todas las personas, aun cuando la atención requerida no forme parte de la cartera de servicios del establecimiento de referencia, en cuyo caso, el gestor de red debe resolver, en primera instancia, a través de la oferta de su red, o en su defecto, mediante la gestión con otras redes.

SIGTE: Nombre que recibe el “Sistema Informático de Gestión de Tiempos de Espera”, provisto por MINSAL, y que contiene los datos de registro disponibles y en línea de las listas de Espera de consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, de intervenciones quirúrgicas mayores y menores electivas, y otras que se definan.

Fecha de entrada: Corresponde a la fecha de indicación de la atención, la que es realizada por el médico u otro profesional autorizado y que es documentada en el formulario correspondiente. Esta fecha de indicación será válida tanto para las indicaciones provenientes desde APS, como niveles secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de Servicio de Salud.

Causal de Egreso: Indica la causal de salida de la Lista de Espera de un paciente, definidas según Norma Técnica N°118 del año 2011 y sus actualizaciones.

Anualidad: Término utilizado para referirse al año de entrada de los casos de las personas que se encuentran en listas de espera registradas en SIGTE.

Servicio de Protección Especializada: Servicio público con enfoque intersectorial, sujeto a la fiscalización de la Subsecretaría de la Niñez y que forma parte del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Se constituye a partir de la publicación de la Ley N° 21.302. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados.

SENAME: El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde el día 01 de octubre de 2021, se enfoca exclusivamente al área de justicia y reinserción juvenil, encargándose de la atención de adolescentes y jóvenes que han estado en conflicto con la Ley entre los 14 y 17 años, y que han sido imputados o condenados, por medio de intervenciones oportunas, pertinentes y de calidad en el marco del respeto a sus derechos fundamentales.

Lista Servicio de Protección Especializada y SENAME (En contextos residenciales): Lista de Espera de pacientes SENAME total, que cumplan con criterios de registro en SIGTE a la espera de consultas nuevas de especialidad. Por contextos residenciales se entiende aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes vigentes en programas residenciales y Familias de Acogida del Servicio de Protección Especializada, y en Centros Privativos de Libertad e Internación Provisoria (CIP-CRC) y Semicerrados de SENAME.

Ley VALECH: Persona reconocida por el Estado de Chile como víctima de prisión política y tortura.

Ley RETTIG: Persona reconocida por el Estado de Chile como familiar de persona detenida desaparecida o familiar de persona ejecutada política.

Ley de Exoneración Política: Persona reconocida por el Estado de Chile como exonerada por expulsión de manera involuntaria en su trabajo por motivos políticos.

Consideraciones Técnicas

Se entregará línea de base y meta de resolución anual calculados con la totalidad de casos incluidos en el corte del 31 de diciembre 2025.

Cálculo de meta en consideraciones técnicas:

- Mediana $X \leq 150$ días: la meta es mantener
- Mediana $X \leq 200$ días: la meta es mantener, si aumenta se aplica la tabla de sensibilidad en base a su aumento. (invertida)
- Mediana $201 \geq X \geq 290$ días: la meta es reducir un 15%
- Mediana $X \geq 290$ días: la meta es reducir un 30%

El Medio de Verificación es una estructura Excel enviada vía email a cada referente de registro y gestión de LE de los Servicios de Salud a fin del mes siguiente al corte. Además, en Visor Gestor se publica la medición de mediana de días de espera actualizada que se encuentra en línea para los referentes con acceso.

14. Tiempo de Espera a intervenciones quirúrgicas.

Este indicador mide la reducción de la mediana de días de espera para intervenciones quirúrgicas, reflejando avances en la optimización del acceso a atención.

ID CG-SRA 55	Tiempo de Espera a intervenciones quirúrgicas.				
DIGERA Departamento de Análisis e Información para la Gestión					
Objetivo del Indicador	Disminuir los Tiempos de Espera para intervenciones quirúrgicas				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Días disminuidos de la mediana de espera en Lista de Espera de intervenciones quirúrgicas / Total de días de la mediana de espera comprometidos a disminuir en la Lista de Espera de intervenciones quirúrgicas) x 100.				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores bajos son Buenos
Meta	100% de la meta establecida				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	SIGTE		Fuente Denominador	SIGTE	

Definición de Términos

Listas de Espera: Es el registro con los casos de todas las personas que han recibido indicación de atención, sea esta para: consulta ambulatoria de especialidad médica u odontológica; realización de procedimiento en atención especializada; intervención quirúrgica mayor y/o menor programada. Las que deben ser otorgadas por un profesional autorizado para su ejercicio en la red asistencial, teniendo documentada la solicitud de atención en el formulario correspondiente. La inclusión en el registro debe considerar a todas las personas, aun cuando la atención requerida no forme parte de la cartera de servicios del establecimiento de referencia, en cuyo caso, el gestor de red debe resolver, en primera instancia, a través de la oferta de su red, o en su defecto, mediante la gestión con otras redes.

SIGTE: Nombre que recibe el “Sistema Informático de Gestión de Tiempos de Espera”, provisto por MINSAL, y que contiene los datos de registro disponibles y en línea de las listas de Espera de consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, de intervenciones quirúrgicas mayores y menores electivas, y otras que se definan.

Fecha de entrada: Corresponde a la fecha de indicación de la atención, la que es realizada por el médico u otro profesional autorizado y que es documentada en el formulario correspondiente. Esta fecha de indicación será válida tanto para las indicaciones provenientes desde APS, como niveles secundarios y terciarios, según los flujogramas acordados en cada red de Servicio de Salud.

Causal de Egreso: Indica la causal de salida de la Lista de Espera de un paciente, definidas según Norma Técnica N°118 del año 2011 y sus actualizaciones.

Anualidad: Término utilizado para referirse al año de entrada de los casos de las personas que se encuentran en listas de espera registradas en SIGTE.

Servicio de Protección Especializada: Servicio público con enfoque intersectorial, sujeto a la fiscalización de la Subsecretaría de la Niñez y que forma parte del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Se constituye a partir de la publicación de la Ley N° 21.302. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados.

SENAME: El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde el día 01 de octubre de 2021, se enfoca exclusivamente al área de justicia y reinserción juvenil, encargándose de la atención de adolescentes y jóvenes que han estado en conflicto con la Ley entre los 14 y 17 años, y que han sido imputados o condenados, por medio de intervenciones oportunas, pertinentes y de calidad en el marco del respeto a sus derechos fundamentales.

Lista Servicio de Protección Especializada y SENAME (En contextos residenciales): Lista de Espera de pacientes SENAME total, que cumplan con criterios de registro en SIGTE a la espera de consultas nuevas de especialidad. Por contextos residenciales se entiende aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes vigentes en programas residenciales y Familias de Acogida del Servicio de Protección Especializada, y en Centros Privativos de Libertad e Internación Provisoria (CIP-CRC) y Semicerrados de SENAME.

Ley VALECH: Persona reconocida por el Estado de Chile como víctima de prisión política y tortura.

Ley RETTIG: Persona reconocida por el Estado de Chile como familiar de persona detenida desaparecida o familiar de persona ejecutada política.

Ley de Exoneración Política: Persona reconocida por el Estado de Chile como exonerada por expulsión de manera involuntaria en su trabajo por motivos políticos.

Consideraciones Técnicas

Se entregará línea de base y meta de resolución anual calculados con la totalidad de casos incluidos en el corte del 31 de diciembre 2025.

Cálculo de meta

- Mediana $X \leq 150$ días: la meta es mantener.

- Mediana $X \leq 200$ días: la meta es mantener, si aumenta se aplica la tabla de sensibilidad en base a su aumento. (invertida).
- Mediana $201 \geq X \leq 290$ días: la meta es reducir un 15%
- Mediana > 290 días: la meta es reducir un 30%

El Medio de verificación es una estructura Excel enviada vía email a cada referente de registro y gestión de LE de los Servicios de Salud a fin del mes siguiente al corte. Además, en Visor Gestor se publica la medición de mediana de días de espera actualizada que se encuentra en línea para los referentes con acceso.

15. Especialidades médicas que cumplen con estándar de Altas en Centros de Especialidades Ambulatorias de Atención en Salud.

Mide el cumplimiento de las altas realizadas, por especialidad, registradas respecto del total de consultas nuevas de especialidad y controles de especialidad médica en los Centros de Especialidades Ambulatorias de Atención en Salud. Busca evaluar la capacidad resolutive de estos establecimientos para entregar atención en el nivel que corresponde, conforme a los protocolos de referencia y contrarreferencia en red. Un mayor porcentaje indica una mejor resolución clínica y favorece el ingreso de nuevas personas en espera de atención.

ID CG-SRA 6	Especialidades médicas que cumplen con estándar de Altas en Centros de Especialidades Ambulatorias de Atención en Salud.				
DIGERA Departamento de Gestión Ambulatoria y de Apoyo Diagnóstico					
Objetivo del Indicador	Aumentar el porcentaje de altas de usuarias/os en especialidades médicas.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	Número de especialidades que cumplen mensualmente con el porcentaje de altas según cluster/ Número de especialidades que generan producción mensualmente				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Mensual
Número de Decimales	1 Decimal Trucado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	60,0% de las especialidades médicas cumplen meta				
Exclusiones	Los establecimientos DFL-36 y establecimientos de baja complejidad Especialidades: Medicina Nuclear (Excluye Informes)- Imagenología				
Fuente Numerador	REM A07		Fuente Denominador	REM A07	

Definición de Términos

Alta de especialidad médica: Corresponde a un hito dentro del proceso de atención del(la) usuario(a), formalizado mediante un acto clínico-administrativo, a través del cual se concluye el plan diagnóstico y/o terapéutico o se determina la no continuidad de la atención de especialidad en el CEAAS, por razones clínicas o administrativas.

A partir de este acto, la continuidad de la atención se transfiere al nivel asistencial que corresponda. Existen dos tipos de alta: Clínica y Administrativa

Fórmula de cálculo para pertinencia: Número de consultas pertinentes según criterio clínico en box de SIC (con origen CDT-CAE-CRS-Hospitalizado) por especialidad/ Número de consultas nuevas (con origen CDT-CAE-CRS-Hospitalizado) por especialidad.

Fórmula de cálculo para alta: Número de altas por especialidad/ Número de consultas totales por especialidad.

Consideraciones Técnicas

Este indicador no tiene consideraciones técnicas.

Grupos de exigencias de altas médicas

Grupo N°1: Altas $\geq$ 5,0% GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA HEMATOLOGÍA INFECTOLOGÍA INMUNOLOGÍA MASTOLOGÍA MEDICINA PALIATIVA Y DE MANEJO DEL DOLOR NEFROLOGÍA ADULTO	Grupo N°4: Altas $\geq$ 14,0% CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA COLOPROCTOLOGÍA (CIRUGÍA DIGESTIVA BAJA) GENÉTICA CLÍNICA MEDICINA DEL DEPORTE MEDICINA FAMILIAR MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN MEDICINA INTERNA MEDICINA MATERNO INFANTIL NEUROCIRUGÍA NEUROLOGÍA ADULTO OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA PEDIATRÍA RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
Grupo N°2: Altas $\geq$ 7,0% DIABETOLOGÍA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA ENFERMEDAD RESPIRATORIA DE ADULTO (BRONCOPULMONAR) ENFERMEDAD RESPIRATORIA PEDIÁTRICA (BRONCOPULMONAR INFANTIL) NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA REUMATOLOGÍA	Grupo N°5: Altas $\geq$ 18,0% CIRUGÍA DIGESTIVA (ALTA) CIRUGÍA GENERAL CIRUGÍA TÓRAX DERMATOLOGÍA GERIATRÍA NEONATOLOGÍA OFTALMOLOGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA
Grupo N°3: Altas $\geq$ 10,0% CARDIOLOGÍA CIRUGÍA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL ENDOCRINOLOGÍA ADULTO GASTROENTEROLOGÍA ADULTO GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA MEDICINA DEL ADOLESCENTE MEDICINA REPRODUCTIVA E INFERTILIDAD NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA NEURORRADIOLOGÍA NUTRICIÓN CLÍNICA ONCOLOGÍA MÉDICA PSIQUIATRÍA ADULTO PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA Y DE LA ADOLESCENCIA UROLOGÍA	Grupo N°5: Altas $\geq$ 25,0% CIRUGÍA CARDIOVASCULAR CIRUGÍA PEDIÁTRICA Grupo N°6: Altas $\geq$ 70,0% ANESTESIOLOGÍA

16. Índice de ausentismo laboral por Licencia médica curativa.

Este indicador mide la disminución y/o mantención del índice de ausentismo laboral por licencia médica curativa, de acuerdo con las metas de reducción del ausentismo definido tanto para cada Servicio de Salud como para cada EAR.

ID CG-SRA 5	Índice de ausentismo laboral por Licencia médica curativa.				
DIGEDEP Departamento de Desarrollo y Calidad de Vida Laboral					
Objetivo del Indicador	Medir el índice de ausentismo laboral por licencia médica curativa, considerando la implementación de acciones de prevención y abordaje del ausentismo en los Servicios de Salud y Establecimientos Autogestionados (EAR)				
Responsable de gestión	Dirección del Establecimiento				
Fórmula de Cálculo	(Índice Ausentismo Laboral LMC año 2026)- (Índice Ausentismo Laboral LMC año 2025)				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Índice	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	2 Decimal Aproximado			Polaridad	Los Valores bajos son Buenos
Meta	Cumplir el 100% de la meta respecto IA 2025. ≤19 días: disminuir o mantener. >19 y ≤ 23 días: disminuir 1 o más días. >23 y ≤ 27 días: disminuir 2 o más días. >27 días: disminuir 3 o más días.				
Exclusiones	No tiene				
Fuente Numerador	QLIKVIEW		Fuente Denominador	QLIKVIEW	

Definición de Términos

Dotación efectiva: Promedio trimestral de funcionarios titulares y a contrata, incluyendo funcionarios con calidad de suplentes en cargos titulares vacantes, funcionarios que se encuentran en comisión de servicio y funcionarios que hacen uso de permiso sin goce de remuneraciones.

Enfoque Biopsicosocial: Modelo general que plantea que los factores biológicos, sociales y psicológicos (incluye pensamientos, emociones y conductas), juegan un papel importante en el funcionamiento humano, y, por tanto, en la comprensión del continuo salud-enfermedad.

Índice de ausentismo laboral: Corresponde a la relación entre los días de ausencia por licencia médica curativa de los funcionarios (dotación efectiva, suplencias y remplazos) y la dotación de estos, según la fecha de corte.

Licencia médica curativa: Reposo por enfermedad o accidente común y prórroga de medicina preventiva (Licencias Tipo 1 y 2). Se abreviará LMC.

Personal suplente: Corresponde a aquel asignado a un cargo que, por cualquier circunstancia, no es desempeñado por su titular durante un lapso no inferior a 15 días, siempre y cuando: El cargo no se encuentre vacante. El suplente no posea la titularidad de otro cargo en la institución.

Personal de reemplazo: Personal contratado para reemplazar a funcionarias/os a contrata que se encuentran imposibilitados para desempeñar sus cargos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 10º de la Ley de Presupuesto vigente. El personal suplente y de reemplazo deberán ajustarse a las causales de suplencia y reemplazos definidas por DIPRES. Perspectiva de género: “Los derechos humanos y la igualdad de género son elementos fundamentales para el desarrollo económico y social de los países”. Por dicha razón, se hace cada vez más necesario fomentar la inclusión de estos enfoques en acciones transversales en todos los niveles y campos de actuación. El enfoque de género “refiere a observar, analizar y promover transformaciones respecto de las desigualdades e inequidades en la condición, construcción de los roles y posición de hombres y mujeres en la sociedad”. Con la incorporación de esta perspectiva surge la necesidad de considerar el contexto del trabajo desde la justicia y equidad, para diseñar, implementar y evaluar intervenciones sin discriminación por razón de género y, promover la igualdad de oportunidades, fortaleciendo las capacidades y competencias de las mujeres, hombres y diversidades sexo genéricas en su conjunto.

En tanto, integrar la perspectiva de género (o mainstreaming) permitirá evaluar las diferentes implicancias que tiene para las mujeres, hombres y las personas con diversas identidades de género, las acciones planificadas en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Consideraciones Técnicas

Las metas de reducción tanto para los Servicios de Salud como EAR, se basan en las siguientes definiciones:

La meta 2026 se construye en base al Índice de Ausentismo 2025:

1. Con un IA de 19 o menos días, se debe disminuir o mantener el índice observado.
2. Con un IA mayor a 19 y menor o igual a 23 días, se debe disminuir 1 o más días.
3. Con un IA mayor a 23 días y menor o igual a 27 días, se debe disminuir 2 o más días.
4. Con un IA mayor a 27 días, se debe disminuir 3 o más días.

Considerar los siguientes documentos técnicos para el abordaje del ausentismo:

Ord. N°78 del 13.01.25 “Guía Práctica para el abordaje del ausentismo laboral por LMC en los Servicios de Salud”.

Ord. N°3353 del 31.12.24 “Envía orientaciones para la aplicación del Artículo 151 de la Ley 18.834”.

Ord. N°10149 del 25.05.25 remite “Criterios de Exclusión sugerido para la priorización de funcionarias y funcionarios con licencia médica superior a 180 días en el marco del Abordaje del Ausentismo Laboral”.

Consideraciones técnicas indicador índice de ausentismo laboral por licencia médica curativa:
A fines de febrero de 2026 se enviará la línea base y metas a cumplir por Servicio, tendientes a disminuir el Índice de Ausentismo, según cronograma.

17. Implementación de protocolos de atención nuevos o adaptación de aquellos vigentes en establecimientos de salud, incorporando criterios de pertinencia cultural en la APS.

Este indicador evalúa el grado de implementación de protocolos de atención, nuevos o adaptados con pertinencia cultural, en los establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS), como parte de la estrategia de transversalización de los cuidados interculturales impulsada en el marco del rediseño del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI).

Su finalidad es medir la capacidad institucional de los establecimientos de APS para integrar criterios de pertinencia cultural en la atención de salud de la población indígena conforme al Decreto 21.

ID CG-SRA 147	Implementación de protocolos de atención nuevos o adaptación de aquellos vigentes en establecimientos de salud, incorporando criterios de pertinencia cultural en la APS.				
DIVAP Departamento de Desarrollo e Integración en Atención Primaria					
Objetivo del Indicador	Asegurar una atención de salud con pertinencia cultural, mediante la implementación progresiva de protocolos de atención nuevos o adaptados en la atención de salud y en coherencia con el Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria (MAIS).				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de establecimientos de APS con protocolos de atención nuevos o adaptados con pertinencia cultural implementados / Número total de establecimientos de APS programados) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100%				
Exclusiones	No hay				
Fuente Numerador	LOCAL		Fuente Denominador	LOCAL	

Definición de Términos

Modelo de Salud Intercultural: Forma en que se diseña, organiza, implementa, evalúa y actualiza la gestión y atención de salud realizada por los equipos de salud de un establecimiento, de manera conjunta y coordinada con los pueblos indígenas, respetando la pertinencia cultural en la atención de salud.

Protocolo de Atención en Salud: Instrumento técnico-operativo que establece instrucciones sistemáticas para el manejo de un problema de salud específico en un contexto determinado, incluyendo criterios clínicos, roles, flujos de atención, registros y mecanismos de seguimiento. Tiene carácter referencial, salvo resolución contraria que disponga su obligatoriedad, y su propósito es estandarizar los procesos asistenciales para asegurar la calidad, seguridad y continuidad de la atención sanitaria.

Transversalización de los Cuidados: Se comprende como el proceso mediante el cual los cuidados integrales, continuos, equitativos y culturalmente pertinentes se instalan como eje articulador de la atención en salud en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque familiar y comunitario (MAIS). Operativamente, implica la adaptación de protocolos de atención, con pertinencia cultural, elaborados de manera participativa entre los equipos de salud, los terapeutas indígenas y los representantes de los pueblos indígenas, en coherencia con los contextos socioculturales y territoriales.

Población a cargo: Conjunto de personas beneficiarias, inscritas o adscritas a un establecimiento de salud, sobre cuya salud, dicho centro asume la responsabilidad de brindar y coordinar servicios integrales de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento. Esta población se organiza y sectoriza geográficamente con el propósito de favorecer la continuidad de los cuidados y fortalecer el vínculo entre los usuarios, sus familias y el equipo de salud, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque Familiar y Comunitaria.

Pertinencia cultural: La relación respetuosa y horizontal entre los equipos de salud y las personas, familias y comunidades pertenecientes a pueblos indígenas en el proceso de atención de salud, con comprensión de la cosmovisión de los pueblos indígenas, el reconocimiento de su cultura, filosofía de vida, conceptos de salud-enfermedad y sistemas de sanación propios.

Consideraciones Técnicas

La implementación de protocolos nuevos o adaptados con pertinencia cultural se estructura en tres fases secuenciales:

Fase 1. Diagnóstico y diseño participativo.

- Conformación de mesas técnicas interculturales con participación de referentes comunitarios, pueblos indígenas y equipos APS. Se recomienda incluir a la o el profesional responsable del área de calidad por la experiencia que tienen en estos procesos.
- Elaboración del borrador del protocolo de atención nuevo o adaptado con pertinencia cultural, definiendo principios, ámbitos de aplicación y responsabilidades.

Fase 2. Validación técnica y cultural

- Evaluación del protocolo nuevo o adaptado, por parte de los Servicios de Salud y representantes de comunidades indígenas locales.
- Ajustes de contenido según lineamientos técnicos del PESPI, el MAIS y las orientaciones del nivel central.
- Emisión del acto administrativo formal que aprueba el protocolo.

Fase 3. Implementación y seguimiento

- Capacitación a equipos de atención primaria de salud sobre la aplicación del protocolo nuevo o adaptado con pertinencia cultural.
- Incorporación del protocolo de atención nuevo o adaptado, en los procedimientos de atención, registros clínicos y estrategias de participación comunitaria.
- Monitoreo periódico de avances, identificando buenas prácticas, brechas y recomendaciones para el fortalecimiento de sistema de registro.

Cada Servicio de salud deberá reportar a través de una planilla Excel con formato MINSAL, los protocolos nuevos o adaptados de forma semestral, 10 días hábiles luego de la fecha de corte, en la plataforma definida de Control de Gestión de la Subsecretaría de Redes para informar los medios de verificación.

Igualmente deberán subir en dicha plataforma, la copia del protocolo de atención nuevo o actualizado, aprobado mediante un acto administrativo, y ser enviado también al correo electrónico del referente técnico MINSAL, encargado del programa.

18. Implementación de Modelos de Salud Intercultural en Hospitales y Servicios de Salud.

Este indicador mide el grado de instalación de los Modelos de Salud Intercultural en Servicios de Salud y Hospitales, conforme al Decreto ley 21/2023. Mide el porcentaje de indicadores de instalación cumplidos en ambos niveles, en el marco de un COMGES de continuidad para el 2026, ya que se debe cumplir la instalación de los indicadores en el 100% de los hospitales de 1 nivel, 2 nivel y 3 nivel.

ID CG-SRA 33	Implementación de Modelos de Salud Intercultural en Hospitales y Servicios de Salud.				
DIGERA Departamento de Gestión Territorial					
Objetivo del Indicador	Medir el grado de cumplimiento de la instalación de los Modelos de Salud Intercultural en Hospitales y Servicios de Salud, en el marco de los estándares definidos en el Decreto 21 de 2023 de MINSAL.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de indicadores de instalación MSI de Servicio de Salud cumplidos + Número de indicadores de instalación MSI de hospitales cumplidos / Número total de indicadores de instalación de los Modelos de Salud Intercultural) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	2 Decimal Aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	Cumplir con el 100% de indicadores de instalación de Modelos de Salud Intercultural de Hospitales y Servicio de Salud.				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	LOCAL		Fuente Denominador	LOCAL	

Definición de Términos

Pueblos indígenas: Aquellos que el Estado reconoce como descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra y su modo colectivo de vida el fundamento principal de su existencia y cultura, y que se encuentran enumerados en el artículo 1º de la ley Nº 19.253.

Modelo de salud intercultural: Forma en que se diseña, organiza, implementa, evalúa y actualiza la gestión y atención de salud realizada por los equipos de salud de un establecimiento, de manera conjunta y coordinada con los pueblos indígenas, respetando la pertinencia cultural en la atención de salud y en base a mecanismos institucionalizados de participación. Contempla adecuaciones técnicas y organizacionales para que los prestadores institucionales públicos atiendan con pertinencia cultural a los pueblos indígenas en forma coherente con sus contextos culturales, epidemiológicos, geográficos, demográficos y sociales, considerando la diversidad existente entre aquellos. Para hacer tangible la atención de salud con pertinencia cultural, los prestadores y los pueblos indígenas a través de sus representantes, elaborarán procedimientos, protocolos, instrumentos, herramientas y estrategias institucionales para responder a sus necesidades de salud.

Indicadores de instalación: Se trata de 9 indicadores de proceso y estructura descritos en la Norma Técnica de Modelos de Salud Intercultural del MINSAL, cuya implementación conduce al progresivo cumplimiento del Decreto 21 de 2023. Se trata de 3 indicadores a ser ejecutados a nivel de Servicio de Salud y 6 indicadores a nivel de establecimientos de la red.

Consideraciones Técnicas

El porcentaje de instalación del Modelo de Salud Intercultural (MSI) se calcula con la fórmula:

$$(\text{Número de indicadores MSI cumplidos en Servicios de Salud} + \text{Número de indicadores MSI cumplidos en hospitales}) / \text{Número total de indicadores definidos en la Norma Técnica MSI} \times 100.$$

El indicador se basa en los 9 indicadores de instalación vinculados al Decreto 21/2023, los cuales exigen evidencia formal para su verificación, incluyendo resoluciones, protocolos, actas de participación indígena, instrumentos de gestión intercultural y registros administrativos. Según el Decreto 140, Art. 8 letra e), los Servicios de Salud con alta concentración indígena deben programar, ejecutar y evaluar, junto a representantes de comunidades indígenas, estrategias, planes y actividades que incorporen el enfoque intercultural en el modelo de atención y en los programas de salud, lo que fundamenta la obligatoriedad de implementar los indicadores del MSI. Los referentes interculturales de los Servicios deben supervisar el avance, calidad del registro y cierre de brechas, consolidando la información en el Plan Anual de Implementación del MSI. DIGERA y DIPOL realizan acompañamiento técnico, revisiones documentales y monitoreo virtual y en terreno para validar el cumplimiento. La meta se fija en 100%, considerando que el diagnóstico inicial arrojó un 47% de cumplimiento en hospitales priorizados y que la normativa establece instalación total al 30 de diciembre de 2026. El MINSAL avanza en la actualización y estandarización de fuentes oficiales de información para asegurar la medición nacional del indicador.

Responsable del envío: referentes de salud intercultural SS.

A quien va dirigido: Equipo DIGERA-DIPOL.

Envío 30 de Junio (Resolución exenta de la conformación del equipo, validada por el Gestor de Red y cargada a carpeta compartida COMGES, Anexo N°1: Plan Anual de implementación de MSI, validado por la o el Director de Servicio y cargada a carpeta compartida COMGES).

Envío 30 de Septiembre (Anexo N°2 Informe estado de avance del Plan Anual de implementación de MSI)

Envío 31 de Diciembre (Anexo N°3: Informe final del Plan Anual de implementación de MSI)

19. Plan de acción de Plataforma “Sistema Integral de Atención a Personas SIAP – OIRS”.

Este indicador mide el cumplimiento de etapas establecidas para la elaboración de planes de acción de los Servicios de Salud que contengan estrategias para la implementación de la plataforma “Sistema Integral de Atención a Personas SIAP – OIRS” en su Red Asistencial, según los lineamientos del Departamento de Participación Social y Gestión Usuaria del Gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

ID CG-SRA 172	Plan de acción de Plataforma “Sistema Integral de Atención a Personas SIAP – OIRS”				
GABINETE SRA Departamento Participación Social y Gestión Usuaria					
Objetivo del Indicador	Medir el cumplimiento de las etapas para la elaboración de Plan de acción de los Servicios de Salud que contenga las estrategias para la implementación de la plataforma “Sistema Integral de Atención a Personas SIAP – OIRS” de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento de Participación Social y Gestión Usuaria del Gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de etapas cumplidas en la elaboración del plan de acción para la implementación de la plataforma “Sistema Integral de Atención a Personas SIAP – OIRS” / Total de etapas establecidas para la elaboración del plan) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	100% de las etapas cumplidas (3/3).				
Nivel de Aplicación	Todos los Establecimientos de la red de los Servicios de Salud.				
Exclusiones	Este Indicador no tiene exclusiones				
Fuente Numerador	LOCAL		Fuente Denominador	Datos con Validación de Nivel Central	

Definición de Términos

El Sistema Integral de Atención a Personas SIAP- OIRS es un sistema que permite la recepción, gestión y registro de solicitudes de la población usuaria de las redes asistenciales y servicios de salud, su resolución y respuesta considerando los marcos normativos vigentes basados en las leyes que garantizan derechos y deberes de las personas en salud y se sostiene en una plataforma que permite trazabilidad y gestión de la información.

Consideraciones Técnicas

Etapas de cumplimiento.

1. Conformación de equipo de soporte técnico y tecnológico constituido por encargados o integrantes de los Departamentos o Unidades de Participación Social y Gestión Usuaria, OIRS

y TICS de los servicios de salud, reportado mediante correo electrónico dirigido a jefatura del Departamento de Participación Social y Gestión Usuaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales hasta el 30 junio 2026.

2. Elaboración de diagnóstico acerca de la red de OIRS del Servicio de Salud para la implementación de la Plataforma “Sistema Integral de Atención a Personas SIAP – OIRS” según lineamientos definidos por el Departamento de Participación Social y Gestión Usuaria del Gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Informe: Diagnóstico Situación OIRS - 31 de julio de 2026.

3. Elaboración de informes del Plan de acción para la implementación de la plataforma “Sistema Integral de Atención a Personas SIAP OIRS”:

- a. Informe N°1: Informe de avance de elaboración de Plan. Entrega 30 septiembre de 2026.
- b. Informe N°2: Informe final con plan definitivo. Entrega 31 de diciembre de 2026.

Se dará por cumplido este indicador en la medida que el Servicio de Salud dé cuenta de todas las etapas establecidas en el indicador señalados en la sección "Condiciones habilitantes" y OOTT emanadas desde el MINSAL. El Departamento de Participación Social y Gestión Usuaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales proveerá las Orientaciones Técnicas y de los formatos de informe para reportar el indicador.

20. Consultorías y teleconsultorías de Salud Mental en Establecimientos de Atención Primaria.

Este indicador compuesto mide el cumplimiento de las consultorías y teleconsultorías de salud mental infante adolescente y de adultos/as programadas en los establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS), como parte del fortalecimiento de la capacidad resolutive local y la implementación del cuidado integral.

ID CG-SRA 47	Consultorías y teleconsultorías de Salud Mental en Establecimientos de Atención Primaria.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Asegurar que los establecimientos de Atención Primaria reciban consultorías de Salud Mental infanto adolescente y adultos/as.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	$((a / b) \times 0,5) + ((c / d) \times 0,5) \times 100$ Donde: a) Número de consultorías infanto adolescentes recibidas b) Número de consultorías infanto adolescentes programadas c) Número de consultorías adultos/as recibidas d) Número de consultorías adultos/as programadas				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	83%				
Exclusiones	Este indicador no tiene exclusiones.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	LOCAL	

Definición de Términos

Componentes de la fórmula: a) Número de consultorías infante adolescentes recibidas b) Número de consultorías infante adolescentes programadas c) número de consultorías adultos/as recibidas d) número de consultorías adultos/as programadas

Conceptos Consultoría: Se define como la actividad conjunta y de colaboración permanente entre el equipo de especialidad en salud mental y el equipo de salud general del nivel primario, que tiene como propósito potenciar la capacidad resolutive del nivel primario, mejorar la referencia y contra referencia de personas entre ambos niveles de atención y garantizar la continuidad de cuidados de la población usuaria con problemas de salud o trastornos mentales. La Consultoría constituye un recurso de formación y una instancia de coordinación, diálogo, definición de roles y responsabilidades compartidas, entre el nivel primario de atención y el nivel de especialidad en salud mental.

Consideraciones Técnicas

Se espera que cada establecimiento realice 12 consultorías anuales para población infanto adolescente y 12 para adultos/as, con un cumplimiento de 83% en cada componente. Ambos subcomponentes tienen un peso del 50% en el cálculo final, de modo que solo se logra el 100% al cumplir ambos grupos.

Adaptación local: en casos justificados, los Servicios de Salud podrán ajustar la cantidad de consultorías programadas por grupo según características del territorio y necesidades detectadas, resguardando la proporcionalidad y la cobertura de ambos componentes.

Los Servicios de Salud deben enviar la programación de consultorías adultos/as e infanto adolescente hasta el 30 de marzo de 2026

21. Intervenciones psicosociales grupales realizadas a personas en tratamiento por Salud Mental.

Este indicador refleja el comportamiento de la proporción de intervenciones psicosociales grupales como parte del tratamiento de salud mental de APS en relación al total de controles de tratamiento de salud mental de APS (controles individuales y grupales).

ID CG-SRA 46	Intervenciones psicosociales grupales realizadas a personas en tratamiento por Salud Mental.				
DIVAP Departamento de Cuidados Integrales en Salud					
Objetivo del Indicador	Aumentar la proporción de intervenciones psicosociales grupales, en relación al total de controles realizados (individuales y grupales) a personas en tratamiento por Salud Mental en la APS.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Número de intervenciones psicosociales grupales realizadas a personas en tratamiento por Salud Mental/Número de controles de salud mental realizados a personas en tratamiento por salud mental (grupales e individuales)) x 100				
Cuenta con Línea Base	Sí	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Semestral
Número de Decimales	1 Decimal aproximado			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	20% de aumento de la proporción de intervenciones psicosociales grupales, en relación al total de controles realizados (individuales y grupales) a personas en tratamiento por Salud Mental en la APS, respecto del cumplimiento del año anterior.				
Exclusiones	No aplica para Postas de Salud Rural ni CECOSF; sin embargo si algún Servicio de Salud estima incorporar dichos establecimientos, debe señalarlo a MINSAL hasta el 30 de marzo.				
Fuente Numerador	REM		Fuente Denominador	REM	

Definición de Términos

Intervención psicosocial grupal: es un control de salud mental que consiste en una intervención grupal realizada en el contexto de la atención integral de personas que ingresan a tratamiento por algún condicionante de la salud mental, factor de riesgo y/o trastornos mentales.

Control de salud mental: es la intervención individual realizada por profesionales, técnicos y/o gestores comunitarios del equipo de sector, con formación en salud mental.

Consideraciones Técnicas

Las intervenciones psicosociales grupales son intervenciones que se otorgan en el contexto de los tratamientos de salud mental de Atención Primaria, las cuales han ido en aumento en los últimos años en nuestro país. Se requiere un aumento de la proporción de este tipo de intervenciones en relación con el total de controles de salud mental que se otorgan en APS.

Se debe considerar un aumento del 20% de esta proporción que incorpore un aumento paulatino de estas actividades.

22. Procesos clínicos que cumplen con la evaluación de concordancia SIDRA-REM de las atenciones médicas de los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia.

Este indicador busca que exista una concordancia de un 98% entre los Registros Clínicos Electrónicos (RCE) de cada proceso y establecimiento comprometido por los Servicios de Salud respecto a lo informado a DEIS para esos mismos procesos y establecimientos a través de los REM.

ID CG-SRA 48	Procesos clínicos que cumplen con la evaluación de concordancia SIDRA-REM de las atenciones médicas de los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia.				
GABINETE MINISTRO(A) Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones					
Objetivo del Indicador	Fortalecer la estrategia SIDRA mediante equipos interdisciplinarios que impulsen la implementación y uso de los sistemas de RCE en los establecimientos de salud, asegurando la calidad y completitud de los registros a través de procesos de validación de datos.				
Responsable de gestión	Dirección de Servicio de Salud				
Fórmula de Cálculo	(Total de procesos clínicos que cumplen umbral del >= 98,0% de concordancia / Total de procesos clínicos evaluados) x 100				
Cuenta con Línea Base	No	Unidad de Medida	Porcentaje	Periodicidad de Monitoreo	Trimestral
Número de Decimales	Entero sin decimales			Polaridad	Los Valores altos son Buenos
Meta	98% concordancia de los procesos clínicos (SIDRA – REM)				
Exclusiones	Se excluyen los establecimientos que no generan SIC para CNE al ámbito electivo y/o que no cuenten con registro clínico electrónico (o no tengan contrato vigente con su proveedor) o no tengan conectividad a internet.				
Fuente Numerador	LOCAL		Fuente Denominador	REM	

Definición de Términos

Estrategia SIDRA: Sistema de Información de la Red Asistencial.

REM: Resúmenes Estadísticos Mensuales Concordancia.

SIDRA- REM: comparación entre los registros clínicos electrónicos (RCE) informados por el Servicio de Salud para un determinado establecimiento y proceso con lo informado por DEIS a través de REM.

RCE: Registro Clínico Electrónico.

TIC: Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

SS: Servicio de Salud

Consideraciones Técnicas

El envío y/o actualización fuera de plazo de cualquiera de los verificadores implica el no cumplimiento de la meta.

Los medios de verificación que se envíen incompletos no serán considerados en la evaluación.

La Información asociada al REM será entregada directamente por DEIS MINSAL a TIC MINSAL.

Formarán parte del universo de establecimientos a considerar aquellos informados en producción durante el año 2024.

Aquellos establecimientos que se encuentren en proceso de puesta en marcha de su implementación sólo serán monitoreados. El Servicio de Salud deberá informar al referente MINSAL la fecha de entrada en producción para su consideración en la evaluación.

Toda solicitud de modificación a considerar en las evaluaciones deberá ser solicitada por medio oficial, a través de ordinario con fecha anterior a la evaluación del corte, especificando establecimiento, proceso y justificación de la no evaluación.

7. Nivel de aplicación

Indicador	ID CG-SRA	Nombre	Nivel de aplicación
1.1	30	Suspensiones quirúrgicas en cirugías mayores electivas	Nacional a todos los hospitales de alta y mediana complejidad con quirófanos electivos.
1.2	85	Derivaciones en APS al nivel secundario respecto a las consultas totales	Establecimientos de Atención primaria de salud de administración municipal y dependientes de servicios de salud, incluidos Hospitales comunitarios con APS
1.3	21	Cumplimiento de la tasa de donación de sangre	Todos los establecimientos de la red asistencial que cuentan con un sitio fijo intrahospitalario de atención de donantes de sangre o que cuentan con una casa del donante de sangre o que realizan actividades de colecta móvil de sangre.
1.4	9	Cumplimiento del proceso de acreditación en la etapa de ingreso de los establecimientos de Salud	Cada Servicio de Salud debe comprometer la cantidad de establecimientos de salud de atención primaria; específicamente CESFAM, CGR y CGU con sus diversas dependencias (postas rurales, otros).
2.1	41	Ingresos a la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP) de personas de 65 años o más	El indicador medirá Ingresos a Estrategia de Cuidado Integral y Planes de Cuidado, en todos los establecimientos de APS (postas, Cecosf, CESFAM, CGU, CGR y Hospitales Comunitarios)
2.2	15	Tasa de donantes efectivos en muerte encefálica por millón de población (PMP) generados por Servicio de Salud	Establecimientos de mediana y alta complejidad
3.1	78	Cumplimiento de Garantías Explícitas en Salud (GES) en la red	Toda la Red Asistencial.
3.2	81	Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad médica	Servicio de Salud, incluye todos los establecimientos de su red que presenten lista de espera al corte.
3.3	82	Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de consulta nueva de especialidad odontológica	Servicio de Salud, incluye todos los establecimientos de su red que presenten lista de espera al corte.

3.4	83	Monitoreo del percentil 75 de la lista de espera de intervenciones quirúrgicas mayores y menores	Establecimientos que cuentan con la cartera de servicio. Aplica para todos los establecimientos de la red que presenten LE de Intervenciones Quirúrgicas mayores y menores al cierre del año 2025 con el criterio de antigüedad del indicador
3.5	52	Resolución de Lista de espera de consultas nuevas de especialidades médicas con destino APS en especialidades definidas	Establecimientos de Atención Primaria de Salud, tanto de administración municipal y dependientes de servicios.
3.6	53	Resolución de Lista de espera de especialidades odontológicas de endodoncia, prótesis removible y periodoncia en atención primaria de salud	APS municipal, APS dependiente SS, posta rural con APS y Hospital Comunitario que reciba financiamiento vía PRAPS.
3.7	56	Resolución de Lista de espera de intervenciones quirúrgicas menores electivas en atención primaria de salud	Establecimientos de Atención Primaria de administración municipal y dependientes de Servicios de Salud
4.1	153	Ejecución de actividades al proceso de planificación, ejecución y monitoreo presupuestario	Servicios de Salud
4.2	50	Implementación del plan gestión del riesgo de desastres	29 servicios de Salud
4.3	35	Índice del gasto en convenio con personas naturales respecto a la glosa autorizada vigente	Aplica a todos los establecimientos de los SERVICIOS DE SALUD
5.1	18	Nivel de cumplimiento efectivo de garantías GES en problemas de salud oncológicos	Toda la Red Asistencial.
5.2	22	Casos oncológicos No GES en lista de espera quirúrgica con espera menor a 90 días	Hospitales de alta y mediana complejidad.
5.3	38	Cobertura de tamizaje para cáncer cervicouterino en establecimientos de APS municipales y dependientes de Servicio de Salud	Establecimientos de atención primaria, municipales y dependientes de servicios de salud más DFL 36.
5.4	59	Cobertura efectiva de vacuna contra el VPH de NNA que cursan cuarto año básico con dosis novalente	Aplica para establecimientos de salud que cuentan con unidad de vacunatorio, es decir, establecimientos de APS municipales y dependientes, además de Hospitales.

6.1	44	Nivel de implementación de estrategias y/o células de Hospital Digital en establecimientos del Servicio de Salud	Aplica a establecimientos de los niveles de baja, media y alta complejidad
6.2	138	Plan de Ciberseguridad conforme a Ley 21.663	Servicios de Salud y Hospitales de Alta Complejidad
6.3	145	Implementación de Estrategia Tiempos De Espera Interoperable	Todos los establecimientos de salud de nivel primario que generan solicitudes de interconsulta (SIC) para consulta nueva de especialidad (CNE).

Autores

Departamento de Control de Gestión Subsecretaría Redes Asistenciales

- Lucía Astorga Inostroza
- Sebastián Cid Alvarado
- Andrea Cocio Salas
- Héctor Henríquez Serey
- Alejandro Gómez Muñoz

Colaboradores

Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastre

- Carlos del Real Barrenechea
- Renato Calcagno Soto

División de Gestión de la Red Asistencial

- Felipe Ardiles Martinez
- Marco Olea Rojas

División de Atención Primaria

- Laura Morlans Huaquin

División de Gestión y Desarrollo de Personas

- Andrea Farías Caicedo

División de Inversiones

- Macarena Castro Bruguera

División de Presupuesto

- Marco Vásquez Zúñiga

Departamento de Salud Digital

- Carolina Cunill Leppe
- Jorge Neira Oyarzo

Departamento de Tecnología de Información

- José Villa Catalan

Departamento de Planificación Sanitaria

- Odette Urrutia Pumeyrau

Departamento de Control de Gestión

Subsecretaría de Redes Asistenciales

Ministerio de Salud de Chile

2026

comges@minsal.cl